

terapia familiar

ESTRUCTURA, PATOLOGÍA Y
TERAPEUTICA DEL GRUPO FAMILIAR

I

JORGE GARCIA BADARACCO

La familia como contexto real de todo proceso terapéutico

ISIDORO BERENSTEIN

Objetivos y metas de la terapia familiar

E. G. DEBBANE

Psiquiatría del grupo familiar: una perspectiva

JUAN CARLOS NOCETTI

La organización de las relaciones familiares

GERALD H. ZUK

Terapia familiar: ¿collage clínico o ciencia clínica?

CARLOS E. SUZUKI

Un ambiente para pensar interaccionalmente

LOREN R. MOSIER

Influencias de los estudios de la familia
para el tratamiento de la esquizofrenia

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica
del grupo familiar.

Año 1. Nº 1. Marzo de 1978.

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Comité de Redacción

Lic. Stella Maris Molina
Dr. Rafael Skiadaressis
Dr. Jorge Presta

Consejo de Redacción

Jorge García Badaracco (Buenos Aires)
Isidoro Berenstein (Bs. As. - Tel Aviv)
Juan C. Nocetti (Buenos Aires)
Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)
Gerald Zuk (Filadelfia)
Alberto Serrano (Bs.As. - San Antonio, Texas)
Jacques Rudrauf (Paris)
Helm Stierlin (Heidelberg)
Maurizio Andolfi (Roma)

Gerente Comercial

Alberto Cattari

Asesor Editorial

Alfredo Carlino

Proyectó

la edición

Guillermo Cicerchia

TERAPIA FAMILIAR es una publicación cuatrimestral de Editorial ACE S.R.L. (ef). Alberti 1362, Buenos Aires, Argentina. Publicada simultáneamente en castellano e inglés. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción o uso de todo o parte del contenido de esta publicación, tanto en español, como en cualquier otro idioma. Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Nombre de la Revista registrado como marca. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 1382769. Fotocomposición, armado e impresión: S.A. The Buenos Aires Herald - Azopardo 455, Capital Federal. Impreso en la Argentina. Printed in Argentine.

Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión de la revista.

INDICE

JORGE GARCIA BADARACCO	9
<i>La Familia como contexto real de todo proceso terapéutico</i>	
ISIDORO BERENSTEIN	17
<i>Objetivos y metas de la terapia familiar</i>	
E.G. DEBBANE	21
<i>Psiquiatría del grupo familiar: una perspectiva</i>	
JUAN CARLOS NOCETTI	33
<i>La organización de las relaciones familiares</i>	
CARLOS E. SLUZZKI	39
<i>Entrenamiento para pensar interaccionalmente</i>	
GERALD H. ZUK	43
<i>Terapia familiar: ¿"collage" clínico o ciencia clínica?</i>	
LOREN R. MOSHER	49
<i>Implicancias de los estudios de la familia para el tratamiento de la esquizofrenia.</i>	
Libros	65
Simposium	79
Congresos	81

TERAPIA FAMILIAR

Estructura, Patología y Terapéutica del grupo familiar

PRESENTACION

Editar una revista científica sobre un tema determinado, supone no sólo encuadrar un objeto de estudio específico y propio, ayudar a construir y consolidar un cuerpo de teoría o discurrir sobre su mediatización técnica, sino también la búsqueda de un interlocutor, un Otro significativo que dé sentido a ese esfuerzo. Esta relación dialéctica será el aliciente que nos permita, día a día, crear un espacio sobre el cuál converjan distintas disciplinas integradas de una manera enriquecedora.

Si bien nuestra inquietud surge de un campo bien determinado, como su título lo indica, nos sucede como al patólogo, que cuanto más conoce y comprende lo enfermo, más va descubriendo y valorando lo sano, como una oposición dinámica implícita que estructura su tarea. Por eso, nuestras metas son más ambiciosas, como el subtítulo lo indica, para lo cual se irán solicitando los aportes de antropólogos, sociólogos, historiadores y todos aquellos que nos ayuden a comprender, en el doble sentido de abarcar y de entender el objeto de nuestro estudio.

Durante mucho tiempo, la familia de los pacientes, se convirtió para los terapeutas en algo persecutorio, en parte por la identificación con ellos, en parte por la falta de una visión más totalizadora en la ciencia misma. En los últimos años se va haciendo más común pensar en términos de estructura, con una visión ecológica y sintetizadora de muchos fenómenos antes disociados para su mejor comprensión pero sin el esfuerzo de una re-integración posterior.

¡Cuánto tiempo y esfuerzo se ahorrarían, terapeuta y paciente, a veces empeñados en una pugna estéril por la realidad de sus afirmaciones, si consultaran, cuando fuera posible, con las fuentes de esos conflictos! Ya lo decía Freud: "No podemos despedir a los monstruos del Averno, sin antes haberlos convocado". Que la representación psíquica de los personajes del grupo familiar es distinta a la realidad de estas personas, se encargó el psicoanálisis de enseñarnoslo durante muchos años. En la terapia familiar nos permite hoy el psicoanálisis comprender cómo las fantasías "delirantes" de los pacientes tienen su correlato con hechos, pensamientos o fantasías inconscientes de sus familiares significativos, aún cuando sean anacrónicas. Este pedazo de "realidad" puede ser el pivote esencial sobre el que gire la curación de un paciente. Esto no significa que el terapeuta se aliene en el delirio de su paciente, sino que precisamente el esclarecimiento de esta realidad profunda quita sentido a la continuidad del delirio y permite adentrarse en aspectos más dolorosos y vergonzantemente ocultos, como son las carencias afectivas profundas en esas relaciones significativas. Dice Martin Buber: "A medida que voy convirtiéndome en Yo, digo Tú. Toda vida real es una reunión o encuentro". Este cambio en el enfoque requiere instrumentar esos encuentros para que yendo más allá de la confirmación de la realidad y de la delimitación de responsabilidades (no culpas) proporcionen el soporte necesario para la búsqueda de una mayor autonomía y de relaciones de objeto menos alienadas por las frustraciones de los desencuentros anteriores. Por eso es que pensamos que el psicoanálisis puede enriquecerse con estos aportes permitiendo trabajar con mucha más propiedad y efectividad en la persona del paciente y donde ya el analista deje de ser una mera pantalla de proyecciones distorsionadas y distorsionantes.

En la resolución de la transferencia no termina el psicoanálisis, sino que recién empieza como nueva dimensión en la que el analista pasa a convertirse en una persona real que acompaña y sufre con su paciente en el largo camino de la búsqueda de su identidad. De ahí nacen el cariño y el reconocimiento por ese compañero de ruta o el odio y la indiferencia por una nueva frustración.

Valorando la importancia de la complementariedad de los tratamientos individual y familiar y la función catalizadora que esta integración significa tanto para el individuo como para el grupo, insensiblemente vamos entrando en un terreno nuevo. El enfrentar los problemas en conjunto agrega a su redimensionamiento cualitativo, la posibilidad de levantar represiones sobre hechos o temas que como rompecabezas inconcluso ejercían su acción patógena. Se comienza a salir más fácilmente de una causalidad cronológico-lineal de los problemas para pasar a otra, circular que pone en evidencia el compromiso del conjunto. El síntoma individual pasa a perder su significado de cortina de humo y como "pars pro toto" adquiere un nuevo sentido a la luz de una patología compartida. Ahí la responsabilidad es grupal, por duelos no realizados, motor de esa patología y el dolor evitado y subyacente a las idealizaciones entra en escena.

El real sufrimiento a la manera de purificador cumple con la doble función de quitar el letargo de la enfermedad y de poner en juego mecanismos de solidaridad antes inhibidos o bloqueados. Se va pasando así de una regresión patológica centrada en los síntomas a una regresión sana centrada en las carencias.

Toda esa tarea adquiere entonces un sentido y las experiencias emocionales compartidas son la nutrición necesaria para ese esfuerzo.

Teóricamente el psicoanálisis, a pesar de ser en su esencia una antropología familiar, no es suficiente para dar cuenta de todos estos fenómenos. La noción de sistema y de estructura se hace imprescindible y se abre la puerta entonces a aportes que van surgiendo de la cibernética, de la lingüística, de la antropología estructural, de la sociología y de todas aquellas disciplinas que enriquecen el campo de estudio. Estos distintos ángulos de lectura de un mismo fenómeno, que los nuclea, el hecho clínico, hace imperiosa la necesidad de echar bases para una metodología epistemológicamente más precisa. De ahí que sin ocultar la inspiración psicoanalítica de nuestra posición, queremos contribuir con la publicación de trabajos de otras escuelas a la creación en el lector de un espacio ontológico nuevo que esté, quizás, más cercano a la realidad.

Si bien ambiciosas, nuestras metas, no por eso menos necesarias, constituyen a la vez una invitación formal a todos aquellos que quieran contribuir con sus esfuerzos. Para eso, nuestra revista tenderá a abrir las fronteras no sólo del conocimiento en sí, sino también, pragmáticamente, aquellas que nos separen de otros países, de otros autores. En un esfuerzo editorial, saldrá paralelamente una edición internacional en inglés, que facilite ese propósito.

Vaya por último, nuestro profundo agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible esta realización, tanto sea desde el plano afectivo y humano, como desde el científico y administrativo. Y finalmente, a manera de homenaje, queremos evocar a un gran ausente-presente, Enrique Pichón Riviere, pionero en nuestro país y maestro de varias generaciones. Que sus aspectos de vida y de creación puedan hallarse en estas páginas.

El Director

La familia

como contexto real de todo proceso terapéutico

Jorge E. García Badaracco*

Profesor Adjunto de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Bs. Aires.

La historia de la psicoterapia está más bien ligada a la idea de una técnica. Pero la experiencia clínica nos muestra que más allá de las diferentes técnicas a nuestro alcance es necesario poder visualizar el proceso psicoterapéutico. A semejanza del proceso de crecimiento y desarrollo normal dentro de la familia pensamos que todo proceso psicoterapéutico verdadero, cualquiera sea la técnica empleada como tratamiento, constituye una especie de redesarrollo en un contexto familiar real o virtual. En el presente trabajo vamos a tratar de desarrollar esta concepción, que elaborada de la experiencia clínica realizada principalmente con paciente psicóticos puede extenderse, a nuestro entender, a todo tipo de pacientes. En este sentido, más allá de la psicoterapia de la familia, como técnica de abordaje de la patología mental individual y grupal, pensamos que la familia constituye, de una u otra manera, el contexto real de toda experiencia psicoterapéutica y que directa o indirectamente, juega un papel fundamental en todo proceso psicoterapéutico.

La experiencia clínica nos ha ido llevando a la necesidad de diferenciar el concepto de tratamiento, entendido como técnica, del concepto de proceso terapéutico. Podemos decir que el tratamiento comprende todo lo que sucede en las sesiones desde el comienzo hasta el fin de los encuentros entre paciente y terapeuta. Por su parte el proceso terapéutico podría definirse como el conjunto de transformaciones que puede experimentar un individuo a través del tratamiento. Pueden existir entonces variados tratamientos en cuanto técnicas de abordaje o recursos terapéuticos pero el proceso terapéutico propiamente dicho constituye necesariamente una unidad que consiste en una sucesión de cambios que pueden presentarse o darse en realizaciones variadas pero que tienen una coherencia interna y un sentido progresivo de desarrollo hacia una condición humana de mayor integración de la personalidad y mayor madurez y equilibrio emocional.

* Clínica Psiquiátrica O'Higgins 2328, Buenos Aires, R. Argentina

La psicoterapia se ha estudiado, en general, como la relación paciente terapeuta y no se ha tomado suficientemente en cuenta el conjunto de condiciones, factores y circunstancias que rodean al enfermo (y a la relación terapéutica) entre los cuales encontramos fundamentalmente la familia y el medio social, lo que constituye lo que hemos llamado el contexto real (17) de la experiencia psicoterapéutica. Esta noción de contexto no debe confundirse con la de encuadre o "setting" del tratamiento que está constituido por el conjunto de reglas según las cuales se realiza este último. Muchos psicoanalistas postularon la necesidad de un setting estricto que excluía a la familia, como una forma de preservar la pureza de la experiencia terapéutica reservada a la relación bipersonal analista-analizado. Poco a poco se ha ido viendo que esta pureza es muchas veces una ficción que pretende mantener el analista. La realidad es que el paciente en análisis se encuentra incluido en una red de situaciones y factores actuales directa o indirectamente en el campo psicológico de la relación analítica.

Para los pacientes psicóticos en particular los factores externos son aún mucho más poderosos. En primer lugar la dependencia económica del paciente que raramente paga su tratamiento a causa de su incapacidad de tener ingresos propios. A esta dependencia económica se agregan otras formas de dependencia que responden a su condición patológica y están íntimamente ligadas a la misma, a través de la incapacidad y/o para manejarse frente a la realidad cotidiana. Entre las formas de dependencia, juega un papel importante la dependencia de la familia y en especial de algunos de sus miembros. A través de las relaciones de tipo simbiótico el paciente está atrapado en una red familiar. El tratamiento psicoanalítico, a través de la movilización afectiva de la relación transferencial y de los cambios psíquicos que promueve, produce modificaciones en los vínculos intrafamiliares y la forma de las relaciones objetales dentro de la familia, que generan una serie de reacciones y contrareacciones a través de las cuales se tiende a volver a su situación anterior en un mecanismo que podemos llamar homeostático. Estos mecanismos actúan sobre el individuo en análisis, en forma a veces poderosa. Freud señaló que era muy difícil trabajar analíticamente con un paciente cuando el campo está sometido a una serie de ataques semejantes a lo que sería para un cirujano el que se estuviera ensuciando desde afuera el campo operatorio. En forma similar, muchas veces una reacción terapéutica negativa está profundamente influenciada por un familiar que genera en el paciente un intenso sentimiento de culpa por una mejoría. Otras veces una recaída severa puede estar condicionada por una actitud rígida y castradora de un padre o una madre que no tolera el crecimiento de su hijo enfermo. Finalmente, muchas veces después de algún tiempo de tratamiento y precisamente cuando éste comienza a ser exitoso, la familia obliga al paciente a interrumpirlo bajo diferentes pretextos. También ocurre a menudo, que la familia corta el tratamiento del paciente cuando se produce una regresión severa que puede estar formando parte inseparable de un proceso terapéutico necesario, bajo la justificación de que el paciente está peor y que el tratamiento debe estar agravándolo y enloqueciéndolo, cuando en realidad se trata más bien de que no toleran el tipo de regresión que el paciente está haciendo y que por otra parte es necesaria para cambiar ciertas estructuras de base y poder curarse. En estos casos se ve claramente que hay un contexto de realidad de la experiencia psicoanalítica que no es solamente el setting del tratamiento sino que comprende también un conjunto de factores que constituyen una red alrededor del mismo que no puede dejar de tomarse en cuenta.

En cuanto a la psicoterapia entendida como técnica intentaremos hacer un poco de historia. En el siglo pasado encontramos la psiquiatría moral. En las últimas décadas del mismo, comienza a aplicarse la hipnosis. Freud desarrolla la técnica psicoanalítica haciendo hacer al paciente la asociación libre y va descubriendo los mecanismos que tienen lugar en la mente, entre los cuales, la existencia del inconsciente, la noción de conflicto y de defensa y de los cambios que pueden obtenerse a través de la transferencia y del insight. La técnica psicoanalítica se aplicó a las neurosis y luego se extendió a otros cuadros. Pero las

expectativas puestas en el psicoanálisis se vieron un tanto frustradas en muchos aspectos; no todos los pacientes se curaban, los pacientes psicóticos eran en gran medida inabundables por el psicoanálisis, los tratamientos se fueron haciendo cada vez más largos. Alrededor de la década del 30 comienzan los primeros esbozos de psicoterapia de grupo y de psicoterapia de familia. Luego fueron apareciendo diferentes formas de psicoterapia: existencial, de la conducta, terapia ocupacional, expresión corporal, musicoterapia, psicodrama, etc. En la década del 50, el descubrimiento de los psicofármacos trajo, entre otras cosas, un gran avance en las posibilidades de abordaje psicoterapéutico de pacientes psicóticos. Simultáneamente desde la dimensión social, se introduce la noción de socioterapia y la comunidad terapéutica, también como una nueva técnica de abordaje de la enfermedad mental. Si bien es cierto que la incorporación y desarrollo de nuevas técnicas fue enriqueciendo el bagaje de recursos terapéuticos y fue permitiendo el estudio de las mejores formas de abordar al paciente según su psicopatología, pensamos que, al mismo tiempo, se acentuó la tendencia a la configuración de compartimientos estancos, en el sentido de una especialización en variadas técnicas psicoterapéuticas que compiten en la obtención de buenos resultados, sin investigar suficientemente las causas de los fracasos.

Intentando estudiar las causas de los fracasos en las distintas formas de psicoterapia e investigar la posibilidad de hacer accesible a las mismas a los pacientes prácticamente inabundables, descubrimos que, en muchos casos, el fracaso no se explica por la condición psicopatológica en sí misma, sino que se debe a que las condiciones en que colocamos al enfermo no contemplan las verdaderas necesidades del mismo y que en esa situación se le hace imposible recorrer el camino de la cura. Puede tratarse de dificultades en la relación del paciente con su terapeuta o en otra dimensión podemos encontrar influencias negativas que rodean al paciente y que pueden ser tan importantes como para detener o paralizar el proceso terapéutico mismo.

En el campo de trabajo donde hemos realizado nuestra investigación en estos últimos 15 años, hemos tenido la oportunidad de integrar variados recursos terapéuticos, trabajar en equipo, asociar diferentes modalidades asistenciales y sobre todo rescatar los fracasos, es decir, hacer posible que éstos se transformen en éxitos a través de la revisión de los errores cometidos.

El poder ver al paciente simultánea y sistemáticamente en su vida cotidiana, en psicoanálisis individual, terapia grupal comunitaria, familiar nuclear y familiar múltiple, terapia ocupacional, expresión corporal, etc., constituye por una parte una red terapéutica para el paciente y por otra una red investigacional para los terapeutas que nos permitió hacer correlaciones significativas de todo tipo, técnicas, clínicas y teóricas. El enriquecimiento y la potenciación de la experiencia terapéutica nos dio la oportunidad de tener una visión pluridimensional de los fenómenos y nos permitió realizar múltiples experiencias comparadas. Dado que las experiencias terapéuticas son abordadas en gran medida en distintas formas de co-terapia con participación de diversos miembros del equipo terapéutico, la elaboración se hace también en una forma compartida con una objetividad mucho mayor por una adecuación recíproca de las interpretaciones.

Trabajando en este contexto se nos fue haciendo cada vez más evidente que la actitud de la psiquiatría clásica con su pesimismo condenatorio de la enfermedad mental como incurable es similar a la de la familia de estos enfermos que tampoco es capaz, en la mayoría de los casos, de hacerse cargo de las profundas angustias de estos pacientes como seres humanos inmaduros y necesitados de gran apoyo. El problema de la posibilidad de tratamiento y curación de estos enfermos se vincula entonces con el problema de quién se hace cargo de este ser que necesita crecer y recorrer un camino que no hizo en su momento y que está cargado de frustraciones y carencias, inseguridades y desconfianzas profundas y que por su experiencia personal ha llegado a una especie de convicción de que nada ni nadie lo puede sacar de su fracaso y que además, muy a menudo, no está dispuesto a ilusionarse nuevamente sin garantías adecuadas. Vistas las cosas de

esta manera se comprende mejor lo que poco a poco y a lo largo de los años hemos ido descubriendo y comprobando sistemáticamente: la existencia de una complicidad inconsciente entre los enfermos, los familiares, los médicos y las instituciones, en el sentido de dar por definitivamente establecida y demostrada la incurabilidad de la enfermedad.

Por el contrario, cuando se piensa en la enfermedad mental como detención o distorsión del desarrollo en el núcleo familiar y la posibilidad de curación a través de un proceso de redesarrollo, la comunidad terapéutica psicoanalítica revela ser el "continente" más válido para el paciente psicótico (en particular el esquizofrénico), porque provee las condiciones más adecuadas para que pueda darse un proceso terapéutico en el paciente, que requerirá que la familia pueda acompañarlo en su redesarrollo, capacitándose para hacer ahora lo que no supo o no pudo hacer en su momento. La familia entonces tendrá que aprender a tolerar las regresiones y favorecer las progresiones y esto implica que sus miembros también tendrán que realizar a su vez un proceso terapéutico de redesarrollo. Cada uno como individuo y la familia como un todo tendrá que descubrir y desarrollar relaciones interpersonales más maduras.

Diferentes y variadas son las maneras en que la familia y la estructura familiar están presente permanentemente en nuestro trabajo psicoanalítico en comunidad terapéutica. En primer lugar, las familias forman parte de la comunidad en la medida en que cada paciente llega a la misma con su familia dentro de él, es decir que, dentro de la estructura de su personalidad existen identificaciones y objetos internos representantes de sus familiares y relaciones de objeto representantes de sus relaciones infantiles con esos familiares. En el funcionamiento de la comunidad rápidamente estos objetos internos encuentran personajes reales externos donde materializarse, de tal manera que los médicos, las enfermeras, otros pacientes u otros familiares, pueden representar figuras o parejas parentales, hermanos, hijos, etc. De esta manera, en la comunidad el paciente vive en forma transferencial los conflictos internos infantiles que no ha podido elaborar, encontrando en la misma una oportunidad para hacerlo. Estas situaciones son extensamente utilizadas para mostrar e interpretar cómo muchos conflictos que se viven en la comunidad representan claramente la repetición o reproducción de conflictos internos o conflictos familiares y constituyen oportunidades y materiales valiosos para la elaboración de estos conflictos y para la superación de las carencias. Los pacientes psicóticos, en particular, realizan identificaciones proyectivas con suma rapidez y actúan psicopáticamente en la relación interpersonal, conflictos con objetos internos y es trabajando interpretativamente estas conductas externas que pueden elaborarse estos conflictos con los objetos internos. En otro sentido, el paciente mantiene con sus familiares relaciones enfermas en roles complementarios, ya sea porque el paciente es, de una manera u otra, un emergente de la estructura familiar enferma, ya sea porque, de alguna forma, eligió un partenaire enfermo para depositar parte de su propia enfermedad en él.

Lo más difícil para los familiares es tolerar que el paciente esté a mitad de camino en su proceso terapéutico y poder hacerse cargo en parte de ciertos aspectos todavía no resueltos, colaborando en el tratamiento con la tolerancia necesaria hasta que el enfermo pueda afianzarse definitivamente. Para conseguir esto nuestra experiencia nos ha mostrado que es necesario hacer participar a la familia en el proceso terapéutico que está haciendo el enfermo, lo cual, en cierto modo, hace que aparezcan también en los familiares las partes enfermas de cada uno y que tomen conciencia de que también ellos generalmente necesitan de una manera u otra, tratamiento. Quizá lo más importante en todo este proceso es el desarrollo de un insight familiar y de una capacidad de tolerar la angustia y acompañar alternativamente al miembro más necesitado. En estas condiciones se hace posible mantener una mejor actitud ante las diferentes vicisitudes del tratamiento, incluidas las recaídas, sin verlas necesariamente como fracasos terapéuticos, sino como formas y cambios dentro del proceso de la cura. Como ensayos y errores a través de los cuales el paciente adquiere

estabilidad y seguridad interiores. Muy a menudo los familiares están poniendo a prueba la posibilidad futura de tratamiento y curación para ellos mismos a través del tratamiento del enfermo. Secretamente miden la capacidad del médico para manejar situaciones difíciles, para tolerar la angustia, su seguridad en el éxito, etc. En estas condiciones el médico o el equipo terapéutico tiene que poder hacerse cargo potencialmente de toda la familia.

La participación de los familiares en la Comunidad terapéutica se puede hacer de diferentes maneras. Hemos hecho experiencias con reuniones de la familia nuclear de cada paciente, sin la presencia de este último y con el paciente incluido. Hemos reunido a todos los familiares de los pacientes de la comunidad en un grupo para la discusión y elaboración de problemas comunes. Hemos incluido familias en las reuniones diarias de Comunidad Terapéutica de los pacientes y hemos hecho grandes grupos de pacientes y familiares, formando una gran reunión de comunidad que llamamos grupo familiar múltiple. Todo este enfoque incluye concebir a la Comunidad Terapéutica Psicoanalítica como un campo psicológico de estructura multi-familiar y al proceso terapéutico como un conjunto de cambios que se dan en el individuo, en sus familiares y en el grupo familiar como totalidad, en el sentido de una mayor maduración personal de cada uno de ellos, una mayor individuación y personalización de sus miembros dentro del grupo y, como consecuencia, un logro de relaciones interpersonales más adecuadas entre los mismos.

Si consideramos la comunidad como contexto de la experiencia terapéutica, podemos decir que ella se comporta como una familia sustitutiva que puede constituir un "continente" válido para hacerse cargo de los componentes más psicóticos de los pacientes o de los momentos más regresivos de los mismos. En este sentido, el paciente puede, en el clima de seguridad emocional que le da la institución, expresar los contenidos más enfermos de su personalidad y, a través de una regresión operativa, desarrollar los aspectos "infantiles sanos" que no pudieron integrarse durante su desarrollo dentro de su núcleo familiar. El desarrollo incluye la necesidad de recuperar la espontaneidad y la capacidad de jugar, el desarrollo de un Yo verdadero y el logro de una identidad propia, haciendo un proceso de desimbiotización que generalmente es sumamente doloroso. La familia tiene que aprender a tolerar la regresión, participar en el proceso de desimbiotización y favorecer la individuación. Muchas veces la familia se convierte en el "paciente", o distintos miembros de la misma requieren a su vez atención especial. La Comunidad, como una familia sustitutiva puede comportarse de una manera más adecuada que la familia real, permitiendo una serie de experiencias de desarrollo que el enfermo no había podido hacer hasta ese momento.

La necesidad de hacernos cargo del paciente y de la familia, debe ser compartida por el equipo terapéutico que tiene que trabajar en forma integrada, para asegurar la máxima coherencia en la conducción del tratamiento, generalmente amenazada por la tendencia a disociarnos que tienen tanto el paciente como los familiares. Pero además el equipo terapéutico participa necesariamente en el trabajo de elaboración psicológica de los conflictos, porque el proceso terapéutico del paciente psicótico no se realiza solamente en la dimensión transferencial con el analista individual. Los intensos mecanismos de splitting, las transferencias desplazadas en otras personas del equipo, las frecuentes actuaciones psicopáticas donde, muy a menudo se expresan los conflictos psicóticos más intensos hacen que el trabajo de elaboración psicoanalítica se enriquezca enormemente cuando se complementa con terapia grupal, grupo familiar y grupo comunitario. En este contexto, el trabajo interpretativo puede incluir mucho más la realidad exterior y la confrontación entre mundo interno y mundo externo.

El tipo de vínculo neurótico o psicótico que el paciente tiene con sus familiares, revela su estructura psicopatológica y es al mismo tiempo la expresión de la naturaleza de las relaciones de objeto que constituyen su personalidad. Cuando a través del proceso terapéutico, esas estructuras comienzan

14 JORGE GARCIA BADARACCO

a movilizarse los miembros de la familia del paciente, ejercen consciente o inconscientemente una serie de influencias, a través de las cuales se trata de evitar, detener o inmovilizar precisamente los cambios que la psicoterapia trata de poner en marcha. En esas condiciones, muy a menudo, la transferencia que es una de las fuerzas más importantes del proceso, choca con la fuerza de los vínculos reales del paciente con sus familiares que, a través de toda suerte de complicidades (11), actúa abierta o secretamente, contra la posibilidad misma de un verdadero proceso terapéutico. La inclusión de la familia (8), no es una tarea fácil y la experiencia nos muestra que, cuando reunimos al enfermo con sus familiares, se movilizan ansiedades profundas, tanto en uno como en los otros, cuyo control o regulación no es siempre cómodo. Para mejor comprender la naturaleza de las ansiedades y de las dificultades que nosotros encontramos, sería necesario desarrollar algunas ideas que hemos reunido bajo los títulos de "Patología del narcisismo familiar" (16) y de "Influencia familiar en la así llamada reacción terapéutica negativa" (10).

La patología psicótica corresponde en gran parte a una problemática familiar, en la que el paciente no ha podido jamás tener verdaderamente una vida psicológica propia plena y ha podido solamente expresar aspectos de su personalidad correspondientes a identificaciones parentales diversas. En las relaciones interpersonales encontramos relaciones de objeto primitivas o narcisistas en las que la omnipotencia juega todavía un rol predominante. Los miembros de esos grupos familiares, se tratan entre ellos como objetos parciales y tratan de manipularse los unos a los otros como si fueran partes de ellos mismos. Las partes del self que se consideran indeseables porque producen dolor y ansiedad son proyectadas de una manera omnipotente en el interior de los otros, que son así utilizados como depositarios. El enfermo mental es el que toma en general ese rol y es a partir de la crisis psicótica que se convierte en una especie de estabilizador de la estructura familiar enferma. En esas estructuras familiares narcisísticas, los miembros no pueden aceptar la separación del self y el objeto, es decir, el proceso de individuación y pretenden mantener la aglutinación y la simbiosis como el ideal de la relación familiar y esto empobrece los intercambios y la reelimentación psicológica con el mundo exterior. Cualquier intento de individuación de uno de los miembros pone en evidencia los sentimientos de dependencia patológica escondidos y disfrazados por la omnipotencia, tanto en el que pretende individuarse, como en los otros. Esto se presenta como una situación dramática en la cual se juegan profundos sentimientos de agresión, de envidia y de dolor que hacen imposible el clima psicológico necesario para tal individuación, que se hace entonces muy difícil en relación con la dificultad de elaborar el duelo de la separación. El enfermo psicótico sería, en ese sentido, el miembro de una familia de estructura narcisística que intenta transformarse en individuo y que, encontrando intolerable el cambio e imposible la elaboración de la separación de la simbiosis, fracasa y se psicotiza. Cuando el enfermo se vuelve el "loco" sus propias dificultades de salir de la enfermedad, se incrementan con las dificultades del grupo familiar que inconscientemente fuerza la psicosis en el paciente. En esas condiciones la psicoterapia que pretende elaborar los núcleos psicóticos y reconstruir la personalidad total, se beneficia mucho de la inclusión de la familia en el proceso terapéutico, para que el paciente pueda desprenderse de sus objetos internos malos a través de la elaboración de sus relaciones de objeto con los objetos externos reales (12). Retornando ahora nuevamente al problema de la relación médico-paciente queremos hacer algunas consideraciones complementarias. Es sabido que la psicoterapia, entendida en general como la relación paciente-terapeuta por medio de entrevistas, exige que el sujeto tenga una capacidad de expresarse y de manifestar receptividad y reactividad emocional. Si está completamente postrado o muy excitado, si tiene perturbaciones que en el estado actual de los conocimientos psiquiátricos son consideradas incurables, entonces se considera que no está en condiciones de aprovechar ningún tipo de psicoterapia. Freud dijo también que el Yo del enfermo, para analizarse, debe ser capaz de

establecer con su analista, una especie de alianza terapéutica como condición necesaria a todo enfoque psicoanalítico. El paciente psicótico, muchas veces se presenta como incapaz de hacer un vínculo de esta naturaleza, pero nuestra experiencia nos ha mostrado que la capacidad yoica para establecer una relación terapéutica no es algo determinado solamente por la condición psicopatológica o por las modificaciones o perturbaciones del Yo del paciente, sino que depende, en gran medida, de la capacidad del analista y del "contexto real" de la experiencia terapéutica (15) (17). En la mayor parte de los casos la participación de la familia en el proceso terapéutico (a través de una terapia familiar simultánea a la psicoterapia individual o grupal del paciente) constituye un factor esencial para que el enfermo pueda mantener el vínculo terapéutico y realizar un proceso verdadero hasta alcanzar una madurez satisfactoria de su personalidad. Si el paciente necesita internación la comunidad se comporta como una familia sustitutiva que provee el alimento afectivo y la estabilidad necesaria para que el enfermo mental pueda recorrer y realizar su proceso terapéutico. A medida que se fue haciendo nuestro trabajo la comunidad fue revelando la estructura virtual de una gran familia multifamiliar. Los factores que configuran el contexto pueden influir de tal manera sobre el tratamiento, que pueden condicionar un fracaso o hacer imposible el proceso, si no son tomados en cuenta e incluidos en la terapia del paciente. Es en la psicoterapia de pacientes psicóticos en donde se pone más en evidencia la importancia del contexto que rodea al enfermo porque no estando éste en condiciones de establecer y mantener fácilmente una relación terapéutica, necesita que el tratamiento se realice en condiciones de seguridad psicológicas tales que constituyan un "continente" válido y un apoyo yoico verdadero para que el paciente pueda tolerar la reactivación transferencial de sus conflictos, la intensidad intolerable de las emociones que se despiertan y realizar las experiencias correctoras necesarias para su crecimiento yoico.

Para terminar deseamos señalar que si bien las ideas desarrolladas en el presente trabajo se refieren especialmente a la psicoterapia de pacientes psicóticos, pensamos que son igualmente válidas para la psicoterapia de cualquier paciente. Para los niños y los adolescentes los problemas son muy semejantes a lo que ocurre con los pacientes psicóticos. En lo que concierne a los pacientes neuróticos también podemos sostener la misma afirmación, aunque sería necesaria una fundamentación más amplia imposible de realizar aquí porque excedería el espacio asignado para nuestro trabajo.

RESUMEN

En el presente trabajo el autor desarrolla la idea de que la familia constituye el contexto real de todo proceso psicoterapéutico. Comienza planteando la necesidad de diferenciar el concepto de tratamiento, ligado a la idea de una técnica particular, del concepto de proceso terapéutico. En ese sentido existe una diversidad de técnicas psicoterapéuticas pero, más allá de las técnicas es necesario apuntar hacia una creciente integración de los recursos alrededor de la unidad del proceso terapéutico verdadero.

Continúa luego planteando que la psicoterapia en general se ha estudiado como la relación paciente-terapeuta pero que no se ha tomado suficientemente en cuenta lo que el autor llama el contexto real que rodea al enfermo y a la relación terapéutica. Después de hacer una breve reseña histórica de las técnicas psicoterapéuticas señala que a su entender no se han estudiado suficientemente las causas de los fracasos. Desarrolla luego las investigaciones personales en ese sentido y plantea que, a través de su experiencia, la inclusión de la familia es fundamental para hacer posible el abordaje psicoterapéutico del paciente psicótico. Cuando el paciente necesita hospitalización, la institución debe comportarse como una familia sustitutiva para que el paciente pueda tolerar las vicisitudes de su tratamiento en cuanto a regresiones y progresiones y movilización emocional en la transferencia. Describe en forma resumida las dificultades que se presentan en la terapia familiar que pretende elaborar profundamente las dificultades de estos pacientes y plantea la posibilidad de la curación

de estos pacientes siempre que se tengan en cuenta las características particulares del enfermo psicótico en cuanto al vínculo terapéutico y al contexto real que necesita para poder realizar las experiencias correctoras necesarias para su crecimiento yoico.

Finalmente el autor plantea que si bien el trabajo se refiere en particular a la psicoterapia de pacientes psicóticos considera que los mismos principios son válidos para todo tipo de pacientes, aunque para fundamentar esta afirmación sería necesario un desarrollo mas amplio que no se puede realizar en esta oportunidad.

BIBLIOGRAFIA

- 1 Ackerman, Nathan W.: *The Psychodynamics of Family Life*. Basic Books, Inc. New York, 1958, (hay traducción en español).
- 2 Ackerman, Nathan W. y otros: *Family Process*.
- 3 Boszormenyi — Nagy, I. y Framo, J.L. eds. *Intensive Family Therapy, Theoretical and Practical Aspects*, Harper and Row, New York, 1965.
- 4 Bateson, G., Don D. Jackson, Haley, J. y Weakland J.A. *Hacia una teoría de la esquizofrenia*, en *Interacción Familiar*. Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971.
- 5 Bowen, M.: *Family Psychotherapy With Schizophrenia in the Hospital and in Private Practice*, en Boszormenyi - Nagy, I. y Framo, J.L. eds. op. cit.
- 6 Fleck, S.: *Psychotherapy of Families of Hospitalized Patients*, en Masserman, J.H. ed. *Current Psychiatric Therapies*. Grune and Stratton, New York, 1963.
- 7 García Badaracco, J.E.: *Relato oficial sobre comunidad terapéutica*. IV Congreso Mundial de Psicodrama; Iº Symposium Panamericano de Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires, 1969.
- 8 García Badaracco, J.E.; Proverbio, N. y Canevaro, A.: *La terapia familiar en comunidad terapéutica psicoanalítica de pacientes psicóticos (grupo familiar múltiple y grupo familiar nuclear)*; en *Patología y terapéutica del grupo familiar*, pp. 150-152 (Fundación Acta, Buenos Aires, 1970).
- 9 García Badaracco, J.E.; Canevaro, A. y Czertock, O.: *Coterapia y grupo familiar*; en *Patología y terapéutica del grupo familiar*, pp. 226-229 (Fundación Acta, Buenos Aires, 1970).
- 10 García Badaracco, J.E. y Canevaro, A.: *La reacción terapéutica negativa y la influencia familiar*; en *Patología y terapéutica del grupo familiar*, pp. 221-225 (Fundación Acta, Buenos Aires, 1970).
- 11 García Badaracco, J.E. y Proverbio, N.: *Las alianzas familiares en la terapia de familias de psicóticos*, en *Patología y terapéutica del grupo familiar*, pp. 230-231 (Fundación Acta, Buenos Aires, 1970).
- 12 García Badaracco, J.E.; Proverbio, N. y Canevaro, A.A.: *Tratamiento de pacientes psicóticos*. Acta psiquiat. psicol. A., Lat. 18: 232-243 (1972).
- 13 García Badaracco, J.E.; y Zemborain, E.J.: *La regresión en la comunidad terapéutica psicoanalítica*. VIIº Congreso Latinoamericano de Psiquiatría, Punta del Este, 1972.
- 14 García Badaracco, J.E.; Canevaro, A.A.; Czertock, O.; Sicardi, A. y Zemborain, E.J.: *El grupo familiar múltiple para el tratamiento de pacientes psicóticos en comunidad terapéutica psicoanalítica*. VIIº Congreso Latinoamericano de Psiquiatría, Punta del Este, 1972.
- 15 García Badaracco, J.E. y Zemborain, E.J.: *El narcisismo en pacientes psicóticos. Analizabilidad de las "neurosis narcisísticas" en función del comportamiento del analista como objeto externo*. Revista Psicoanalítica, 3 (1975).
- 16 García Badaracco, J.E.: *Trabajo inédito*.
- 17 García Badaracco, J.E.: *Avances en psicoanálisis de neurosis y psicosis*. Relato presentado al Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis. Buenos Aires, 1976.
- 18 Haley, J. ed. *Changing Families*. Grune and Stratton, New York, 1974.
- 19 Lidz, Th. Cornelison, A. Carlson, D.T. y Fleck, S.: *el medio intrafamiliar del paciente esquizofrénico: la transmisión de la irracionalidad*, en *Interacción Familiar*, Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971.
- 20 Pichon Riviere. *Tratamiento de grupos familiares*. 1960, trabajo inédito publicado en *Del Psicoanálisis a la Psicología Social*. Ed. Galerna, Buenos Aires, 1971.
- 21 Rubinstein, D. *Family Therapy*, en Masserman, J.H. ed. *Progress in Neurology and Psychiatry*, Grune and Stratton, New York, vol. 18, 1963.
- 22 Wynne, L.C. *Indicaciones y Contraindicaciones de la terapia familiar exploratoria*, en *Interacción Familiar*. Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971.
- 23 Zuk, G.H. y Rubinstein D. *A Review of Concepts in the Study and Treatment of Families of Schizophrenics*, en Boszormenyi - Nagy, I. y Framo, J.L. eds. op. cit.

Objetivos y metas de la terapia familiar

Simposium: terapia de familia y pareja

II Congreso Inteamericano de Psicología Clínica,

San Pablo, agosto 1976

Isidoro Berenstein*

1. Ejemplos clínicos:

Al servicio de psiquiatría de un hospital general (1) concurrió un estudiante de medicina para consultar por la hermana. Como el motivo de la consulta resultaba ambiguo resolvieron hacer entrevistas familiares. Fueron tres, en dos de ellas estuvieron presentes los cuatro miembros y en la tercer entrevista faltó el hijo, de manera tal que la silla vacía marcaba como signo una ausencia. Eran cuatro personas: el padre de 53 años, la madre de 47 años, el hijo de 22 años y la hija de 14 años.

Cuando la entrevistadora interrogó sobre el motivo de la consulta el padre dijo que por indicación del médico clínico a la hija la habían llevado al servicio de neurología. Allí le habían hecho un electroencefalograma y el registro no tenía ningún tipo de alteraciones pero como tenía un problema nervioso la derivaron a psiquiatría. El problema nervioso es que no se siente comprendida por los padres aunque deja constancia, el padre, que le dieron más cariño, dedicación, cuidado a la hija que al hermano. La hija respondió que nervios tenían los cuatro puesto que chocaban y se peleaban por cualquier detalle. Este tipo de interacción siguió durante un rato en tanto la madre y el hijo se mantenían callados a la expectativa. El padre siguió quejándose de los reproches de la hija hasta que agregó como al pasar que la niña era la única nieta de la rama materna y quizá por ello trataba de ser la "vedette" del espectáculo. Nunca tenía un lindo gesto, siempre el ceño fruncido como enojada. Habían pasado una época de mala situación económica y de esa manera no podía haber felicidad completa. La hija puso como ejemplo que ella cree que a los 14 años de edad se tiene que vestir sola y la madre quiere vestirla según los deseos de ella. Como datos sin mayor importancia dijeron que el padre tuvo meningitis cuando tenía un año de edad y la madre padeció tuberculosis entre los 7 y los 12 años.

(*) Rechov Rav Ashi 1 piso 7º. Ap. 71 — Naveh Avivim — Tel Aviv — ISRAEL

(1) Agradezco la colaboración de las licenciadas Ivon Suide y Marta Mor Roig quienes han recogido y estudiado minuciosamente el material.

En otro momento volvieron a mencionar a la abuela materna, era muy generosa, por ejemplo para las fiestas se vestía de Papá Noel para divertirlos. No se puede dejar de conectar esta actitud histriónica con la adjudicación de sentido cuando dijeron que la hija era la "vedette" del espectáculo. Aunque dispongo de más material clínico, a los efectos de esta presentación interrumpo aquí para pasar a relatar otro ejemplo. Es de un fragmento de sesión de una pareja matrimonial.

En esta sesión el marido, preocupado, trata de contarme lo que les ocurrió el día anterior. La mujer tenía un problema ocular y habían consultado a un primer oculista, quien le había indicado un estudio radiográfico mediante inyección de sustancia radioopaca en el saco lagrimal. Parecía ser un método cruento y doloroso. De común acuerdo decidieron consultar a un segundo oculista y éste, apelando al método clínico, les indicó el tratamiento, obviando el doloroso medio diagnóstico. Pero a la salida de la segunda consulta el marido se sentía inquieto y con la preocupación sobre si el colega no dejaría pasar por alto algo importante y sugirió el método de la sustancia radioopaca. comunicó su preocupación a la mujer quien a su vez se preocupó puesto que antes no lo estaba. Acerca de la cualidad inoculatoria del mensaje del marido en la mente de su mujer y de la disposición en ésta a tomar como propias las preocupaciones de su marido no lo consideraré aquí. Fue tan intensa y ahora compartida la preocupación que decidieron volver al médico y consultarlo. Este los tranquilizó, había pensado en el método pero lo había descartado. Al volver a salir tuvieron una intensa pelea con mutuas y recíprocas agresiones verbales. Les señalé que aunque trataban acerca del ojo de la mujer, el marido, sin saberlo, instalaba una preocupación propia desencadenada por la percepción del ojo de la mujer y que sin saberlo lo vivía como algo propio. Respondieron que efectivamente el marido tenía una disminución en la visión de un ojo y de la audición en un oído. El material que siguió en la sesión fue aportado por la mujer. Tenía una serie de quejas basadas en el descuido de los suegros por los hijos, es decir los nietos. Los abuelos no veían las situaciones de peligro, como ser, en una oportunidad, la madre del marido había cruzado la calle con el nieto, sin advertir como un coche se acercaba peligrosamente. Otra vez se había acercado al balcón con la criatura en brazos sin darse cuenta que la baranda era baja y el niño sacaba el cuerpo al vacío. Para mayor aclaración me explicaron que los hijos sólo tenían esos abuelos, los padres del marido, los otros habían emigrado hacía mucho tiempo. Podemos pensar hipotéticamente que la mujer expulsaba su odio a los padres abandonantes en la persona de los suegros ofreciéndose en cambio para que el marido recíprocamente 'usara' el cuerpo de su mujer para alojar las propias preocupaciones. Les señalé que el malestar por la situación matrimonial era de tal magnitud que no podían mirar los dos para el mismo lado como paratener dos puntos de vista distintos pero del mismo problema o de la misma situación y al no poder tratar lo que les pasaba con esa perspectiva sentían que se dañaban mutua y respectivamente porque no veían el riesgo que para sus respectivos aspectos infantiles suponía no contar con aspectos suficientemente adultos. También incluí que contaban conmigo, segundo terapeuta de pareja de ellos, para que los tratara no dolorosamente y contuviera las propias peticiones de ellos en ese sentido.

2. Objetivos de la terapia familiar. La familia como un sistema.

El grupo familiar es un grupo preformado y como tal o busca o le es indicado el tratamiento psicoterapéutico. Como grupo antecede y postcede al terapeuta, viven juntos antes y después de las sesiones, tienen una historia previa y una estructura inconsciente. Estas son las cualidades que lo diferencian de cualquier otro grupo psicoterapéutico.

Para esta comunicación, y espero poder lograr establecer un acuerdo con ustedes considero al grupo familiar como un sistema compuesto por personas

ligadas por una relación de parentesco y cuya significación depende de la estructura familiar. Decir sistema se refiere a pensar la familia como teniendo una particularidad definitoria como conjunto y no sólo por la suma algebraica de sus integrantes.

Considerar la familia del enfermo mental como un sistema implica optar por una decisión estratégica: desenfocar el problema individual y reenfocarlo como un síntoma familiar. Para el primer ejemplo clínico sería desubicar lo ubicado en la cabeza de la hija donde se ha proyectado las consecuencias fantaseadas o reales de la meningitis paterna como las de la tuberculosis de la madre cuando tenía la misma edad que la hija ahora y que es a su vez la edad de la menarca y del recomienzo de las pulsiones sexuales, posterior al período de latencia luego del primer acmé sexual infantil referido al complejo de Edipo.

Enfocarlo como un síntoma familiar lleva a recoger los indicios clínicos del sistema. Para este caso podemos decir que la hija es un doble simétrico invertido de la abuela materna transformación operada a través de la madre ligada defectuosamente en su alianza matrimonial y aunque no tengamos datos aún se podría sostener que esa estructura se mantuvo con la colaboración del padre. Efectivamente contaron que el hijo durmió hasta los seis años entre la cama del padre y la de la madre y tenían camas gemelas, las únicas que admiten estar juntas y a la vez separadas. La silla vacía de la tercera entrevista puede ser pensada como un indicio individual y la ausencia, como un significado ligado al hijo pero también puede ser considerado como la proyección en el espacio de una presencia ausente y cuya significación pasa por la relación entre la abuela materna y el grupo familiar de la consulta.

Para alcanzar este primer nivel de homogeneidad es necesario disolver, como primer paso técnico, las significaciones individuales y alcanzar el nivel del sistema. La perspectiva respecto de una familia puede variar según la ubicación del observador. Es el cambio de perspectiva obtenido por ejemplo cuando uno viaja en avión y al levantar vuelo se ven al principio las casas en forma distinta y diferenciada, una suma de casas. A medida que cobramos altura las casas se borran en sus límites distintos y se tiene la visión de los bordes y detalles del contorno de la ciudad, la costa, sus accidentes geográficos.

3. Meta de la terapia familiar. La estructura inconsciente.

Una familia tiene funcionamientos cuya significación puede no estar en el campo de la conciencia de los integrantes, aunque regulan y dan sentido a las relaciones familiares. Es inconsciente aquello de la organización familiar que no pasa por la conciencia de los integrantes o aquello de su historia no apreciado como determinante de la estructura actual de las relaciones familiares. Es inconsciente lo desconocido pero determinante y que otorga significación a las relaciones familiares. Algunos aspectos de la estructura familiar son explicitados como normas y aunque originados en acontecimientos históricos ya no vigentes, siguen regulando al grupo familiar en la actualidad y conservan toda su eficacia a pesar de ser desconocidas para los integrantes, las fuentes históricas tanto como las condiciones actuales que las mantienen. La conciencia de cada uno de los integrantes de todo grupo familiar tiene puntos en común donde perciben cualidades y otros puntos en común donde dejan de percibir otras cualidades, de acuerdo a un código o normas que admiten o censuran y prohíben el autoconocimiento y el conocimiento de los otros miembros familiares. cuando el conocimiento se refiere a indicios de la estructura inconsciente. Esta es determinada por acontecimientos históricos transformados colectivamente y vigentes como trozos de verdad histórica, reelaborados y mantenidos en la actualidad como recuerdos compartidos encubiertos y encubridores, mitos y fantasías familiares compartidas.

Psiquiatría del grupo familiar: una perspectiva

E.G. Debbane*

La Psiquiatría del grupo familiar. Su contexto.

No es de extrañar que la psiquiatría del grupo familiar esté en pleno desarrollo en América del Norte; es al mismo tiempo un producto de su cultura e introduce la cultura en un mundo psiquiátrico que a menudo tuvo tendencia a vivir en compartimientos estancos. La psiquiatría del grupo familiar es a la vez un movimiento sociológico, una innovación terapéutica y el esbozo de una teoría propia de la patogénesis familiar que ya parece querer incluir en su dominio tan diversas ramas como el psicoanálisis, la cibernética, la informática, la teoría general de los sistemas, la sociología, la antropología y diversas teorías de la formación de la personalidad. Sólo el tiempo dirá si tal síntesis es posible.

Dos corrientes parecen haber favorecido el desarrollo de la psiquiatría del grupo familiar tal como la conocemos hoy: la primera, a través de cierto desarrollo del pensamiento psicoanalítico en América del Norte, y la segunda, a través de la evolución de la sociología.

Se podría decir, quizás arbitrariamente, que fue Erikson quien entreabrió el camino a través del cual la importancia del medio ambiente fuera reconocida en su influencia sobre las diversas fases del desarrollo. De una manera más radical, Sullivan puso en términos interpersonales lo que hasta aquel momento no estaba concebido más que en términos intrapsíquicos. Karen Horney puso el acento sobre la influencia de los acontecimientos actuales en el desarrollo y tratamiento de las neurosis. A partir de ese momento y para un cierto número de psiquiatras el aquí y ahora, así como la suma de las relaciones interpersonales ocupaba su lugar en el estudio y tratamiento de la psicopatología observada.

La evolución hacia el estudio de las familias propiamente dicho se hizo len-

(*) ALLAN MEMORIAL INSTITUTE. 1025, avenue des Pins, W. MON-TREAL - CANADA

(1) En *perspectives Psychiatriques* - N° 37, III - Junio 1972 - Paris - FRANCIA - Publicado con permiso del autor.

tamente (21). Al comienzo se encuentran estudios centrados en la relación madre-niño, ya sea la descripción de la madre sobreprotectora de Levy, en 1948, o la descripción de la madre esquizofrenógena por F. Fromm-Reichman, en 1948, en 1952 la descripción por Mahler de la relación simbiótica. En 1949 Lidz & Lidz (10) se interesan en la familia de los esquizofrénicos. Ellos notan que sobre 50 esquizofrénicos solamente 5 han tenido en sus antecedentes una vida familiar adecuada: 40% de ellos habían perdido a uno de los dos padres antes de los 19 años. Ellison y Hamilton (3), en 1949, describen una serie de observaciones en el mismo sentido: sobre 100 esquizofrénicos estudiados 30 tenían en sus antecedentes una historia de inestabilidad familiar caracterizada ya sea por la muerte de un padre o por la separación o el divorcio; tres sobre cinco tenían una madre que se podría calificar de sobreprotectora. Johnson y Zurek en 1954, han delineado de una manera más directa la relación entre la patología de los padres y la de los hijos en ocasión de su descripción de las "lagunas" del superyo, que según ellos caracterizaría a algunos niños de comportamiento antisocial; para ellos se podría encontrar un déficit similar en los padres.

En otra serie de estudios. Lidz (11), en 1957, va a tomar al padre como punto de referencia. Siempre en el estudio de la familia del esquizofrénico Lidz describe 5 categorías de padres:

- 1) en conflicto con su mujer y seductor con su hija;
- 2) en conflicto con su mujer y desplazando la hostilidad que siente hacia ella sobre su hijo;
- 3) padre con tendencias megalomaniacas, siendo éstas reforzadas por la sumisión y la colaboración aparente de su mujer en estas ideas de grandeza; él es en general distante respecto de sus hijos;
- 4) el padre es un fracaso y objeto del desprecio de su mujer;
- 5) padre pasivo dominado por su mujer. Se puede ya encontrar en esta clasificación lo que ha servido de base a la descripción ulterior de los cismas y desviaciones familiares.

Hasta entonces la familia no había sido percibida como un todo, una unidad teniendo características que no fueran la suma sus componentes. En efecto, en los estudios ya mencionados parece que el énfasis se hubiera puesto sobretudo en considerar la influencia de una variable (padre, madre, familia desunida) y su rol en la producción de la psicopatología en un niño.

En 1959, Spiegel y Bell describen a la familia como una unidad biosocial e introducen el concepto de patología familiar donde el paciente designado o sancionado correspondería al síntoma y manifestaría el estado de enfermedad del conjunto. En 1960 Bell y Vogel describen el fenómeno del "chivo emisario". Bowen describe el concepto de divorcio emocional e introduce la hipótesis de la génesis familiar de la esquizofrenia a través de tres generaciones. Lidz remarca que en la familia de esquizofrénicos la barrera entre las generaciones está suprimida; o sea el hijo se convierte en el partenaire del padre del sexo opuesto y es utilizado contra el padre del mismo sexo; la relación edípica es vivida en los actos. Esto subyace a la descripción de los cismas familiares. Wynne, en 1958, introduce el concepto de pseudomutualidad en la familia de los esquizofrénicos que diferencia por un lado de la mutualidad y por otro de la complementariedad. Clínicamente estas familias se distinguen por su impermeabilidad; todo el mundo está siempre de acuerdo sobre todo. Son familias donde no se llega a manifestar ninguna divergencia de opinión, ninguna discusión. Todos los miembros tienen siempre la misma opinión y consideran esto como una norma habitual. La individualidad de cada uno de ellos está sumergida en la homogeneidad del bloque familiar. Desde 1956 el grupo de Palo Alto elabora una teoría familiar de la génesis de la esquizofrenia basada sobre la teoría de la comunicación. Este grupo desarrolló el concepto de doble vínculo y de homeostasis familiar de los que hablaremos más tarde.

Nos podríamos remontar a E. Goffman (6), en 1959, para trazar el origen del estudio sociológico de la relación entre una institución y su paciente. En efecto, él

describe en detalle la "carrera moral" del paciente mental. Para él lo que es importante no es la génesis de los síntomas psiquiátricos y su tratamiento eventual sino lo que pasa entre el sistema social y uno de sus miembros desde que éste último acusa una sintomatología psiquiátrica aguda. Para él, ser enfermo mental es también un rol, molesto por otra parte, pero del que no es posible desembarazarse fácilmente; "se hace" carrera. Este nuevo rol acordado al individuo se caracteriza por la pérdida de la autonomía, de la individualidad, de la decadencia de las interrelaciones sociales. Enfermo mental es aquel que es incapaz de asumir sus derechos y por lo tanto los ha perdido. Para Goffman institución mental y prisión no son muy distintas; en los dos casos se es admitido por haber derogado ciertas normas de comportamiento y la institución, al fin de cuentas, sirve más a la sociedad que al individuo que debería beneficiarse con su protección. El paciente se encuentra súbitamente alienado, su medio se ha vuelto hostil y sus parientes, aquellos de los que podría esperar un sostén, son a menudo los agentes de su internación.

Se podría reprochar a Goffman ignorar de manera deliberada la disfunción que ciertos síntomas psiquiátricos implican. Sin embargo, Szasz, un psiquiatra, es igualmente explícito respecto de la decadencia social y psicológica tal como es vivida en el rol de paciente. Habría que agregar que toda esta serie de estudios han tenido una gran repercusión y que no han dejado de influir al medio al que se dirigen. Como quiera que sea, despiertan un cierto número de preguntas: "¿existe en efecto una dicotomía entre el paciente sancionado como tal y su medio?" "¿Es ella necesaria?" Habiendo ya emitido la hipótesis de que el paciente sería el chivo emisario de su medio, una manera práctica de desembarazarse de un síntoma cuando el mal es más profundo. La solución clásica es siempre dicotómica (el paciente "enfermo" y el medio ambiente "sano"). ¿Esta es la mejor solución para el paciente sancionado como tal? O será, como lo sostiene Laing (9), una tentativa de parte del grupo social de mantener el statu quo y de ahogar al individuo que a través de un modo experiencial distinto pone en cuestión de manera violenta la estructura de nuestra sociedad actual? Para Laing el amor-dazamiento se produce a través de una conspiración médica donde se establece un diagnóstico, lo que supone lógicamente la aplicación del tratamiento adecuado. El aduce, no sin cierto sarcasmo, que el proceso de diagnóstico en este caso es más un acto político que médico. En efecto, cómo se podría diagnosticar una enfermedad cuya entidad misma es aún dudosa y menos aún pretender un tratamiento? Para Laing la esquizofrenia es una etiqueta que ciertos individuos se reconocen el derecho de otorgar a otros, es una forma de alienación, un hecho social y un acontecimiento político, una manera de penar la experiencia vivida del esquizofrénico que se ha juzgado incomprensible e inaceptable. En una tentativa más extrema, Laing no duda en invertir los roles y la esquizofrenia se convierte en una tentativa experiencial, un esfuerzo heroico por superar nuestro propio estado de alienación crónica que se llama normalidad. El esquizofrénico estaría entonces embarcado en un viaje en el tiempo y los espacios internos. Para Sieglar (15) y otros el intento de Laing es peligroso. Ellos encuentran que él tiende a confundir experiencia psicótica y experiencia psicodélica y termina idealizando la experiencia psicótica.

Lo que Laing describe no es muy distinto a otro fenómeno social, el de la contestación en el que un grupo se define como minoritario y define su relación con el grupo mayoritario como si fuera una relación de explotación a través de la cual éste último mantuviera su dominación y el sometimiento del grupo minoritario a sus fines. Parece que Laing, que persigue al mismo tiempo diversas orientaciones sin poder integrarlas, extrapola esa corriente de pensamiento en su descripción de la familia. Para él, la familia es una institución de carácter político creada por el grupo mayoritario (los padres) para la satisfacción de sus necesidades. La explotación del grupo minoritario (los hijos) tiene lugar a través de comunicaciones del tipo doble vínculo. Así se estaría obligado a creer que es el abuso de este poder político o su ejercicio a través de ciertas modalidades lo que

engendraría en algunas personas la elección de la experiencia esquizofrénica. Se podría decir que al criticar una dicotomía, aquella creada por el etiquetado de un paciente psiquiátrico, Laing termina por crear otra en sentido inverso. De cualquier manera su intento teórico refuerza la necesidad de formular una visión más guesáltica de la familia.

La psiquiatría del grupo familiar en el curso de su evolución no ha dejado de sentir la influencia de estos trabajos. Ella constituye una innovación psicoterapéutica en la medida que es la única técnica que incluye como participantes activos y comprometidos a miembros "sanos". Por último ella establece el vínculo y trata de dilucidar la relación entre el individuo y su sociedad en el cual la familia representa la unidad de base.

La psiquiatría del grupo familiar. Su práctica.

Una interesante obra recientemente publicada que tiene como objetivo el campo de aplicación de la psiquiatría del grupo familiar constituirá la base de lo que sigue (5). El objetivo de este estudio era el de reunir a través de un cuestionario dirigido a 520 profesionales una visión global del estado actual de la psiquiatría del grupo familiar o sea durante el período de febrero de 1966 a febrero de 1967. Es evidente, como lo subraya la obra, que en una especialidad de rápida evolución esta visión de conjunto no tiene ya el mismo valor. Sin embargo, por lo que conozco, ella constituye el primer intento de investigación del conjunto de la práctica y tiene éxito en este sentido.

1. Los profesionales comprometidos en la práctica de la psiquiatría del grupo familiar.

Es interesante constatar que los psiquiatras están lejos de representar una mayoría. En efecto, los trabajadores sociales representan alrededor de un 40%, los psiquiatras y psicólogos otro 40% y en el resto se encuentran médicos, sociólogos y enfermeros (en América del Norte). En tanto grupo, ellos tienen tendencia a ser más bien jóvenes. El 80% tiene menos de 50 años. Un hecho interesante es que la psiquiatría infantil no constituye, al contrario de lo que se podría pensar, un medio donde la psiquiatría del grupo familiar se practique intensamente. Ellos han elegido la psiquiatría del grupo familiar porque les parece más eficaz; mejores resultados son obtenidos más rápidamente y de manera más evidente. Parece que en este grupo existe de manera subyacente el sentimiento de que las técnicas clásicas, esencialmente el psicoanálisis o la psicoterapia intensiva de tipo analítico han decepcionado. Finalmente, parece que la penetración de la psiquiatría del grupo familiar se ha hecho esencialmente a nivel de los centros comunitarios de higiene mental o en clínicas externas. Los centros universitarios o los hospitales mentales parecieran ser refractarios. La explicación plausible sería que en las instituciones de tipo comunitario la necesidad de técnicas nuevas se ha hecho sentir de manera más acuciante y que la psiquiatría del grupo familiar respondería a cierto deseo de integración del paciente y de su medio al tratamiento en curso. Hay que remarcar también que la mayoría de los profesionales de estas instituciones son trabajadores sociales.

2. Fines perseguidos.

El cuestionario ha intentado definir un cierto número de fines primarios y secundarios. El énfasis parece ponerse sobre los problemas actuales y la definición del sistema relacional de la familia. Los cambios de la estructura de la personalidad no son citados como importantes. Por el contrario, la mejora de la comunicación, de la autonomía y de la individuación de los miembros de la familia así como un acrecentamiento de sentimientos empáticos parecen ser los principales objetivos primarios. La mejoría sintomática, así como la mejoría del

funcionamiento social encabezan los fines secundarios.

3. Técnicas y aplicación práctica.

La psicoterapia de familia ha comenzado como una práctica terapéutica centrada sobre la solución de problemas más que la aplicación práctica de una teoría. De hecho, el desarrollo de la teoría se ha hecho más tarde y existe un margen considerable entre las dos. Los profesionales que se consideran psicoterapeutas de familia tienen al menos dos puntos en común: 1) creen que existe una relación entre la psicopatología del individuo y la de su medio familiar, y 2) preconizan la superioridad del tratamiento del grupo familiar sobre el tratamiento exclusivo del paciente sancionado como tal.

Fuera de esto y sobre el plano de la práctica existen muchas variaciones; vamos a considerar algunas:

Problema del grupo en tratamiento.

En general, el énfasis se pone sobre la familia nuclear o sea padres e hijos. Sin embargo el 60% incluyen en ciertos casos otros miembros de la familia. Un número igual se limita luego de algunas entrevistas al tratamiento de la pareja. Un gran número de terapeutas encaran de entrada la terapia de conjunto y la terapia individual. Otros prefieren restringirse a la terapia del grupo familiar y, si es necesario, referir los individuos que necesitan terapia individual a un colega.

Problema de la coterapia.

En general la coterapia no es muy popular en la terapia de familia. Sin embargo Whitaker (18) la encuentra útil sobre todo cuando se trata de identificar o de corregir las reacciones de la contratransferencia. En general, la razón invocada es que es ya bastante difícil de seguir la interacción del grupo familiar sin tener que introducir la complejidad de un problema adicional: la presencia de un coterapeuta, ya sea en la relación con los miembros de la familia, ya sea con el otro terapeuta. Solamente el 6% admite incluir un coterapeuta regularmente; el 68% estaría dispuesto a utilizarlo ocasionalmente.

Problema de la frecuencia del tratamiento.

La terapia de familia se practica en general con una frecuencia semanal. La duración de los encuentros parece variar según los terapeutas entre 45 y 90 minutos. La razón de esta frecuencia óptima no ha sido jamás clarificada aunque se enumeran algunas posibilidades.

- 1) Desde el comienzo y sobre el plano logístico podría ser difícil de movilizar todos los miembros de una misma familia más frecuentemente,
- 2) podría ser también que el conjunto de los terapeutas piensen llegar a resultados satisfactorios con esta frecuencia,
- 3) es posible que la tolerancia del terapeuta sea óptima en esta frecuencia, y finalmente,
- 4) es interesante poner de manifiesto que la mayor parte de ellos ven su compromiso con la familia como siendo a largo plazo.

Problema de la transferencia y contratransferencia.

La psicoterapia de familia implica una participación más activa del terapeuta que en las técnicas tradicionales lo que al comienzo puede ser una fuente de dificultades en numerosos planos. Ante todo, el anonimato del terapeuta es más difícil de preservar, lo que plantea de entrada un problema de ética en la medida

en que a través de sus modalidades de intervención el terapeuta puede tratar de favorecer su propia visión de las cosas, cuando no su propia escala de valores. La neutralidad del terapeuta es otro aspecto expuesto a verse rápidamente comprometido. Jackson (8) habla en detalle del problema que se presenta al comienzo de toda terapia cuando el terapeuta corre el riesgo de ser incorporado en el patrón de interacción de la familia y por lo tanto neutralizado. G. Zuk (2) ha descrito una técnica de intervención a través de la cual el terapeuta puede cambiar sus alianzas, incluirse o excluirse de la participación directa según su sistema de análisis de las interacciones. Se puede decir en general que el terapeuta debe mantener una libertad de movimiento en sus interacciones con la familia de manera tal que sea imposible definir a su respecto un patrón regular de interacción con ninguno de los miembros de la familia. En la medida de lo posible se mantiene imprevisible y en este sentido y en una cierta medida, neutro y anónimo. La cuestión de la discreción y la información privilegiada parece ser para algunos un falso problema ya que en el comienzo ellos informan a los miembros de la familia que toda información que cualquiera de ellos pueda confiar al terapeuta por separado pertenece al grupo y le será comunicada en la entrevista siguiente. Visto desde este ángulo el problema realmente no es el aspecto confidencial de la información sino la tentativa de un miembro del grupo de intentar establecer una relación privilegiada con el terapeuta y de proteger a través del establecimiento de un secreto en común el aspecto confidencial de otros secretos. Sería en suma, una maniobra de neutralización del terapeuta. Una excepción mayor sería la existencia de problemas sexuales entre los padres, en cuyo caso la discusión se limita a los únicos interesados y los niños son excluidos por un cierto número de sesiones.

En lo que respecta al problema de la transferencia parece en general que este aspecto no es central para el éxito del tratamiento. No es ciertamente necesario el esfuerzo de objetivarla para analizarla. En efecto, los objetos reales forman parte de la situación terapéutica y la resolución del conflicto a través de esta relación sería más útil. Sin embargo, para algunos terapeutas de orientación analítica y sobre todo cuando se trata de terapia marital o conyugal el problema de la transferencia reviste de nuevo su importancia clásica.

El problema de la contratransferencia desgraciadamente está poco discutido. Whitaker (18) la menciona para subrayar la importancia de la presencia de un coterapeuta que podría colocarse como observador objetivo y señalar al terapeuta los efectos de su contratransferencia. Framo y otros subrayan el hecho de que para el terapeuta, en cierta medida, es siempre la misma familia que cura, la suya, y la libertad de intervención activa que existe en psiquiatría de familias puede llevar a tentativas de análisis salvaje y de pasaje al acto de parte del terapeuta.

Es evidente que el problema de la transferencia y contratransferencia no se plantea más que en la medida en que el terapeuta incluya en su formulación teórica los conceptos analíticos. Para aquellos que siguen estrictamente al grupo de Palo Alto estos problemas se plantean mucho menos en la medida en que el terapeuta más bien es percibido como un técnico que trata de operar los cambios deseados a través de ciertas manipulaciones técnicas.

4. Perfiles Terapéuticos.

Sería posible tratar de describir los perfiles extremos de dos terapeutas de orientación diametralmente opuesta reconociendo, desde el comienzo, que tal descripción es teórica y esquemática y que la mayor parte de ellos se sitúan entre esos límites aunque algunos más cerca de un extremo que del otro.

En un extremo se podría describir un terapeuta de orientación analítica clásica operando a través de una institución universitaria y que conceptualizaría la terapia familiar como una variante de la técnica clásica y para quien el énfasis se pondría esencialmente sobre el individuo. Para él sería entonces el individuo el portador de la patología concebida esencialmente como intrapsíquica y

secundariamente, por externalización, como interaccional. La familia sería percibida entonces como un factor de stress; él se interesaría naturalmente por la historia personal del paciente así como por la historia personal de los miembros de la familia. Trataría de formular a partir de las dinámicas personales ciertas modalidades de transacciones dinámicas. El establecimiento de un diagnóstico clínico, al menos en lo que concierne al paciente descubrir y expresar sus sentimientos y movilizaría a la familia hacia una comprensión más profunda del dilema del paciente así como a su contribución y eventualmente a su ayuda posible. Y en el otro extremo se podría concebir un terapeuta para quien la orientación analítica es insuficiente. Ideológicamente se apoyaría casi exclusivamente en una orientación de la teoría de los sistemas; no trabaja en una institución universitaria; para él la terapia familiar es una nueva orientación, un descubrimiento, y se inscribe al margen de las técnicas analíticas clásicas. La noción de enfermo sancionado es rechazada; el paciente es un síntoma y el enfermo es la familia. El sistema familiar expresa su disfunción a través del miembro designado como enfermo. La disfunción reside en las interacciones familiares y ellas pueden ser observadas y objetivadas por el terapeuta. Los procesos intrapsíquicos son de importancia secundaria; los antecedentes o historia del caso tienen poca importancia ya que de entrada se interesa en las interacciones y en su manifestación en vista de modificar el sistema familiar. Toda la atención del terapeuta está centrada sobre la identificación de las constantes de funcionamiento en ese sistema. El estimulará la participación de todos los miembros de la familia y su interacción. La familia en todo momento forma un sistema social y ecológico distinto que él trata de explorar, clarificar y objetivar a todos sus miembros.

Psiquiatría del grupo familiar. Su teoría

Existe un desnivel importante entre la práctica de la psiquiatría familiar y su teoría. Esto puede ser interpretado de dos maneras diametralmente opuestas: por un lado, es posible que sin una base teórica coherente el entusiasmo podría diluirse rápidamente y como pasó con otras técnicas terapéuticas, la psiquiatría del grupo familiar sería cosa del pasado. Como ejemplo sería suficiente echar una rápida ojeada sobre el número de trabajos que han tratado de establecer una relación entre la eclosión del proceso esquizofrénico y ciertas características de las familias de estos individuos. Quince años más tarde y después de muchos esfuerzos nos encontramos en presencia de una serie de conclusiones inconexas. De acuerdo a las publicaciones de los últimos años es evidente que la etiología familiar de la esquizofrenia no tiene el interés que tenía entonces.

A la inversa, se podría decir que para una rama joven y en plena evolución todavía no ha llegado el momento de una síntesis global. Por el contrario no habría que subestimar la enorme complejidad de esta tarea y la posición muy particular en la que se encuentra la psiquiatría del grupo familiar, es decir en la encrucijada de fenómenos que pueden ser descriptos en diferentes niveles que no están necesariamente en continuidad. En efecto, la familia puede ser vista como un microcosmos de una organización social, un grupo con una larga historia, un sistema cibernético abierto o cerrado según el género de los fenómenos que se quiera describir, una interacción delicada entre intrapsiquismos que alternativamente introyectan y proyectan tratando de moldear la realidad externa su realidad interna, recreando a través de múltiples vicisitudes una concretización de su mundo fantasmático.

Las teorías más aceptadas en psiquiatría del grupo familiar parecen haberse desarrollado a partir de observaciones clínicas hechas a través de una cierta perspectiva teórica. Formular una conceptualización tiene por objetivo unificar esas observaciones y eventualmente proponer una generalización.

Son entonces a priori las teorías fragmentarias y limitadas que reagrupan serie de observaciones, ya sea, por ejemplo, el fenómeno de la seudomutualidad descrito por Wynne (19), ya sea las desviaciones y cismas maritales como los descriptos por Lidz o aún los fenómenos del doble vínculo. Se tiene la impresión en cierta medida que los diferentes autores han percibido la misma gama de fenómenos pero que cada uno de ellos ha utilizado desde el comienzo un lenguaje derivado de una teoría distinta lo cual lo ha llevado a reagrupar los fenómenos observados en una constelación particular. Es difícil por ejemplo, no notar una cierta similitud entre el doble vínculo de Bateson y Jackson (1) y el fenómeno de la seudomutualidad de Wynne. En efecto, en el primer caso se trata de un mensaje que contiene una contradicción entre sus dos niveles: el nivel más superficial informático que implica una prohibición (no hay que); el nivel más profundo, no verbal, de la metacomunicación que invierte esta prohibición (hay que) con el requisito de que este último mensaje es no verbal. Y finalmente se le prohíbe al receptor abandonar el campo de interacción. En la segunda conceptualización, la seudomutualidad, lo importante es estar siempre de acuerdo en que se está de acuerdo; un desacuerdo sobre el contenido del mensaje indica en estas familias la posibilidad de la ruptura de la relación. Las palabras están desprovistas de su sentido informático y tienen casi exclusivamente un valor relacional. La transmisión de significaciones precisas está falseada a favor de una imprecisión del sentido. La identidad individual es sacrificada por el mito de la identidad colectiva sentida como un bloque solidario y no diferenciado. Se podría decir que en este contexto se observarían un gran número de doble-mensajes. Además, este mismo grupo de fenómenos podría encontrarse en las desviaciones conyugales de Lidz (12). Por otra parte, se podría reencontrar elementos comunes entre lo que Wynne (19) describe bajo el título de seudomutualidad y la descripción del cisma conyugal de Lidz (12). De manera práctica, y tal como ya lo hemos expuesto, no hay teoría sobre la familia, pero a partir de teorías pertenecientes a campos de observación diferentes se han realizado aplicaciones familiares y conceptualizaciones derivadas que tratan de describir a través de su propio lenguaje los fenómenos familiares. El psicoanálisis, la sociología, las teorías sobre grupo; la cibernética, la teoría de los sistemas y la teoría behaviorista, por nombrar sólo algunas, cada una en su momento han contribuido con su lenguaje a la descripción de la familia. No es sorprendente entonces encontrar profesionales pertenecientes a disciplinas distintas que se reconocen todos el título de terapeutas de familias. En ciertos casos un mismo terapeuta en el curso de su carrera pasa de una teoría a la otra. Epstein (4) divide su evolución como terapeuta familiar en tres fases: 1) la fase intrapsíquica en la que la dinámica individual es de importancia central y los miembros de la familia se sitúan dinámicamente con respecto al enfermo designado como tal; 2) la fase interaccional que tiene aún por base la interacción de las dinámicas individuales tal como se las percibe a través de las diadas y la familia es analizada en función de un cierto número de diadas y de su interrelación; 3) por último, la fase de los sistemas donde los fenómenos intrapsíquicos e individuales son de una importancia secundaria y donde el énfasis se pone sobre la estructura, la organización y los patrones transaccionales de la familia considerados como determinantes del funcionamiento del sistema y afectando el comportamiento de los individuos que componen ese sistema.

A pesar de la fragmentación evidente de las diversas aproximaciones teóricas, sin embargo, a grosso modo se podrían ubicar tres tipos de teorías: las de tipo sociológico, las de tipo psicoanalítico y las de tipo cibernético y de sistemas. Las dos primeras teorías necesitarían para su exposición un texto separado. A continuación señalaremos sucintamente la evolución del último grupo de teorías o sea las de tipo cibernético y de sistemas.

En 1956, Bateson, Jackson, Haley y Weakland publican un artículo titulado "Hacia una teoría de la esquizofrenia" en el cual se identifica el fenómeno del doble vínculo basado en la teoría de la comunicación. La descripción del doble vínculo es precisa: dos personas o más, un modo frecuente de comunicación que implica una experiencia repetida, un mandato primario negativo, un mandato secundario que contradice al primero en el nivel abstracto de la metacomunicación reforzado por amenazas de castigo, un mandato terciario prohibiendo a la víctima salir del campo de interacción. En esta teoría la relación está tomada como una constante, la comunicación como una variable. En otros términos, es la comunicación la que condiciona la relación y no es que el tipo de relación se traduzca por una comunicación particular (en este último caso se estaría más próximo de una conceptualización psicoanalítica). La intensidad de la relación no hace más que reforzar la intensidad del mensaje y la obligación del receptor de someterse así como su incapacidad de librarse de él; teóricamente para salir de este campo le sería suficiente verbalizar su interpretación de la comunicación recibida, es decir comunicárselo al sujeto de la comunicación y entonces salir del campo de interacción que le han impuesto: esto sería contrario al tercer mandato. Laing (9), más tarde, ha insistido sobre este último punto detallando la presión ejercida sobre el niño para que no identifique el doble vínculo y que de hecho niegue la totalidad de la experiencia como si nunca hubiera tenido lugar. En el centro de esta teoría está la comunicación que está en la base de la interacción y es el vehículo a través del cual se transmite la información, la cognición y el sentido de relación. Más tarde Watzlawick (17) identificará a los dos niveles de mensajes como siendo de tipo informático digital (siguiendo el modelo de las computadoras de tipo digital) y de tipo analógico (a partir del modelo de las computadoras de tipo analógico); en otros términos, en cada mensaje existe un nivel de transmisión de información diferente, estando en un caso incluido en el contenido verbal y en el otro en un nivel no verbal que define la relación con el interlocutor y que se transmite a través de inflexiones de la voz, actitudes corporales, etc. Para él, los fenómenos intrapsíquicos están definitivamente puestos en un segundo plano; y para justificar su punto de vista compara el psiquismo con una caja negra que científicamente es imposible de penetrar (el concepto de la caja negra es tomado del campo de las telecomunicaciones y ha sido aplicado en algunos casos en los cuales era imposible estudiar la estructura interna de ciertos aparatos; gracias al análisis de los "input-output" si bien no era posible reconstituir la estructura interna del aparato, al menos lo era su funcionamiento). Para Watzlawick, todo lo que podría decirse de la estructura del psiquismo no surge de la investigación científica. Por el contrario, los procesos intrapsíquicos se traducen eventualmente en términos de comunicación y esto puede ser analizado objetivamente. Los síntomas constituyen una forma particular de comunicación a través de la cual el individuo que emite el mensaje lo descalifica al mismo tiempo y no es, en este sentido, la expresión de un conflicto intrapsíquico. La interacción entre dos individuos constituye una serie de emisiones de una caja negra a otra que las recibe y que a su vez responde con un mensaje que será recibido por el primero; esto constituye un "feedback" que tiene funciones múltiples: acusa recepción del mensaje, confirma la existencia de una relación, propone su punto de vista en cuanto al mensaje y a la relación y por ese mismo hecho limita a los dos a través de una interacción. El problema de la motivación, o sea el porque, es subjetivo y por lo tanto sujeto a interpretación. Para Watzlawick esto es reemplazado por la fórmula para qué, es decir es analizado en términos del efecto producido, asumiendo que, si el efecto producido no es el deseado, éste será modificado a través de otra serie de interacciones conducentes a una estabilización.

Sería interesante examinar el concepto de conflicto tal como lo propone esta teoría. Aquí el conflicto por definición no puede ser individual (en cuyo caso podría ser intrapsíquico o para adoptar su misma formulación ocurriría dentro de la caja negra) y también porque axiomáticamente no se puede no comunicar o

sea que se está siempre en interacción. Watzlawick admite que se puede estar en interacción con interlocutores fantasmáticos e implica que se sigue probablemente las mismas leyes; sin embargo él se impide proseguir en esta línea más profundamente probablemente porque, una vez más, tendría que adoptar una conceptualización de tipo analítica como por ejemplo la de los objetos internos. Para él, el conflicto se vuelve intrapsíquico secundariamente; al principio es interaccional y es el resultado de los "errores de juego":

1) podría ser el resultado de un malentendido de interpretación: un mensaje esencialmente digital es interpretado de un modo analógico o 2) un conflicto a propósito de la puntuación en la comunicación: es decir la secuencia que el receptor organiza cuando recibe un mensaje y sobre la cual basa su respuesta. Por ejemplo, si se tomaran dos comportamientos complementarios emitidos por dos personas distintas, el comportamiento A favorecería al comportamiento B que a su vez reforzaría A que a su vez reforzaría B. De todas maneras cada uno de los miembros de este diada efectuaría una puntuación distinta: ya sea la serie A—B—A por una parte o la serie B—A—B por la otra parte. En el caso de una pareja donde la mujer se queja del silencio de su marido al mismo tiempo que él se queja de los accesos de mal humor de ella, él puntuaría la secuencia siguiente: acceso de mal humor / silencio / acceso de mal humor; para ella la puntuación sería: silencio / acceso de mal humor / silencio; siendo éste el prototipo del género de interacción que puede durar años o del género de discusiones estériles donde todo el mundo tiene razón puesto que ninguno de los partenaires puede convencer al otro de lo bien fundado de su propio punto de vista. Dos clases de interacción son definidas: aquella de tipo simétrico que parecería una escalada progresiva y aquella de tipo complementario tal como describe el ejemplo mencionado. Y finalmente,

3) toda traba a la consistencia interna, a la claridad y al libre interés cambio de la comunicación (descalificación, doble vínculo, etc) constituye una fuente de conflictos.

Un concepto que completa el de la comunicación es el de la homeostasis familiar descrito por Jackson en 1959. Este concepto deriva de la cibernética y no es completamente ajeno al introducido por Claude Bernard: la constancia del medio interno que se trata de preservar aquí es el de la célula familiar. Al comienzo Jackson nota que el número de respuestas posibles a un mensaje dado es infinito. En una pareja se forma rápidamente una restricción de las posibilidades de respuestas. Por ejemplo, la cólera de un cónyuge terminará por provocar al cabo de un cierto tiempo casi siempre la misma reacción o al menos el repertorio de posibilidades está extremadamente restringido. Esto constituye un patrón de interacción. Cada grupo familiar está caracterizado por cierto número de patrones de interacción que definen las reglas del juego o los límites entre los cuales se produce la interacción. Se supone además que existe una prohibición no verbal y por lo tanto más efectiva respecto de toda tentativa de introducción de patrones de interacción que desborden ese marco. Se sabe por ejemplo que en toda familia hay cosas que no se dicen y también cosas que ni se piensan.

El concepto de homeostasis familiar tuvo mucha influencia en la psiquiatría del grupo familiar; ha sido retomado por cierto número de autores. Haley, en 1962, describe la familia como un sistema estable; él dice: "Cuando un individuo indica un cambio de relación respecto de otro, éste último actúa de manera tal que modifique o disminuya ese cambio". Riskin (14) describe toda familia como tendiente a mantenerse alrededor de un punto de equilibrio. El sistema está constantemente sujeto a nuevos "input" y por lo tanto siempre expuesto a ser desplazado de su punto de equilibrio. Sin embargo al cabo de cierto tiempo la familia desarrolla ciertos patrones de interacción que tendrán como objetivo minimizar el impacto y mantener el equilibrio del sistema. Estos patrones de interacción son mecanismos homeostáticos.

No ha sido últimamente que la validez del concepto de homeostasis aplicado en sentido estricto fue cuestionada. Speer (16) en 1970 juzga insuficiente el concep-

to de homeostasis familiar. En su opinión sería adecuado si el objetivo principal de la familia fuera la auto-regulación y la preservación del statu quo. Repara con acierto en que tal teoría no explicaría los fenómenos de creatividad, maduración y adaptación. Cita ciertos trabajos de Haley (7), Mishler y Waxler (13) que, separadamente, y a pocos años de distancia, parecen haber llegado a la misma conclusión: es en las familias consideradas enfermas que se encuentran con más frecuencia patrones de interacción rígidos mientras que en las familias llamadas normales, se nota más interrupciones, más fragmentación de la comunicación así como la disrupción de patrones de comunicación más frecuentes. De hecho en estas familias habría más espontaneidad, una mayor flexibilidad así como una libertad de intervención y de introyección en la conversación. Estas familias son más expresivas mostrando que a pesar de esas intrusiones sin embargo es transmitida una cantidad considerable de información. Speer se refiere al trabajo de Buckley (2) que habla del sistema, de sus componentes o elementos y de su medio ambiente. El sistema está compuesto por un número de elementos directamente ligados entre sí de manera más o menos estable y caracterizado por una organización entre estos distintos elementos. Estas relaciones son esencialmente flexibles. El medio ambiente está en interacción constante con el sistema y sus elementos, su input es siempre variable. Lo que define un sistema es su organización o sea la suma de las interacciones entre sus elementos. Si un elemento no influye o no es influido por otro, no están entonces en relación y no manifiestan organización, estructura o interacción alguna. La interacción entre los componentes se realiza a través de la comunicación que se transmite en dos niveles distintos: o sea un nivel informático y un nivel de definición de la relación. Los sistemas sociales tienen por función desarrollar mecanismos de integración y de asimilación del input con el objetivo de mantener la viabilidad del sistema.

Buckley sugiere que los sistemas sociales están abiertos hacia el interior y el exterior, o sea que reciben, asimilan e integran informaciones provenientes ya sea tanto del medio ambiente como del sistema mismo. El intercambio de informaciones tiene lugar a través de los mecanismos de feedback que Buckley siguiendo a Maruyama, divide en dos categorías: A) feedback negativo, activado por el error y tendiente a corregirlo y teniendo entonces como objetivo minimizar la desviación posible, y B) feedback positivo que también es activado por una desviación pero que tiende a acentuarla. En este caso al sistema tendría tendencia a asimilar el cambio sugerido por el medio ambiente más que a neutralizarlo. El feedback negativo tiene por objeto mantener la homeostasis y favorecer el status que así como resistir a todo cambio y llevar al sistema a un punto de equilibrio. Buckley piensa que los procesos de feedback positivos son los vehículos a través de los cuales los sistemas sociales se desarrollan. El los considera como morfogénicos. Para él, un sistema viable es ultraestable, es decir que debe ser capaz de operar cambios fundamentales en su estructura interna más bien que estables, es decir que trataría de mantener la integridad de su estructura. Un sistema ultra estable sería de organización más compleja. En efecto, él sostiene que los sistemas sociales se vuelven más complejos en las medida en que se vuelven más flexibles y viables. La complejidad del sistema deriva del aumento de autonomía de sus componentes y de su capacidad para influir en el comportamiento del sistema.

La teoría de la comunicación que se completa con la integración de la teoría de los sistemas, presenta a primera vista un cierto número de ventajas. Ante todo, su punto de partida es el conjunto del grupo es decir el sistema, cuyo funcionamiento, organización y diferentes características pretende describir. El individuo o el componente no es percibido más que en función del todo. Ella suscita cada vez más la esperanza en la posibilidad de aplicación de los conocimientos adquiridos a través de la teoría de los sistemas en los grupos sociales y más precisamente en la familia. En fin, sería posible que un cierto número de fenómenos observados pudieran ser eventualmente cuantificables o por lo menos una serie de leyes, si no es que una clasificación psicopatológica de

los sistemas familiares pudiera ser postulada. Esto resuelve de entrada la dicotomía individuo-familia, en favor de la familia y promete cambios en el nivel del individuo por la acción ejercida en el momento del análisis del sistema familiar. Desgraciadamente en este contexto y a pesar de las modificaciones que Buckley ha tratado de aportar hablando de la apertura del sistema en el interior de este último, es decir el rol de la información interna de un elemento que traduzca y retransmita a otro elemento que lo internaliza a su vez, no se ve bien el rol del intrapsiquismo individual y de la interacción de los intrapsiquismos en el seno de una familia. Es evidente que este grupo de teorías no se interesan por este problema. Y para terminar, habría que recalcar la contribución que ha aportado a nuestro conocimiento describiendo una serie de fenómenos que se sitúan más allá del individuo y que no se puede ignorar cuando se trata en la práctica cotidiana de curar grupos familiares.

* Traducido por

S.M. Molina y A. Canevaro

BIBLIOGRAFIA

- 1 — BATESON G., JACKSON D., HALEY J. & WEAKLAND J.: *Toward a Theory of Schizophrenia*. Behav. Sci., 1956: 251-264.
- 2 — BUCKLEY W.: *Sociology and Modern Systems Theory*. Engelwood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1967.
- 3 — ELLISON E.A. and HAMILTON D.M., 1949, *Hospital Treatment of Dementia Praecox*. Amer. J. Psychiat. 106: 454-461.
- 4 — EPSTEIN N.B.: *Mental Illness and Mental Health: Focus on the Family in "The Canadian Family"*, edited by K. Ishwaraw, 1971.
- 5 — G.A.P. Report N° 78, Vol VII, March 1970: *The Field of Family Therapy*, formulated by the Committees on the Family.
- 6 — GOFFMAN B.: *The moral Career of the Mental Patient*. Psychiatry, Vol. 22, N° 2.
- 7 — HALEY J.: *Research on Family Patterns: An Instrument Measurement*. Fam. Proc. 3: 41-65, 1964.
- 8 — JACKSON D.D. and WEAKLAND J.H.: *Conjoint Family Therapy*. Psychiatry 24: 30-45, 1961.
- 9 — LAING R.D.: *The Politics of Experience*. 1967. Penguin Books.
- 10 — LIDZ R.W. and LIDZ T.: 1949: *The Family Environment of Schizophrenic Patients*. Amer. J. Psychiat. 106: 332-345.
- 11 — LIDZ T., CORNELISON A., FLECK S. and TER Y D., 1957: *Intra Familial environment of the schizophrenic Patient: I - The Father*. Psychiatry 20: 329-342.
- 12 — LIDZ T., CORNELISON A., FLECK S. and TERRY D.: *The Intra Familial Environment of Schizophrenic Patients: II - Mental Schisms and Mental Skew*. Amer. J. Psych., 1957, 114: 241-248.
- 13 — MISHLER E.G. and WAXLER N.E.: *Interaction in Families*. New York. John Wiley & Sons, Inc, 1968.
- 14 — RISKIN J.: *Methodology for Studying Family Interaction*. Arch. Gen. Psych. 8: 343-348, 1963.
- 15 — SIEGLER M., OSMOND H. and MANN H.: *Laing's Model of Madness*. Bri. J. of Psych., Vol 115, N° 525, August 1969.
- 16 — SPEER D.: *Family Systems: Morphostasis and Morphogenesis, or "Is Homeostasis enough?"* Family Proc., Vol. 9, N° 3, 259-278.
- 17 — WATZLAWICK P., BEAVIN J.H., JACKSON D.D.: *Pragmatics of Human Communication*. W.W. Norton. New York 1966.
- 18 — WHITAKER C.A., FELDER R.E. and WARKENTIN J.: *Countertransference in the Family Treatment of Schizophrenia in Intensive Family Therapy*. Boszor-menyi-Nagy & Framo, Editors, 1965, Harper & Row Publ.
- 19 — WYNNE L., RYCKOFF I., DAY J. & HIRSCH S.: *Pseudo-Mutuality in the Family Relations of Schizophrenics*. Psychiat. 1958, 21: 205-220.
- 20 — ZUK G.H.: *The Go-Between Process in Family Therapy*. Family Proc., Vol. 5, N° 2.
- 21 — ZUK G.H. and RUBINSTEIN D.: *A Review of Concepts in the Study and Treatment of Families of Schizophrenics in Intensive Family Therapy*. Boszor - menyi - Nagy & Framo Editor, 1965, Harper & Row Publ.

La organización de las relaciones familiares

Juan Carlos Nocetti*

1. ¿Cómo surge la necesidad de tomar como objeto de estudio a las relaciones familiares?

El campo de la psicoterapia que abarca las enfermedades mentales más graves ha abierto senderos de investigación en diversas direcciones. La insatisfacción en cuanto a los resultados esperados en los tratamientos dió lugar a innovaciones de distinto tipo: El tratamiento de psicóticos, delincuentes, drogadictos, alcohólicos, borderlines o neuróticos muy graves comenzó en un momento a ser encarado desde su relación con el grupo familiar. Pudo percibirse que también el tratamiento de niños y adolescentes obligaba a una seria evaluación de las relaciones familiares en las cuales el paciente se encontraba comprometido. La necesidad de encarar modos de relación surgió en la mente de muchos terapeutas; pero era imprescindible contar con un bagaje conceptual que permitiera dar cuenta de los fenómenos que, al encarar de esta manera las conductas patológicas, se ponían de manifiesto. La noción de simbiosis fue incluido entre ellos, en la medida en que define un modo de relación que no puede comprenderse cabalmente desde uno sólo de sus polos.

¿Por qué no tomar entonces a estos modos "patológicos" de relación como unidad diagnóstica y terapéutica? Se inician entonces los tratamientos de grupos de personas relacionados con el llamado "enfermo mental", en forma conjunta. Estamos a mediados de siglo. Las resonancias técnicas, metodológicas y teóricas de esta actitud terapéutica sólo ha comenzado recientemente a ser aguilatada (2). La construcción de una psicopatología centrada en las relaciones familiares es un objetivo que se vislumbra en nuestro horizonte.

2) ¿Cuáles son las consecuencias teóricas de este modo de encarar la enfermedad mental?

Lo que comenzó siendo un mero recurso técnico fue transformándose paulatinamente en un modo de comprender la enfermedad mental. Esta forma de conocimiento fue haciendo posible observar hechos que hasta entonces no habían sido incluidos en ninguna teoría. Así, por ejemplo, en 1948, Frieda From Reichman acuña el concepto de "madre esquizofrenógena". La psicosis es pensada como el producto de una relación donde el enfermo mental es definido como "víctima" de ella. Pero aparece entonces otro problema: no existía ningún lenguaje científico capaz de describir y explicar tales sistemas de relaciones. Ningún modelo psicopatológico había sido lo suficientemente desarrollado como para dar cuenta de un sistema de unidades interactuantes. Comenzaron a utilizarse viejos conceptos que permitían pensar en términos de relaciones: las nociones de transferencia y contratransferencia fueron usadas por algunos para dar cuenta de la relación existente entre los miembros de una pareja. El concepto de identificación proyectiva dio lugar a su aplicación para comprender los intercambios producidos entre los miembros de una familia. Surgieron así nociones tales como "transferencias recíprocas", "proyecciones cruzadas", etc. la relación entre dos o más personas pudo ser pensada a partir de la suma de conocimientos que se tenían acerca del funcionamiento de cada una de ellas. Pero aún esto no era suficiente.

No fue fácil comprender que este cambio en el modo de percibir traía aparejado una nueva forma de pensamiento y con él la necesidad de reformular las premisas epistemológicas, las teorías y los recursos técnicos desprendidos de ellas; si es que se quería producir una teoría científica de las relaciones familiares.

3. ¿Cuáles son las premisas epistemológicas para la producción de una teoría científica de las relaciones familiares?

En primer lugar, el objeto de conocimiento deja de ser algo que pueda ser denominado aparato psíquico, está ahora constituido por un conjunto de ellos que a su vez se encuentran en interrelación. El concepto de sistema se perfila como fundamental en este tipo de estudios. Esto acarrea una severa restricción en cuanto a las explicaciones provenientes de una concepción lineal de la causalidad (del tipo "Víctima/victimario" por ejemplo), las categorías de determinación deben ahora dar cuenta de las relaciones existentes entre un conjunto de unidades interactuantes. La identidad de estas unidades deja de ser una propiedad de ellas, debe ser definida a partir de su ubicación dentro de un sistema. Debe establecerse además, una distinción entre lo observable empíricamente y lo determinante: la noción misma de inconsciente debe ser redefinida.

Pero no solo ello. Para que una teoría construida a partir de estos principios reúna los requisitos de una teoría científica debe encuadrarse dentro de las características del paradigma de la ciencia contemporánea. (3) Algunas de ellas son: una distinción radical entre un tipo de ordenamiento fenoménico y uno no-observable, ordenamientos diferentes entre sí; el carácter determinante del ordenamiento no-observable en la producción de fenómenos observables; el intento de establecer modos de articulación entre estos dos ordenamientos; la construcción de sistemas sintácticos o axiomáticos cuyas semánticas hacen referencia a los fenómenos observables; y, finalmente, la aceptación de la perturbación inevitable que el observador introduce en el sistema observado.

4. ¿Cuál es el concepto central para la producción de una teoría científica de las relaciones familiares?

La metodología desarrollada a partir de las ideas expuestas dio lugar a la necesidad de poner de relieve el estudio de los "modos de organización" de los conjuntos observados. Todo sistema se define por sus elementos y las relaciones que entre ellos se establecen. Estas relaciones no son arbitrarias, responden a una organización que no aparece en el plano de la manifestación, está implícita

en la red de relaciones y debe por lo tanto ser construida conceptualmente. Es esta organización la que hace posible la existencia y supervivencia del conjunto en una relación de mutua implicación. Ella representa el "modo de orden" (o, en términos más exactos la "entropía negativa") del sistema. Este modo de ordenado el nivel de complejidad de un sistema como el familiar- no puede ser aprehendido en su totalidad, pero pueden construirse modelos conceptuales que permiten lograr diferentes grados de aproximación a las reglas que lo mantienen. Las relaciones familiares que ese orden hace posible aparecen entonces bajo la forma de distintas configuraciones.

El Complejo de Edipo, por ejemplo, es un modelo que permite poner de manifiesto ciertas configuraciones de las relaciones parento-filiales. Pero con él vuelve a aparecer el problema: permite explicar uno de los aspectos en juego en la constitución del aparato psíquico, esto significa que está centrado en el sujeto. ¿Puede entonces dar cuenta de la constitución de la organización familiar? Tal como lo señala Bleichmar, este modelo no pretende caracterizar a la totalidad de las relaciones y por ello establece una distinción entre "Complejo de Edipo" y "Edipo estructural" (4) Se hace necesario dentro de este campo construir modelos que permitan acercarnos a la comprensión de la organización de las relaciones familiares, no del aparato psíquico de un sujeto. Modelos que tomen en cuenta el lugar que la familia ocupa en relación al orden de la naturaleza y al orden de la cultura, al tabú del incesto que es el modelo conceptual que los articula, que define las características de la organización familiar.

5. ¿Cuáles son las características de la organización familiar?

Pondré a consideración cuatro modelos conceptuales que permiten acceder a distintos niveles de la organización de las relaciones familiares. Corresponden a una forma de pensar la familia como intermediaria entre la naturaleza y la cultura. Como un sistema de transformaciones de relaciones biológicas en relaciones culturales, como un sistema de intercambio regido por el principio de reciprocidad y la polisemia de lo intercambiado. (5) Productos a la vez que productores de objetos culturales, las relaciones sexuales, los bienes económicos, los sistemas lógicos y las estructuras lingüísticas, cumplen un papel fundamental en la consolidación y perpetuación de los modos de intercambio productores de relaciones familiares.

Los modelos que propondré a continuación permiten una aproximación a cuatro de esos modos de intercambio. Corresponden al intercambio de mensajes, al intercambio de mandatos, al intercambio de mujeres y al intercambio de significaciones.

6. ¿Cómo se organiza el intercambio de mensajes?

El nivel de la organización más próximo a la conciencia posible de los miembros de un grupo familiar corresponde al sistema de comunicación. Se refiere al modo en que está organizado el intercambio de mensajes. Esta organización pone en juego un sistema lógico implícito, esto es, un sistema coherente de convenciones que establece el modo de asignación de significaciones y los usos y efectos esperados de este tipo de intercambios. El modelo teórico que permite dar cuenta de este modo de orden surge de la teoría de la información y de la semiótica.

Basicamente, el estudio de los sistemas de comunicación familiares, revela modos de resolver el problema planteado por la incertidumbre de los mensajes y por la necesidad de lograr acuerdos acerca de la información que de ellos puede inferirse, dado el doble carácter denotativo y connotativo que suponen. La posibilidad de utilizar expresiones metalingüísticas permite el abordaje exitoso de este tipo de problemas. Cuando existen impedimentos o prohibiciones para poner al servicio del comercio informacional este nivel del lenguaje, se crean las condiciones para la aparición de distorsiones semióticas (6): es decir, aquellas que generan desacuerdos no rotulados y desplazamientos tendenciosos difícilmente reversibles en la atribución de significaciones.

Modos básicos de organizar las experiencias son configurados a partir de estos hechos. Las familias construyen sistemas deductivos que les permiten explicar y explicarse lo que les pasa, regulando de esta manera el monto de información que pueden controlar. Construyen también normas y sistemas de valores que colaboran en la organización de esas experiencias. El conjunto de convenciones que organiza el sistema de comunicación familiar puede encontrarse a distancia variable con respecto al sistema de convenciones aceptado por la sociedad que los incluye. Ahora bien, ¿cuáles son las operaciones que les permiten compartir esos modos básicos de organizar las experiencias?

7. ¿Cómo se organiza el intercambio de mandatos?

Estos están contenidos en el sistema de las identificaciones. La identificación desde la perspectiva de las relaciones familiares es un mecanismo psíquico por medio del cual cada uno de los miembros de la familia realiza las operaciones tendientes a satisfacer el deseo de sus progenitores. En la medida en que es un proceso inconsciente no hay posibilidad de ejercer sobre él control alguno, a menos que se tome conciencia de sus determinaciones. Los miembros de las familias se ven impulsados a satisfacer demandas que no saben son ajenas. Por medio del sistema de las identificaciones se crean las condiciones que reproducen y perpetúan un modo de organización familiar. Lo prescripto y lo prohibido lo deseado y lo temido, se articulan en un sistema de mandatos denominados normas y valores. La identificación posibilita la constitución de dos instancias psíquicas: el Super Yo y el Ideal del Yo que definen los tipos de relaciones en prescriptos y prohibidos, en deseados y temidos. La articulación de los sistemas de mandatos familiares y sociales puede resultar conflictiva y la satisfacción de los deseos, o inalcanzables o realizables a un elevado precio para la estabilidad familiar.

Pero, ¿cómo se construyen estos modelos convencionales de mandatos?

8. ¿Cómo se organiza el intercambio de mujeres?

Diversos son los medios por los cuales el orden cultural logra imponer acuerdos en las convenciones. Uno de ellos es el sistema de parentesco. Este determina las modalidades de la relación de alianza y las actitudes entre los miembros de la familia. Lo que Freud descubrió poniéndose de manifiesto en el drama de Sófocles es una modalidad de la definición social del sistema de las alianzas. Este sistema niega la posibilidad de ser al mismo tiempo hijo/a y esposo/a de sus propios padres, prescribiendo al mismo tiempo una alianza matrimonial con quien será simultáneamente esposo/a y madre/padre de su hijo/a. La relación de alianza está fundada en un sistema de intercambio regido por el principio de reciprocidad por el cual cada uno debe dar pero recibe algo a cambio de lo que entrega (5). Las familias de origen forman parte de este contrato, quedan por lo tanto incluidas en la organización familiar, aun cuando puedan no estar presentes en su configuración manifiesta.

Esto significa que para que una alianza sea convalidada es necesario que se inscriba en un sistema de convenciones que la valide como reconocida como tal. Toda relación matrimonial pone en juego un sistema de parentesco ante quien los cónyuges deberán dar cuenta de la modalidad de su alianza. Este sistema de convenciones requiere la participación de una tercera instancia que queda investida del poder de autorizar la realización del deseo contenido en la alianza. Este tercero es siempre un cómplice (antagonista o aliado de esa realización). Puede ser cómplice de un pacto neurótico, de un pacto perverso o de un pacto psicótico entre los contrayentes (7). Rara vez estará al tanto de lo que convalida. Esta suele ser, desde los pacientes, la definición del papel del terapeuta.

En general son los hijos los encargados de poner de manifiesto las características del pacto sellado (frecuentemente a través de sus síntomas). Los padres temen por ello a los hijos: por lo que de aquel muestran a los demás y por el espejo de su propio pacto que éstos representan ante ellos. En ocasiones los hijos no saben cómo ocultar lo que sin proponerse exponen y comienzan también a sentirse en peligro frente a sus padres.

Podemos preguntarnos ahora cómo es posible obtener un registro de estos hechos.

9. ¿Cómo se organiza el intercambio de significaciones?

Toda familia posee un modo de organizar su universo semántico. El relato que realizan de los acontecimientos vividos en su historia familiar durante el transcurso de las entrevistas, pone de relieve un modo redundante de atribuir significaciones. Ese relato puede ser formulado porque existe un orden que lo hace posible. Una estructura permite articular las significaciones en juego. El relato nos hará saber que esta estructura se repite a lo largo de su historia, reproduciendo las mismas contradicciones, a veces latentes, a veces manifiestas, cuando una situación crítica ponga en peligro la estabilidad alcanzada.

El universo semántico define algunas de las significaciones básicas alrededor de las cuales se tejen los conflictos centrales de un grupo familiar. Se reafirman cuando una crisis aumenta el monto de angustia tolerable por sus miembros y rebasa los mecanismos de regulación, que mantienen la estabilidad del sistema, definiendo el núcleo de significaciones alrededor del cual se ordenan las distintas patologías de sus miembros. Estas no prosperan sino en ciertas condiciones y son éstas las que determinan el modo de producción patológica que tendrá lugar. Entre esas condiciones se encuentra el tipo de significaciones articuladas en la estructuración del universo semántico. Es posible construir, por reducciones a partir del relato manifiesto, un modelo constitucional de esas significaciones.

10. ¿Qué es entonces una "familia enferma"?

Una familia cuya organización limita la riqueza y diversificación de los intercambios presentando mecanismos de regulación excesivamente rígidos en su intento de mantener la supervivencia de un sistema constantemente amenazado en su estabilidad. De tal manera que ni los padres son víctimas de las conductas manifiestas de sus hijos, ni éstos de las de aquellos. Todos lo son de un modo de organización que no han creado y de cuya existencia no tienen conciencia, aun cuando contribuyan sin percatarse, a perpetuarlo. Estos modos de organización generan conductas habitualmente definidas como patológicas. Las conductas patológicas de los miembros de una familia son el modo de expresión de una organización patológica, cuyos modos de regulación de los intercambios resultan altamente restrictivos.

Los cuatro modelos descriptos (8) constituyen vías de acceso a esa organización cuya expresión manifiesta puede ser detectada a través de índices provenientes del sistema de los nombres propios, de la configuración del espacio y el tiempo familiares (9) y del tipo de distorsiones semióticas que en las sesiones se presenten.

Así como el orden de la naturaleza difiere del de la cultura aunque ambos forman parte del universo real, la determinación legal del mundo físico difiere de la determinación convencional del mundo de la cultura si bien ambas comparten su carácter determinante. Siglos de ciencia nos han convalidado que conociendo las leyes que determinan las relaciones entre los hechos observados es como podemos controlar y predecir los fenómenos. Nos han enseñado también que estas leyes no aparecen directamente a la percepción del investigador, sino que un largo esfuerzo logra en ocasiones ponerlas de manifiesto. A las leyes que rigen las relaciones entre los fenómenos naturales corresponden las reglas que regulan los fenómenos del orden cultural en su doble carácter determinantes y desconocidas.

Si bien no todas las familias concuerdan en esto, tomar conciencia del conjunto de convenciones que constituyen la organización oculta del sistema de sus relaciones es la única vía para lograr un control y una predicción de sus modelos de intercambio y poder actuar en consecuencia para transformarlos. Este proceso no es ni fácil ni rápido: las normas y valores conscientes son expresión

de mecanismos de regulación cuya misión es mantener la estabilidad del sistema amenazado en su supervivencia. De aquí que todo intento de modificación se enfrente con la resistencia que, no siempre conscientemente, los miembros de la familia opondrán a la acción terapéutica. Esta, por su parte, no está dirigida a modificar un sistema de relaciones -meta riesgosa y poco eficaz- sino a evitar la recreación en las sesiones de las condiciones que generan repeticiones y a ofrecer a las familias un contexto en el cual puedan pensar acerca de su modo de organización, acerca de las convenciones que regulan sus intercambios.

Este conjunto de convenciones será, inevitablemente, propuesto como modo de regular los intercambios que en las sesiones tengan lugar. Es este el correlato familiar del concepto de transferencia. La negación de estos hechos por parte del terapeuta conduce a una definición distorsionada de la relación terapéutica.

Los tratamientos familiares requieren entonces el tiempo necesario como para que una familia pueda enfrentar en óptimas condiciones la tarea de reorganizar sus modos de relación. Esta es una tarea lenta, dificultosa y no exenta de sufrimiento. Intentar modificaciones apresuradas, en un sistema familiar, sin contar con una teoría capaz de dar cuenta de las consecuencias de esos cambios es un ejercicio riesgoso. Los desastres ecológicos nos han puesto sobre aviso en este sentido. Y es todavía mucho lo que debemos aprender de las familias que, con valentía y honestidad, se animan a enfrentar el desafío siempre imprevisible de un tratamiento familiar.

RESUMEN

Las consecuencias teóricas, metodológicas, técnicas y epistemológicas de un enfoque terapéutico centrado en las relaciones familiares han comenzado sólo recientemente a ser aglutinadas. Lo que comenzó siendo un mero recurso técnico se ha ido transformando en un modo de comprender la enfermedad mental. Se hacen en este artículo algunas consideraciones acerca de las consecuencias teóricas de este hecho, de las premisas epistemológicas y del concepto central para la producción de una teoría científica de las relaciones familiares. En la medida en que una familia pueda ser pensada como un sistema de intercambio sujeto a una organización, es posible proponer un análisis de los distintos modos de intercambio. Se propone el estudio de cuatro niveles en los cuales esos intercambios se organizan: el intercambio de mensajes, el intercambio de mandatos, el intercambio de mujeres y el intercambio de significaciones. Se hacen finalmente algunas consideraciones acerca de la "patología familiar" y de su terapéutica.

NOTAS

1. Este trabajo es una síntesis del curso dictado a alumnos del tercer año de la escuela de Psicoterapia del Centro Médico Mansilla en el seminario sobre Relaciones Familiares. Las notas harán referencia a la bibliografía que permitirá profundizar conceptos que, dado el destino de este artículo, no han podido ser lo suficientemente desarrollados.
2. Confrontar a este respecto: BERENSTEIN, I.: *Familia y enfermedad mental*. Paidós, 1976.
3. Un mayor desarrollo de este tema se encontrará en: NOCETTI, J.C.: *Un paradigma científico para el estudio de las relaciones familiares*. Centro Médico Mansilla. Publicación interna N° 4.
4. BLEICHMAR, Hugo: *Introducción al estudio de las perversiones*. La teoría del Edipo en Freud y Lacan. Helguero Editores, 1976.
5. El estudio de "la pareja matrimonial como sistema de intercambio" ha sido realizado por I. BERENSTEIN en un trabajo de igual título publicado en ACTA, 1972, 18, 5.
6. Podrá obtenerse mayor información al respecto en: NOCETTI, J.C.: *Terapia Familiar y distorsiones semióticas*. Centro Médico Mansilla. Publicación interna N° 2.
7. BERENSTEIN, Isidoro: comunicación personal.
8. La aplicación de este modelo sobre un material clínico puede encontrarse en: NOCETTI, J.C.: *Diagnóstico de las relaciones familiares*. Un ejemplo clínico. ACTA, 1976, 22, 282.
9. Estos indicadores han sido propuestos en: BERENSTEIN, I.: *Familia y enfermedad mental*. Paidós, 1976.

Entrenamiento para pensar interaccionalmente

Carlos E. Sluzki*

Las instituciones no sólo expresan sus ideologías a través de afirmaciones explícitas de principios sino también se transmiten —a veces en direcciones opuestas a sus credos declarados— a través de sus organizaciones y programas.

Una "trampa" confronta aquellas instituciones que sostienen que una perspectiva interaccional sistémica es un componente natural de la medicina familiar y apuntan a entrenar sus graduados para que empleen un enfoque integrado "socio-psicosomático", "ecológico", "orientado en sistemas", "interaccional", para el cuidado de la salud. A fin de enseñar este punto nuclear la institución debe recurrir a seminarios o cursos organizados denominados "psiquiatría", "ciencia del comportamiento", "dinámica grupal", "proceso familiar" a incluir conjuntamente con el componente tradicional del curriculum tales como "medicina", "pediatría", "ginecología", etc. Sin embargo es precisamente en la organización de este tipo de curriculum, y en la aplicación de estas etiquetas como se perpetúa la misma dicotomía que la institución está tratando de superar. El mensaje "hay una cosa llamada psique y otra llamada soma; hay una cosa llamada individuo y otra llamada entorno", es el mensaje exactamente opuesto al que desea transmitir. Sin embargo resulta público y notorio vehiculado por la estructura y nomenclatura existente.

Subyaciendo a esta trampa está el hecho de que la epistemología relativista operacional implicada por la perspectiva interaccional sistémica choca contra el racionalismo positivista transmitido por el enfoque atomista más tradicional de las ciencias médicas. Sería apropiado afirmar que las instituciones de entrenamiento orientada a los sistemas intenten cambiar el marco epistemológico de muchas de sus entrevistas. Pero los cambios epistemológicos "no pueden lograrse enseñando el nuevo enfoque filosófico como tal (como no fue tampoco an-

(*) Family Health Center, San Francisco General Hospital, San Francisco CA 94 110 U.S.A.

teriormente enseñado) las epistemologías son transmitidas por la manera como la realidad y los conceptos están, organizados y transmitidos por medio del entrenamiento de la temática específica.

El propósito de este trabajo es comentar algunas características y algunos efectos seguidos por una de esas instituciones, el centro de Salud Familiar del Hospital General de San Francisco, sede del programa de residencia de práctica familiar de la Universidad de California en San Francisco, a fin de reducir la probabilidad de los mensajes contradictorios y proveer un medio de entrenamiento coherente con el cambio mencionado arriba.

La estrategia puede resumirse como sigue: a) enunciar la ideología del programa lo más claramente posible en todas las publicaciones tales como folletos de información público general y panfletos enviados a los aspirantes a la residencia; esos enunciados se usan como puntos de referencia en casos de cualquier ambigüedad subsiguiente pero también son frecuentemente discutidos y eventualmente modificados cuando se llega a una mejor formulación de los principios; b) evitar cualquier "paquete" específicamente etiquetado como "psiquiátrico", "conductal" o parecidos así como también en las especificaciones curriculares dado que su presencia crea una Gestalt perceptual que evoca la cualidad no psiquiátrica o no conductal adjunta al resto de los paquetes de la organización y curriculum; y al mismo tiempo c) centrar buena parte de las actividades no específicas de entrenamiento de la institución en temas como proceso familiar, comunitario, teoría de los sistemas, dinámica grupal y ecología humana.

Es innecesario decir que tales medidas no impiden una actitud dicotómica (psique o soma, individuo o ambiente) de parte de los nuevos entrenados. De hecho cuando se confronta la tarea de entrenar a los graduados para "pensar interaccionalmente" concebir al individuo como definiendo y siendo definido por sus relaciones con su familia y con otros miembros significativos de su medio y por su inserción en la comunidad en general, se hace claro desde el comienzo que aquellos estudiantes ya bien adelantados en su educación (residentes de práctica familiar e interna, etc.) no son territorio capaz de ser sembrados de novo. Más bien están ya educados o instruidos en conceptos derivados de un modelo médico tradicional o de un modelo psicológico intrapersonal los cuales tienden a canalizar las observaciones individuales y sus razonamientos a lo largo de líneas dicotómicas. Esta experiencia crea a la vez un refuerzo conceptual y perceptual que a la manera de una profecía auto-cumplida impide la oportunidad de incorporar nuevos enfoques alternativos. La adhesión de un nuevo grupo de entrenados a un conjunto dicotómico de conceptos no implica en sí mismo ninguna dificultad insalvable. Sin embargo, en un nivel más abstracto el punto de vista positivista tradicional parece estar acompañado por un aforismo absolutista del siguiente tipo: "éste es EL modo de ver y pensar las cosas" que no da lugar a la posibilidad de que estos eventos puedan observarse con igual plausibilidad desde diferentes ángulos y desde distintos puntos de vista científicos, pudiendo estas alternativas explicatorias optativas ser aplicadas a esos diferentes niveles de análisis. Esto plantea un serio problema adicional para el entrenamiento, porque hasta que este aforismo primario, a menudo irreconocible se modifique, no puede transmitirse una base epistemológica más amplia. Antes de poder aprender perspectivas optativas, un entrenado debe desaprender la convicción constrictiva de que no hay alternativas.

La noción relativista de que no hay perspectiva intrínsecamente más verdadera, sino que cada una debe ser válida desde su propio marco de referencia no es un estandarte fácil de llevar: mina la ilusión de certeza de cualquier perspectiva que deje sin reconocer enfoques alternativos. (1)

A la larga, los entrenados aprenden a utilizar instrumentalmente diferentes perspectivas y analizar diferentes variables de acuerdo con un esquema más adecuado a cualquier circunstancia dada. Pero como decimos más arriba aparecen como un sub-producto de su experiencia, de entrenamiento más que como un resultado directo de su contenido específico o secuencia de instrucción.

El proceso que ocurre puede ser categorizado como lo que el antropólogo Gregory Bateson denomina "deutero-aprendizaje", esto es, aprendiendo a aprender o aprendiendo un conjunto de reglas subyacentes en la situación de aprendizaje. Este concepto está relatado en las observaciones de H.F. Harlow que en un momento dado del proceso de aprendizaje el sujeto aprende a reconocer no sólo la propia información sino también el tipo de información a la que el caso concreto refiere, o el tipo de situación en que está el sujeto (este salto cualitativo corresponde al establecimiento de reglas de aprendizaje). ¿Qué quiere decir que este alto orden de aprendizaje aparezca como un sub-producto? Durante los primeros meses de su exposición a seminarios con familias y supervisión de grupos sobre diferentes problemas médicos con activa participación en proyectos comunitarios demostraciones in-vivo de entrevistas familiares e individuales orientadas interaccionalmente y participación en experiencias grupales, no se ve cambios en los entrenados. Ellos incorporan parte de la jerga y ganan habilidad en discutir hechos relevantes pero para todo propósito práctico ellos mantienen un punto de vista que se inclina hacia conceptualizar a los pacientes sobre la base de sus síntomas sin sopesar el impacto de los sucesos interpersonales como desencadenantes ni evaluar el efecto de la conducta sintomática en el ambiente del paciente.

Entonces, de pronto un cambio cualitativo es observable en su actividad, sus actitudes, sus percepciones y la lógica implicada en su razonamiento: comienzan a tratar secuencias de conductas más que individuos aislados; analizan síntomas no sólo en términos de sistemas de órganos involucrados sino en términos de sus efectos de significación en otras personas: los factores interpersonales dejan de usarse como último recurso diagnóstico (cuando todas las causas orgánicas han sido descartadas) y comienza otra instancia a ser evaluada como cualquier enfermedad es estudiada y tratada: contextualizan la patología en términos del organismo total más los sistemas en los cuales el individuo está incorporado: familia, comunidad y sociedad. Ellos también ganan en auto-experiencia como interactuantes, por ej. descubren que su propia participación en la corriente de interacción con los pacientes y sus familiares los afectan de importantes maneras. En resumen, las dicotomías no instrumentales aparecen abruptamente superadas. Una instancia de in-sight ha tenido lugar. (2). De aquí en adelante el entrenamiento se constituye en un modo de perfeccionamiento del enfoque; para mantener viva la capacidad de elección entre perspectivas y al mismo tiempo ganar nueva información acerca de la correlación dinámica entre las diferentes dimensiones de la realidad.

Nosotros mencionamos al comienzo de esta nota la posibilidad de presencia de conflictos, significados contradictorios entre los estamentos o las bases ideológicas explicitadas de una institución y los mensajes implicados en su estructura organizativa. A este respecto un claro isomorfismo puede ser observado entre un proceso grupal familiar y el proceso institucional. En cada caso existe un potencial patológico derivado de los mensajes conflictivos simultáneos inpuestos a diferentes niveles, especialmente cuando la naturaleza conflictiva de estos mensajes no es explicitada y cuando los receptores están en una posición dentro del sistema que los adscribe en un rol de "ser socializados" (el niño en el caso de la familia, el entrenado en el caso de la institución). En el nivel de la institución la "patología" en sus miembros puede ser representada por un alto nivel de deserción y de insatisfacción en su staff, impedimento en el proceso de aprendizaje e incremento de la confusión en los entrenados, o bien una recalitante adhesión no crítica de cualquier enfoque o perspectiva (lo cual puede ser otra manera de confusión). En los grupos familiares también como en las instituciones, los mensajes claros y no ambiguos pueden no llegar a resolver todos los problemas de sus miembros pero ayudan a soslayar algunos y resolver otros. En verdad esta no-ambigüedad es un prerrequisito clave para el crecimiento.

(1) Innecesario es decir que la ideología de una institución cubre un espectro amplio. La in-

tegración de la dimensión interpersonal al arsenal del médico de familia y la importancia del entendimiento de las fuerzas operativas sociopolíticas en la flia. como grupo y sobre sus miembros juega un importante rol que son sólo parte de las definiciones institucionales que constituyen la medicina familiar.

(2) Un factor que contribuye de manera importante a esta transición hacia "pensar interaccionalmente" o "pensar en familias" es aquel del modeling o sea aprender a través de identificaciones con el maestro lo que es probablemente un componente importante del aprender de persona - a - persona.

* Traducido por

Carlos Lorusso

Terapia Familiar:

"collage" clínico o ciencia clínica?

Gerald H. Zuk

Director Asociado del Departamento de Psiquiatría Familiar
Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute, Philadelphia U.S.A.

Esto es un resumen sobre mi punto de vista sobre la terapia familiar, aportando principios básicos de lo que considero una teoría y técnica explicativas. Hoy día los críticos dicen, con cierta justificación, que la terapia familiar es una amalgama de aspectos parciales de teorías y de técnicas que es más un arte que una ciencia clínica. En consecuencia, aquellos que reclaman una teoría y técnica integradas tienen la obligación de establecerla en términos simples y directos, invitando a una evaluación rigurosa. Los resúmenes ayudan a una tal meta cuando reducen las afirmaciones a principios básicos.

Me propongo resumir mi posición en el campo de la terapia familiar, una posición que considero que involucra una teoría y técnica explicativas. Mi resumen abarcará principios básicos, proposiciones, suposiciones e inferencias. Paradójicamente, es difícil a menudo, en un ensayo clínico, monografía o libro discernir los elementos básicos que subyacen a una teoría y técnica. Tal material puede contener afirmaciones inconsistentes o contradictorias que debido al método de exposición, no son aparentes. Por ejemplo, hay una pretensión en los últimos años, de algunos estudiosos de la terapia familiar que (obviamente influidos por las nociones psicoanalíticas) insisten todavía en ser trabajadores orientados en sistemas. Esto ha resultado en una corrupción del término "orientados en sistemas", al punto de ser más o menos desprovisto de significado e incluso confuso.

Quisiera resumir los principios que me parecen reflejar más o menos acertadamente mi punto de vista en terapia familiar, ofreciendo así al lector una oportunidad de ver su consistencia e inconsistencia, sus errores u omisiones, la validez de las afirmaciones y su capacidad para generar hipótesis significativas.

Espero, al hacerlo, alentar a otros para duplicar mi esfuerzo. A mi juicio, esto sería un paso constructivo en el proceso de comparar los valores sostenidos por varios autores. Aplacando los reclamos y poniéndolos en una forma resumida, sería más fácil hacer comparaciones constructivas, pudiendo ayudar a desalentar el criticismo hacia la terapia familiar: a saber, que consiste en una mezcla de aspectos parciales de técnicas o de teorías, expuesta por una variedad de "escuelas" cuyos seguidores fervientes se han excedido, a veces, porque ignoran o descuidan sugerencias que sujetan las afirmaciones a pruebas rigurosas. Debido a la presencia de tales defensores, el campo se ha vuelto quizás indebidamente politizado.

Recientemente, en las principales revistas psiquiátricas, prominentes portavoces de la psiquiatría como Brown (1976) y Marmor (1975) señalaron que en la psicoterapia lo que realmente cuenta es el buen criterio y experiencia del terapeuta, no la teoría o la técnica. Brown, en particular, dice que "ha habido un incremento de conocimientos en el área de terapia de pareja y del grupo familiar... la variable crítica hoy es la misma de hace veinte años —la madurez y prudencia de la persona que ayuda". (P.493). En un artículo reciente de un diario distribuido a la mayoría de los psicólogos en USA, Keebler (1976), un periodista, insiste en transmitir la impresión de que la terapia familiar es una mezcla hecha por terapeutas bien intencionados pero muy amplios. El principal mensaje de Keebler a los principiantes es una advertencia: "que el que compra tenga cuidado".

Hay más de una pequeña cuota de verdad en lo que los críticos dicen. Glick y Kessler (1975) y Olson (1975) citaron los errores metodológicos y las deficiencias conceptuales en la investigación en terapia familiar. Hay una tendencia a apoyarse en un caso exitoso para sostener una teoría o técnica particular. Estas deficiencias, de hecho, tendieron al desarrollo de lo que podría llamarse más adecuadamente técnicas y teorías parciales. A pesar de ser, en algunos aspectos, un libro útil que refleja puntualmente una rica diversidad de puntos de vista, uno no puede evitar leer un libro tal como *EL LIBRO DE LA TERAPIA FAMILIAR*, de Ferber, Mendelsohn y Napier sin estar de acuerdo con los críticos.

Como alguien que ha estado involucrado, durante los últimos quince años, en la tarea más bien frustrante de intentar el desarrollo de una teoría explicativa de la terapia familiar (Zuk, 1972) y un método para enseñarlas (Zuk, 1975) que no requiere que el estudiante emule mi estilo personal o idiosincrasia, me concierne profundamente los esfuerzos por mostrar el campo como un simple arte. Sin negar la importancia del arte, creo que es un deber someter los variados conceptos y técnicas emergidos a una más rigurosa investigación, y que aquellos considerados inadecuados, deficientes o ineficientes deberían ser descartados. Durante los últimos años he sometido mi punto de vista —aunque no sin algún temor— a una rigurosa prueba hecha por dos estudiosos, Garrigan y Bambrick (1975, '76), y creo que son las más cuidadosamente controladas series de estudios sobre el tema, que hay a nuestro alcance. Informes de casos exitosos han sido útiles, aun en instancias en que la evaluación del éxito ha sido hecha por el terapeuta mismo. Pero lo que hoy se necesita especialmente en el campo es precisamente el tipo y calidad de investigación llevada a cabo por Garrigan y Bambrick. Utilizando un diseño rigurosamente experimental, controles adecuados y medidas válidas y confiables, pudieron en breve tiempo entrenar estudiantes graduados para dirigir mi técnica de terapia familiar. Estos "terapeutas" dirigieron luego una serie de entrevistas de tiempo limitado, con familias con chicos en escuelas para sujetos con perturbaciones emocionales. En estudios repetidos, grupos de chicos emocionalmente perturbados mostraron mejoras en la conducta en clase y en los hogares; y padres e hijos mostraron mejores actitudes hacia cada uno. Los "terapeutas" no se transformaron en terapeutas de familia totalmente

experimentados, pero pudieron asimilar algunas bases de un método especial en un tiempo relativamente breve y utilizar lo aprendido en beneficio de las familias de sus pacientes.

Pienso que estudios tales como los de Garrigan y Bambrick son absolutamente esenciales para el progreso en este campo. La defensa ardiente de sus puntos de vista, hecha por miembros de distintas "escuelas" ha llevado la polémica a fojas cero y la verosimilitud debe ahora ser establecida por una evaluación rigurosa.

Lo que sigue a continuación es un resumen de mi punto de vista que contiene lo que creo son los elementos esenciales. Espero que sirva como estímulo a otros para hacer lo mismo, de modo que las comparaciones críticas puedan hacerse sin las complejidades o desvíos que largos ensayos, monografías o libros, a menudo, interponen entre lector y autor. También espero que pueda estimular a los investigadores a someter a prueba suposiciones sostenidas como básicas o fundamentales por sus autores. Sólo de este modo podrá ser sostenida sobre bases científicas, la validez de afirmaciones hechas por varias "escuelas".

I. ALGUNAS PROPOSICIONES GENERALES:

- A) La familia es un conjunto de valores derivados, en gran parte, de las instituciones de las cuales afirma ser miembro, tales como la Iglesia, asociaciones civiles y fraternales, sindicatos, etc. Sus filiaciones étnicas, raciales, religiosas y vecinales son consideraciones importantes para definir su "identidad" y por tanto al terapeuta hará esfuerzos en descubrirlas y generalmente sostenerlas.
- B) El terapeuta está interesado en la historia familiar, pero apunta a las actividades y funcionamiento familiar corriente. Su modo de vinculación con la familia puede ser intrépido y de confrontación, o reservado y no directivo, dependiendo de su evaluación del status de la familia, por ejemplo, sus antecedentes, sus expectativas con la terapia, el número de entrevistas hechas, la naturaleza de la relación patológica que existe y el progreso logrado.
- C) El terapeuta está interesado en todos los conflictos sufridos por la familia, pero se centra en tres: 1) aquel entre marido y mujer; 2) aquel entre padres e hijos; 3) aquel entre el núcleo familiar y otros grandes grupos sociales, tales como el vecindario.
- D) el terapeuta utiliza todas las técnicas terapéuticas establecidas o estrategias para lograr cambios útiles, pero enfatiza el conjunto especial de poderes a su alcance porque está trabajando con un grupo único, a saber, la familia. En las próximas secciones, ese conjunto será definido.

II. FUNCIONES DEL ROL DEL TERAPEUTA:

- A) **El Mediador:** El terapeuta ejerce poder como un mediador para facilitar la comunicación entre los miembros de la familia, para tratar conflictos y para establecer límites.
- B) **El Partidario:** El terapeuta ejerce influencia poniéndose de lado de algunos miembros de la familia, contra otros en una discusión, o de lado de la familia como un todo, o en contra, en una discusión con un grupo de afuera, como el vecindario.
- C) **El Celebrante:** El terapeuta ejerce influencia como celebrante, ofreciéndose o siendo solicitado para actuar en un suceso considerado importante por la familia, tal como un divorcio, una pérdida de empleo, o la deserción del hogar de algunos de sus miembros.

III. ESCALA DE VALORES EXPRESADOS POR EL TERAPEUTA Y LAS FAMILIAS:

A) Ni el terapeuta ni la familia están libres de tener su propia escala valores. Pueden ser categorizados como sigue: 1) valores de "continuidad"; ó 2) valores de "discontinuidad". Los valores de "continuidad" sostienen la bondad de la compasión, justicia, igualdad y afinidad, por ejemplo, entre generaciones o vecinos. Los valores de "discontinuidad" sostienen la bondad de sistemas de controles, de abordajes racionales de los problemas, de códigos legales, de procedimientos de orden y disciplina. Cuando hay conflicto en la pareja, las mujeres sostienen habitualmente los valores de "continuidad". En los conflictos entre padres e hijos, éstos sostienen habitualmente los valores de "continuidad". En los conflictos entre el grupo familiar y el vecindario, el núcleo familiar sostiene, generalmente, los valores de "continuidad". Así los valores no se relacionan casualmente en estos conflictos, en general, y el terapeuta, según su evaluación, puede ponerse del lado de o en contra de los valores de "continuidad" o "discontinuidad" expresados en el conflicto familiar.

IV. RELACIONES PATOGENICAS EN LAS FAMILIAS:

A) Se refiere a aquellos procesos negativos que el terapeuta observa directamente en las entrevistas familiares tales como el silenciar a miembros por parte de otros, amenazas encubiertas o directas, el uso de chivos emisarios, u otros esfuerzos sistemáticos para controlar o manipular la conducta de los miembros que a juicio del terapeuta son destructivos para el funcionamiento de uno o todos los miembros.

B) La meta general del terapeuta es reducir las relaciones patológicas, o eliminarlas, usando esos roles descriptos en la Sección II, mientras expresa diferenciadamente aquellos valores descriptos en la Sección III. Las relaciones patológicas tienden a irrumpir después de un callejón sin salida cuando se rivalizan valores. Así, el terapeuta también debe señalar los conflictos subyacentes entre valores.

V. ALGUNOS TIPOS Y METAS PRACTICAS EN TERAPIA FAMILIAR

A) Hay cuatro tipos de contratos de las familias con el terapeuta: 1) con el propósito de solucionar una crisis, con duración de 1 a 6 entrevistas; 2) con el propósito de una terapia breve, de 10-15 entrevistas; 3) con el propósito de una terapia a mediano plazo, de 25 - 30 entrevistas; 4) con el propósito de una terapia a largo plazo, de 40 o más entrevistas.

La meta de cada una es en algún modo diferente —desde la reducción de tensión en (1) hasta el incremento de solidaridad familiar pero con una mejor aceptación de las libertades individuales en (4).

B) Mientras que el esfuerzo del terapeuta es evaluar y reducir o eliminar las relaciones patológicas familiares, sus metas prácticas son las descriptas anteriormente —reducción de la tensión, del conflicto, mejora de la cooperación familiar, etc. Estos cambios se evalúan en un nivel individual, no familiar, por dos razones principales: 1) porque las familias evaluarán el éxito de la terapia en términos de sus efectos en los miembros individualmente; 2) porque medidas válidas, confiables de cambio familiar son todavía inexistentes.

VI) FASES DE LA TERAPIA FAMILIAR

A) El período de contrato, que dura aproximadamente las 4 ó 5 primeras entrevistas, es la primera fase de la terapia familiar porque es la primera impresión crítica entre el terapeuta y la familia.

Es en efecto, el prototipo de todas las discusiones críticas, y cada subsiguiente

te período que surja puede ser considerado una fase de la terapia.

B) La terminación es el último hecho crítico en la terapia que, como el contrato, contiene el potencial para el movimiento terapéutico significativo y positivo. Sucede cuando el terapeuta o la familia, en conjunto o unilateralmente, decide que una meta satisfactoria ha sido alcanzada o que tal meta es inalcanzable en las circunstancias presentes.

C) Como la mayoría de las familias limitan el tiempo que el terapeuta tiene para trabajar a seis meses o menos, es de escaso o ningún valor para el terapeuta distinguir entre las impresiones críticas, cuáles son las "más profundas" y cuáles las "superficiales".

VII. LIMITACIONES Y CONTRAINDICACIONES

A) Hay numerosas limitaciones en terapia familiar, así como en otras psicoterapias, comenzando por la simple falta de motivación para aparecer en las sesiones, que a menudo proviene de la falta de disposición para hacerse cargo del esfuerzo del proyecto. Ciertos modos de presentación de los problemas no tienen perspectivas favorables, por ejemplo, en familias con un miembro alcohólico o un drogadicto crónico. Familias con un único padre con hijos muy pequeños no son a menudo favorables porque se convierte muchas veces en una terapia individual del padre en presencia de sus hijos. B) Mientras que hay numerosas limitaciones prácticas, hay sólo un principio de contraindicación que es evocado en aquellas instancias donde el terapeuta es atrapado para servir como agente de castigo, con el propósito de llevar a cabo una acción disciplinaria, tal como ocurre de vez en cuando en un juicio o en la escuela, cuando se aplica una sanción disciplinaria.

En tales circunstancias, encargarse de una terapia es producir más daños que beneficios.

BIBLIOGRAFIA

- Brown, B.S. - *The Life of Psychiatry*. American Journal of Psychiatry. 1976. 133. 489-495.
 Garrigan, J.J. & Bambrick, A.F. - *Short-term family therapy with disturbed children*. Journal of Marriage and Family Counseling. in press.
 Garrigan, J.J. & Bambrick, A.F. Family therapy for disturbed children: Some experimental results in special education. Journal of Marriage and Family Counseling. in press.
 Glick, I. & Kessler, D. - *Marriage and Family Therapy*. New York: Grune & Stratton. 1975.
 Keebler, N. - *Family Therapy: A profusion of methods and meanings*. APA Monitor. 1976.
 Marmor, J. - *The nature of the psychotherapeutic process revisited*. Canadian Psychiatric Association Journal. 1975. 20. 557-565.
 Olson, D.H. - *Marital and Family Therapy: A critical overview*. In A.S. Gurman, & D.G. Rice (Eds.), *Couples in conflict*. New York: Behavioral Publications. 1972.
 Zuk, G.H. - *Family Therapy: A triadic-based approach*. New York: Behavioral Publications. 1972.
 Zuk, G.H. - *Process and practice in family therapy*. Haverford, PA: Psychiatry & Behavior Science Books. 1975.

* Traducido por

Lic. María J. Mondet

Implicancias de los estudios de la familia para el tratamiento de la esquizofrenia

Loren R. Mosher, M.D.

*Jefe del Centro de Estudios de la Esquizofrenia.
Instituto Nacional de Salud Mental U.S.A.*

1. INTRODUCCION

Para entender el punto central de este trabajo es necesario definir lo que entiendo (para los propósitos de esta discusión) por esquizofrenia, estudios de familia, y sus "implicancias".

A. Definiciones

1. **Esquizofrenia:** Aunque lo que es corrientemente rotulado como "esquizofrenia" no parece constituir una entidad válida de enfermedad, tal como el término enfermedad es usado por otras ramas de la medicina (ver Fabrega (1), Szasz (2), Spitzer y Fleiss (3) y Mosher (4) para más completa discusión acerca de este término), es posible todavía —para los propósitos de discusión y específicamente evitando su reificación definir ciertos tipos de conducta como ubicables dentro de este rubro tal como es usado corrientemente. Esta definición tendrá el valor heurístico de permitirme excluir muchas clases de conducta humana de la consideración que aquí hago. Para los propósitos de esta discusión, asumiendo el punto de vista **individual** de la medicina, las conductas que resultan rotuladas como "esquizofrenia" son principalmente dificultades en el proceso de comunicación. Esta aproximación a su definición me permitirá también relacionar más fácilmente los hallazgos en el estudio de la familia con características de pacientes individuales.

5600 Fishers Lane. Rockville Maryland 20852 U.S.A.

Presentado en el Symposium de Esquizofrenia, patrocinado por el Colegio Real de Psiquiatras (Sección Irlandesa), en Dublin, Irlanda. Octubre de 1975.

Las opiniones expresadas en este trabajo pertenecen al autor y no necesariamente representan una posición oficial del Instituto Nacional de Salud Mental.

La Investigación transcripta aquí es apoyada por NIMH Grant 20123.

En Irish Med. Journal Octubre, 1976, n° 69 Publicado con permiso del autor.

¿Qué entiendo por esquizofrenia como una perturbación de la comunicación? Reducido a su nivel más simple, las personas a quienes se les pone este rótulo son precisas y llanamente difíciles de entender. Sus oraciones pueden no tener sentido lógico (perturbación en el pensamiento); pueden tomar posiciones contradictorias simultáneamente (ambivalencia); pueden establecer difícilmente contacto (autismo) y pueden aparecer sintiendo de modo contrario a lo que esperamos de ese particular contenido verbal (disociación afectiva). Pueden tener creencias que sostienen firmemente, para las cuales no podemos encontrar una base en nuestra propia experiencia de realidad (ilusiones). Finalmente, pueden relatar o escuchar cosas para las cuales no encontramos una evidencia válida en nuestra propia experiencia perceptual (alucinaciones). Aunque los cuatro síntomas primarios y los dos secundarios de Bleuler se basan principalmente en la evaluación de la conducta verbal, pueden también estar acompañados de conductas motoras inusuales. En suma nos queda la impresión de alguien que parece extraño, a quien no podemos entender y que realiza cosas que no concuerdan con nuestras expectativas de conducta en ese contexto social.

Chesterton, un inglés convertido al catolicismo, captura la esencia de esta visión de la locura, en su BALADA DEL CABALLO BLANCO (5):

*"Para los grandes Celtas de Irlanda
son los hombres que Dios hizo locos
pues todas sus guerras son alegres
y todas sus canciones tristes."*

2. Estudios acerca de la familia:

Como intento delinear los descubrimientos clínicos útiles en el estudio de la familia, he incluido tanto los estudios clínicos descriptivos como los experimentales. Aunque mi principal interés es investigar, encuentro los estudios descriptivos más útiles que los datos experimentales, en la práctica clínica diaria. No he requerido que los estudios sean metodológicamente rigurosos para su inclusión. Además, por propósitos de simplificación, he incluido sólo un término aún cuando varios han sido utilizados para describir procesos familiares similares. No pasaré revista a esos estudios exhaustivamente, ya que están al alcance del lector (6-8), ni tampoco a aquellos estudios sobre la eficacia de la terapia familiar como técnica de tratamiento. También estos han sido publicados en otro lugar (9-10). Conozco y he tomado en cuenta en mi lectura y traducción de tales estudios, los problemas que obstruyen la interpretación de los datos de estudios sobre la familia. Tres de ellos requieren una breve explicación: (1) Dificultades en las atribuciones de etiología; (2) Preguntas con respecto a la especificidad de los hallazgos en esquizofrenia y (3) Cuestiones socio-políticas planteadas por estos estudios.

Los estudios originales sobre la familia fueron concebidos como apuntando a la etiología. Sin embargo, recientemente, con el desarrollo de una cada vez más sofisticada metodología, las dificultades inherentes a la atribución de significación causal a los hallazgos en familias con un esquizofrénico manifiesto se han vuelto más ampliamente conocidas. La incapacidad de los estudios tradicionales de familia para distinguir las respuestas de las familias a perturbaciones en uno de sus miembros, de las causas básicas de esta perturbación ha conducido a muchos investigadores al estudio prospectivo de individuos con alto riesgo para el desarrollo de la esquizofrenia.

Un segundo hecho relacionado con la interpretación de estos estudios es la cuestión de la especificidad de las diferencias encontradas entre esquizofrénicos y grupos de control para esquizofrenia per se. Esta cuestión debe ser suscitada porque son muchos los estudios de familia que comparan familias de esquizofrénicos con familias normales donde uno no puede estar seguro si las diferencias encontradas podrían ser ciertas con respecto a cualquier familia con un miembro hospitalizado psiquiátricamente, cuando se comparan con familias

normales. Afortunadamente, como lo puntualizó Jacob (6) en su reciente análisis, parece que el grado de dificultades en la comunicación, encontradas en familias esquizofrénicas no se encuentra en otros grupos psiquiátricamente enfermos. Sin embargo, también puntualiza que hallazgos positivos acerca de familias esquizofrénicas en las áreas afectivas, de conflicto y de dominancia no han sido mostrados como específicos de esas familias como grupos psicopatológicos. A pesar de la especificidad del modelo de comunicación no podemos actualmente atribuirles una significación etiológica definida ya que muy bien podrían ser respuestas parentales a un chico enfermo. Si la significación causal puede ser establecida, nos queda todavía intentar la identificación de sus orígenes y desarrollo en el tiempo; sea que fueran aprendidos y transmitidos como el lenguaje, o fuertemente influidos genéticamente como el color de los ojos. Queda como una cuestión abierta para su dilucidación. A pesar de que la investigación tradicional sobre la familia nunca pueda identificar definitivamente los factores etiológicos familiares, puede sin embargo contribuir a nuestro conocimiento y como instrumentos terapéuticos, elucidando modelos interaccionales familiares que precipitan o ayudan a mantener la enfermedad en el paciente.

Un tercer hecho frecuentemente suscitado en los estudios de familias, es que son destinados a "culpar" a los padres. Creo que esta sobresimplificación irreal existe, en parte, por influencia de un pensamiento sobresimplificado preexistente entre investigadores de familias. Esto los condujo a relatar resultados de maneras que podían ser interpretadas como culpógenas. Sin embargo, la investigación más reciente sobre familias parte de la noción de sistema. Es decir, la familia es conceptualizada como un subsistema social interactuando constantemente, en donde la conducta de cada persona debe ser reflejada en, y modificada por la respuesta de otros en el sistema. Este modelo encaja por cierto en la experiencia de cada uno en su propia familia. Así, no se pueden hacer afirmaciones causales simplísticas; por el contrario, las afirmaciones sobre la interacción familiar deben verse en términos de un sistema que opera constantemente y que puede, con el tiempo, resultar en un cambio del equilibrio familiar. Este proceso es análogo al que ocurre en los equilibrios químicos, cuando se dan los cambios de concentración, temperatura, etc. Desafortunadamente, no tenemos un lenguaje adecuado para manejar fácil y consistentemente la noción de sistema. En consecuencia mis descripciones podrían ser injustas con este punto de vista.

El hecho culposos puede también suscitarse —a menudo por padres con un hijo perturbado— como un acto más estrictamente socio-político. Es decir, los estudios de familia tocan el sentimiento de culpa que la mayoría de los padres sienten naturalmente cuando un hijo sufre un acontecimiento adverso de cualquier índole. Cuando ellos mismos escuchan ser descriptos como habiendo interactuado con su hijo de una manera que pueda vincularse a esta conducta extraña, llegan a sentirse aún más culpables y "censurados". Esto empeora con nuestra terminología psiquiátrica, generalmente peyorativa en su connotación. El intento de inducir la culpa en el clínico o investigar por "acusarlos", permite que el foco se desplace de los modelos de interacción familiar mientras que al mismo tiempo, se permite a la familia y otros situarse en un desconocimiento de lo que sucede realmente, para invalidar los hallazgos clínicos o de investigación bajo bases esencialmente morales; por ejemplo, han sido malos porque invadieron la privacidad familiar, bajo el pretexto de tratar de ayudar y luego los acusan por lo que han encontrado! Los hallazgos pueden también ser entendidos como socavando la familia como institución social —claramente un acto inmoral para alguien que reclama ser un científico objetivo o un clínico que ayuda. Como haré notar luego, desplazar el foco de discusión e invalidar las ideas de otros, como he descrito aquí, son dos modos interaccionales frecuentemente descriptos en familias con un hijo esquizofrénico.

3. Implicancias:

Mi intención es relatar lo que se ha aprendido de los estudios de familia y

sobre ciertas conocidas características de pacientes esquizofrénicos individuales, de sus relaciones, derivar principios prácticos para el tratamiento de pacientes individuales y sus familias. Me responsabilizaré de la selección de los hallazgos de estudios de familia para ser aquí incluidos, así como de la selección de características de pacientes individuales con los cuales creo que aquellos se relacionan. He incluido sólo los hallazgos y características que encontré válidos en mi propia experiencia clínica.

2. DATOS FAMILIARES

A. Antecedente histórico

La familia no alcanzó el exámen psiquiátrico hasta el final de 1940 y el comienzo de 1950, unos cuarenta años después que los trabajadores sociales y las clínicas de orientación pediátrica habían comenzado a considerarla como un aspecto importante en el tratamiento de pacientes individuales. La monografía de Frieda Fromm-Reichmann (1948) sobre la madre esquizofrenizante —base conceptual de la posterior hipótesis sobre la familia esquizofrenizante— fue la primera en recibir una amplia atención dentro de la literatura psiquiátrica. Desde entonces se han llevado a cabo trabajos de investigación sobre y con familias en un número de centros americanos, principalmente Palo Alto, Bethesda, Philadelphia, New York, Boston, Denver y Gavelston: importantes contribuciones también han sido hechas por un grupo de Londres.

Una principal consecuencia del estudio de la familia en la psiquiatría contemporánea ha sido la ampliación de sus "perspectivas" conceptuales. Antes focalizados casi exclusivamente en la patología intrapsíquica del paciente esquizofrénico individual, los psiquiatras consideran hoy cada vez más relevante el contexto familiar del sujeto afectado.

El argumento de que el paciente puede ser tratado completamente marginado de su medio se ha vuelto prácticamente indefendible. De hecho, algunos psiquiatras ya no conceptualizan el problema de la "esquizofrenia" como residiendo en el paciente designado sino como penetrando y quizás surgiendo de su familia y el contexto social más amplio. Así, para ellos, el elemento importante en la terapia no es el paciente individual ni siquiera la diada psicoterapéutica, sino la familia entera del paciente y la red social. En la terapia de red (11), por ejemplo, pueden ser vistas simultáneamente 30 ó más personas. Algunos teóricos ven esta expansión del foco de lo que concierne a la psiquiatría, como conduciendo inevitablemente a la conceptualización de la esquizofrenia como una perturbación no de la persona sino del grupo social, abarcando múltiples contribuyentes y múltiples personas afectadas. Así, la familia ha penetrado, en menor o mayor grado, en la conciencia de los terapeutas que sostienen variadamente que la familia no puede ser dejada de lado en el tratamiento o que debería ser el objeto del tratamiento. Pero sea visto como un factor preeminente o coadyuvante la familia ha emergido, sin poder negarse, como un elemento a ser considerado en el tratamiento de pacientes esquizofrénicos.

B. Características individuales y familiares (Gráficos 1-3)

Como clínico; además de la perturbación en la comunicación ya descripta, veo al individuo rotulado esquizofrénico como caracterizado por una baja autoestima, un pobre o ausente sentido de sí mismo, una deficiente formación de identidad, sobrecargado con estímulos, altamente perturbado, ansioso, carente de afecto, lábil afectivamente y como sintiéndose sin fuerzas para controlar su propio destino.

¿Cuáles son pues los hallazgos en la familia que parecen vincularse con estos índices clínicos (incluyendo los problemas de comunicación) de los pacientes

esquizofrénicos individuales?. La baja autoestima en el paciente individual parece estar relacionada con su rol histórico como el miembro de la familia "malo" (12), "débil", "dependiente" (13). El fenómeno de baja autoestima está relacionado con la pobre identidad y sentido de sí mismo que considero central en la psicología de la esquizofrenia. La confusión característica del esquizofrénico acerca de quién es él puede provenir de haber sido puesto, por su familia, en un rol no elegido por él. Contribuyendo con esta hipótesis hay relatos frecuentes (12, 13) de una fuerte tendencia a la proyección —la atribución de ideas y sentimientos propios a otros— en los miembros de familias esquizopresentes. Muy a menudo, el "malo", irracional, "débil" en la familia debe soportar el gran peso de sus padres y hermanos "sanos" y de sus proyecciones no tan sanas. Su sentido de sí mismo es debilitado adicionalmente por el grado marcado de invalidación y no reconocimiento encontrado a menudo, en estas familias (14, 15). Invalidación o descalificación es un término usado para describir cómo, en el curso de la interacción una persona puede decir algo que indica abierta o encubiertamente que no cree los sentimientos y pensamientos expresados por otra persona —como por ejemplo, cuando, "Estoy enojado contigo" evoca la respuesta, "No, no lo estás" "Estás triste". En el curso de la interacción social habitual, nosotros (normalmente) esperamos de nuestros compañeros que reconozcan que hemos dicho algo, o que se nos escuche. La interacción en las familias esquizofrenizantes, sin embargo, se caracteriza por la infrecuencia con la que los miembros de la familia reconocen a cada uno, lo toman en cuenta. No es difícil entender cómo el sentimiento de sí mismo de alguien en crecimiento puede ser perjudicado cuando sus percepciones, pensamientos y sentimientos son mal codificados o ignorados por aquellos que son importantes para él.

Las perturbaciones perceptuales, cognitivas y de atención ahora reconocidas como características de muchos pacientes esquizofrénicos, están de acuerdo con los relatos de comunicación confusa e irracionalidad en familias esquizopresentes (15), la inhabilidad de estas familias para compartir un foco de atención o atender juntamente a una tarea (16), y su rol en el proceso de "mistificación" (12). Así, se ha encontrado en los padres de esquizofrénicos manifestaciones de perturbaciones cognitivas, muy a menudo sólo cuantitativamente diferentes de aquellas encontradas en el paciente señalado. Es raro sin embargo en estudios de familias de esquizofrénicos, encontrar que alguno de los padres haya tenido él mismo hospitalización psiquiátrica.

Continúo impresionado por la validez clínica del concepto de R.W. White (17) de falta de competencia y sentido de eficacia exhibido por personas esquizofrénicas. Estos fenómenos se asemejan a las descripciones en la literatura sobre la familia del paciente señalado donde éste ha sido habitualmente requerido para cumplir las necesidades de sus padres, más que actuando para definir y cumplir sus propias necesidades.

Este modelo interaccional parecería privar al sujeto en crecimiento, de la oportunidad de probar varios roles y basado en su éxito o fracaso, desarrollar estrategias apropiadas. En nuestras interacciones con el medio, aprendemos enfrentando los problemas reales. Con su solución, comenzamos a desarrollar un sentido de eficacia. Pero, infortunadamente, los miembros de familias esquizopresentes actúan, a menudo, como si les faltase la apreciación de la importancia de la experiencia como educadora. Tienden a ver los hechos de la vida como "inexplicables", totalmente fuera de su control. Esta actitud pasiva y derrotista ha sido descripta por Laing y Esterson (12), como que la familia tiene una noción de "proceso" de la vida. Contrasta esta perspectiva con la noción occidental más usual de "praxis" de la vida, que sostiene que podemos obrar sobre nuestro destino y que los hechos tienen efectos identificables sobre los individuos. Así, si uno debe creer que no puede obrar sobre el destino, es fácil ver cómo la propia fuerza de uno puede atribuirse a algo exterior, por ejemplo, las alucinaciones que luego ejercen control.

Sin entrar en los detalles de sus implicancias filosóficas, estos dos puntos de

vista pueden ser caracterizados como irracional-autoritario (proceso) y racional-igualitario (praxis).

Quizás el relato más notable acerca de la propensión a negar la experiencia en familias esquizopresentes, fue el de Wynne y otros (18) en 1958. Describiendo un proceso que llamaron pseudomutualidad relataron que las familias se comportaban como si nada fuera erróneo o funcionara mal, frente a hechos más bien terribles. A lo largo de esta actitud extrañamente insensible, parecía haber una regla no explicitada en la familia, de modo que los hechos desastrosos no podían ser reconocidos —porque si lo eran podían amenazar la supervivencia de la unidad familiar. Se exigía que hubiese un sólo punto de vista, en la familia— reclamando claramente que se borrasen los límites del yo para permanecer en el sistema familiar. Así, la pseudoarmonía se preservaba por un decreto oculto y era reforzada por amenazas de agresión encubiertas. El esquizofrénico, creciendo en tal familia, no sorprende que aprenda a negar sus experiencias dolorosas, pero su dificultad para reconocer la realidad es más aparente que la de su familia. Con el tiempo, el que va a ser esquizofrénico no habiendo sido estimulado o autorizado a reconocer sus propias experiencias, las mantiene fuera de su conciencia. Así, comienza a usar lo que se ha llamado mecanismos "psicóticos" de defensa: negación, distorsión y proyección. La codificación de sus distorsiones y proyecciones se conocen como ilusiones.

Un concepto, quizá el más conocido, resultante de la investigación en familias de esquizofrénicos, es el de "doble vínculo" (Bateson y otros) (19). Pero, a pesar de lo provocativo, este concepto ha sido muy difícil de someter a una investigación sistemática.

Clínicamente, he encontrado la descripción de Lu (20) acerca de las "experiencias contradictorias" más útil que el "doble vínculo", aunque éstos son conceptos clara y altamente conocidos. El punto esencial de ambos términos es que las familias interactúan de modo tal que ubican al chico en una situación patógena en la que actúe o no actúe, siempre se equivoca. Y de acuerdo a lo especificado en Bateson y otros (19), el chico no puede comentar, clarificar o cuestionar las contradicciones. Hemos encontrado que estos fenómenos abundan en nuestros estudios sobre mellizos idénticos, discordantes con la esquizofrenia (13)—; por ejemplo, del mellizo a quien se le había atribuido siempre el rol de débil, enfermo, dependiente, sumiso, durante su vida, se espera que luego de la graduación universitaria, sea tan fuerte e independiente como su hermano mellizo. ¿Cómo se relaciona este proceso de interacción familiar con la psicología individual de la esquizofrenia? Desde esta perspectiva la intensa ambivalencia notada en muchos pacientes esquizofrénicos puede entenderse como una expresión abierta de ambas partes de las expectativas contradictorias que han experimentado con sus familias. El contenido de la ambivalencia varía pero la preocupación por el elemento independencia/dependencia (como en el ejemplo anterior) es excesivamente común.

3. IMPLICANCIAS PARA EL TRATAMIENTO

¿Qué principios generales de tratamiento pueden derivarse de este orden de hallazgos? Primero, pienso que el tratamiento no debe parecerse al medio familiar, al contrario, debería diseñarse para aumentar al máximo la validación, el reconocimiento y otras cualidades importantes que están notablemente ausentes en la familia esquizopresente. Se debería tomar extremo cuidado para asegurar que la fragmentación, compartimentalización e incomunicación se den mínimamente. Muy a menudo, los encuadres del tratamiento se convierten en una réplica de la situación hogareña en lo que a esto se refiere. Los pacientes son usados a veces para llenar necesidades del propio equipo terapéutico, se les previene de intentar actuar en su propio beneficio, y se les asigna motivos y roles no de su propia elección. A veces se pueden tomar decisiones sobre los pacientes

sin involucrarlos en el proceso. Ya que carecen de autoestima e identidad, su habilidad para resistir estas presiones es pobre y continúan con el modelo de vida de conformar las expectativas de los otros. Así, muchos encuadres convencionales de tratamiento pueden perpetuar la inadecuación del paciente. Si el tratamiento es para ayudar al paciente a desarrollar nuevos modelos identificatorios, debería proveerlo de un nuevo tipo de experiencia interpersonal y no de una repetición de frustraciones.

El paciente debe, con el tiempo, aprender que sus expectativas y las nuestras pueden ser diferentes de las de sus padres. Para cumplir esto, debemos validar las percepciones del mundo en el paciente, no importa lo distorsionadas que puedan aparecer al principio. Esto no significa que deberíamos aceptar las ilusiones del paciente como concretamente "reales" o pretender compartirlas. Por el contrario, deberíamos comunicarle nuestra creencia de que su experiencia acerca de ellas es genuina, que ellas pueden tolerarse y que son susceptibles de ser entendidas. Además es crucial que las necesidades, percepciones y sentimientos de todos los participantes de la interacción sean reconocidos —esto es vital para el desarrollo de la capacidad del esquizofrénico para comprender que sus percepciones pueden, de hecho, ser "verdaderas"— y que el feedback correcto con los otros es una posibilidad real.

En el estado psicótico agudo, al paciente debería hablársele de un modo claro, simple, declarativo y congruente. Es decir, que la conducta debería concordar con la verbalización. Expresados simplemente, el equipo terapéutico debería ser honesto respecto de sus sentimientos. (Por ejemplo, no deberían intentar negar el enojo cuando lo sienten). El ser "derecho" y "correcto" ayudará al equipo a transformarse en personas confiables para el paciente, una gran fuente de reaseguramiento para alguien que está en un estado de desorganización. Como parte de esta honestidad, nunca deberían atribuir sus propios pensamientos y sentimientos a los pacientes; y es una necesidad el ser constantemente autorreflexivo. En el caso de un sujeto psicótico agudo —esto es, en un estado fragmentado, confuso— creo que una situación compleja de grupo es patógena durante ese momento. En consecuencia, un contacto cálido, genuino, tolerante, honesto, diádico o triádico parece lo más apropiado hasta que la desorganización aguda haya pasado. Creo que los programas de tratamiento, para no manejarse con las rígidas atribuciones de roles que el paciente ha experimentado, deben ser muy flexibles y diseñados individualmente.

Muy a menudo, los programas se aplican al paciente por una moda arbitraria, en lugar de hacerlos en función de sus necesidades. Lidz y otros (15) han documentado hábilmente el proceso de modelo arbitrario familiar. El tratamiento debería minimizar las expectativas contradictorias, siendo claro con respecto al tipo de dependencia que permitirá y con respecto al tipo de independencia que pide. Para alentar una independencia realista, los pacientes deberían poder ir y venir, si no libremente, al menos fácilmente, sin tener que dar cuenta permanentemente de sus actos. Para fomentar el desarrollo de identidad y un sentido de sí mismo a los pacientes se les debería permitir probar una variedad de roles y modos de enfrentar situaciones dentro del encuadre del tratamiento sin prevenirlos de hacerlo porque haya algún peligro potencial e hipotético, ya que esto se asemejaría a la situación familiar que impidió el desarrollo de la propia capacidad. Finalmente, el equipo terapéutico debería deshabituarse respecto de la expectativa de que una persona "se deteriora" o se volverá "crónica". Este trato se asemeja demasiado a la situación familiar del paciente, donde se le asignó el rol de "malo", "débil", o "dependiente"—y si continúa contribuirá a hacerlo realmente un paciente "crónico". El equipo debería ser alentado para hacer lo máximo posible para tener expectativas positivas de la situación terapéutica.

Sabemos por el trabajo de Rosenthal (21), Orne (22), y otros que estas expectativas son de una influencia muy potente. De hecho, estudios recientes del pronóstico en esquizofrenia refuerzan con datos, la expectativa de que muy pocos pacientes esquizofrénicos, se volverán crónicos (23, 24, 25). Así, el

tratamiento debería enfatizar el desarrollo del manejo positivo de estrategias que hemos acabado por asociar con la propia capacidad —por ejemplo, la resolución flexible de problemas, la habilidad de obrar sobre el destino de uno, diferenciaciones y otros, etc.— que han sido explicadas anteriormente.

4. EL MODELO SOTERIA

Me gustaría describir ahora brevemente, un encuadre experimental de tratamiento, con el cual he colaborado como experimentador, durante los últimos cinco años. En Soteria —del griego "rescate"— intentamos implementar los principios delineados más arriba, con pacientes esquizofrénicos jóvenes, recién admitidos. Las limitaciones espaciales impiden detallar además el estudio de los antecedentes, al diseño y los resultados preliminares, éstos están al alcance del lector en otro lugar (26, 27, 28 y 29).

Soteria es una casa de doce habitaciones, ubicada en la bahía de San Francisco, una comunidad de 500.000 hab. Seis residentes (nuestra denominación para los pacientes) y dos no profesionales del equipo están allí a cualquier hora. El personal es seleccionado de acuerdo con que posea las actitudes hacia la psicosis que creemos le permitirán relacionarse con nuestros residentes como fue detallado anteriormente. Otros dos factores relevantes en los estudios de familia, están presentes en este encuadre. Los residentes permanecen un tiempo suficientemente largo (alrededor de cinco meses) hasta lograr vínculos genuinos con nuestro personal que resulta, junto con el encuadre hogareño, en un tipo de experiencia como de familia sustitutiva.

La casa debe ser manejada por sus participantes. Hemos notado dos efectos principales del tamaño pequeño de Soteria y de la estadía más bien prolongada: 1) los residentes tienen tiempo de identificarse con sus pares de edad parecida emancipados (nuestro personal) y 2) son capaces de dejar Soteria e ir a vivir por su propia cuenta con pares. (ver gráfico 4). Básicamente, pensamos que (2) es el resultado de (1), aunque obviamente la interacción con otros residentes y los "padres" de nuestro proyecto (la Sra. Alma Menn, el director de proyecto y nuestros consultores psiquiátricos) son también importantes.

Es difícil, por supuesto, sino imposible, conocer precisamente qué aspectos del resultado se relacionan con partes de algo tan vasto como Soteria. Aún cuando la capacidad de nuestros sujetos para dejar sus familias de origen, pueda no deberse al tamaño de Soteria y al tiempo de estadía, pensamos que, a lo largo del tiempo, este impacto en sus vidas puede ser la contribución más importante del proyecto. Estamos impactados con el estudio de Brown y otros (30) que mostró que esquizofrénicos externados, viviendo ahora con familias complicadas eran mucho más frecuentemente readmitidos que aquéllos viviendo lejos de sus familias, o con familias no complicadas. Así, con el tiempo, ya que nuestros sujetos son, capaces de emanciparse ellos mismos, es menos probable que sean rehospitalizados. Un estudio reciente de Waxler (31) parece también especialmente relevante para los aspectos de familia sustituta del proyecto de Soteria. A pesar de que fue un estudio experimental, sus hallazgos fueron relativos al tratamiento:

... "Los hallazgos de una tarea cognitiva que requiere habilidades para la atención y la abstracción muestran que la presencia de un chico esquizofrénico tiene sólo pequeños efectos desorganizantes sobre el desenvolvimiento de padres normales; los padres de esquizofrénicos también tienen efectos pequeños sobre los chicos normales. En cambio, los efectos más consistentes son aquéllos de padres normales sobre el chico esquizofrénico. Pacientes esquizofrénicos adolescentes cuyo déficit de desenvolvimiento cognitivo es aparentemente previo al experimento, muestran una mejoría significativa después de haber trabajado en la tarea cognitiva con padres normales; su déficit cognitivo desaparece y su desenvolvimiento no es diferente al de chicos normales". (p. 1/2)

Así, pensamos que un ingrediente terapéutico importante de Soteria puede ser la provisión de contacto prolongado con influencias normalizadoras tanto de figuras parentales como de pares. Este modelo es relevante para aquéllas personas rotuladas esquizofrénicas que no han sido capaces de dejar el hogar, como es el caso de la mayoría de nuestra población. Su aplicación a otros tipos de esquizofrénicos (por ejemplo, mayores o más crónicos) o grupos con otros diagnósticos, debe ser establecida. Sin embargo, los cálculos en nuestros datos indican que además de ser más capaces de dejar el hogar, los residentes tratados en Soteria tienen un mejor ajuste psicosocial y no más síntomas que un grupo control de pacientes que reciben un "buen" tratamiento convencional. Esto se logra a pesar del hecho de que menos del 10% de Soteria, comparado con el 100% de los pacientes control, recibe drogas antipsicóticas!

5. RESUMEN

Se explican las implicancias del tratamiento después de dos décadas de estudios sobre familias con un miembro esquizofrénico. Este cuerpo de investigación es revisto selectivamente, manteniendo la definición de esquizofrenia como una perturbación de la comunicación y usando conceptos que el autor encontró como clínicamente útiles. No se intenta revisar este cuerpo de investigación comprensivamente, ni revisar estudios sobre la eficacia de la terapia familiar. Por el contrario, la monografía intenta relacionar los modelos de interacción familiar con las características de pacientes esquizofrénicos individuales y derivar principios para el tratamiento que se desprenden lógicamente de estas relaciones.

Se dedica particular atención a la necesidad de que los encuadres de tratamiento tomen en cuenta la perturbación en la comunicación de la familia y el paciente, proveyendo con un modelo que logre claridad cognitiva y un poco de atención. Los varios roles fijos intrafamiliares asociados, con el pobre sentido de sí mismo, límites yoicos borrados, autoestima baja y la incapacidad tan comunes en la psicología del esquizofrénico deben abordarse en el tratamiento, poniendo énfasis en la flexibilidad, el aprendizaje por ensayo y error, la autonomía y la responsabilidad individual en las decisiones importantes. Los modelos afectivos familiares asociados con la marginación y falta de afecto en los pacientes individuales deben abordarse, en el tratamiento, con aceptación, tolerancia, empatía y alentando la expresión de los sentimientos.

Se describe un encuadre de tratamiento innovador basado en la comunidad, llamada Soteria, en el que se practican estos principios. Hallazgos de investigaciones preliminares indican que es efectivo en la ayuda de esquizofrénicos jóvenes recientemente diagnosticados, enmarañados en sus familias de origen, que se emancipen y se adecúen a las normas culturales de la subcultura urbana.

Traducido por

Lic. María José Mondet

BIBLIOGRAFIA

IMPLICATIONS OF FAMILY STUDIES FOR THE TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA

- Loren R. Mosher, M.D.1. Fabrega, N. *The need for an ethnomedical science. Science*, 189:969-975, 1975.
- Szasz, T. *The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct*. New York: Hoeber-Harper, 1961.
- Spitzer, R. L., and Fleiss, J. L. *A reanalysis of the reliability of psychiatric diagnosis. British Journal of Psychiatry*, 125:341-347, 1976.
- Mosher, L. R. *Can Diagnosis be Nonpejorative?* Paper presented at the Second Rochester International Conference on Schizophrenia, Rochester, New York, May 2-5, 1975.
- Chesterton, G. K. *The Ballad of the White Horse*, 1911.
- Jacob, T. *Family interaction in disturbed and normal families: a methodological and substantive review. Psychological Bulletin*.

7. Riskin, J., and Faunce, E. *An evaluative review of family interaction research*. *Family Process*, 11:365-456, 1972.
8. Mishler, E., and Waxler, N. *Family interaction processes and schizophrenia: A review of current theories*. *Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development*, 11:269-315, 1965.
9. Massie, H. N., and Beels, C. C. *The outcome of the family treatment of schizophrenia*. *Schizophrenia Bulletin*, 6:24-36, 1972.
10. Wells, R. A.; Dilkes, T. C.; and Trevelli, N. *The results of family therapy: A critical review of the literature*. *Family Process*, 11:189-207, 1972.
11. Speck, R. V. *Psychotherapy of the social network of a schizophrenic family*. *Family Process*, 6:208-214, 1967.
12. Laing, R. D., and Esterson, A. *Sanity, Madness and the family: Vol. I. The Families of Schizophrenics*. London: Tavistock Publications, Ltd., 1964.
13. Mosher, L. R.; Pollin, W.; and Stabenau, J. R. *Families with identical twins discordant for schizophrenia: Some relationships between identification, thinking styles, psychopathology and dominance-submissiveness*. *British Journal of Psychiatry*, 118: 29-42, 1971.
14. Mishler, E. G.; and Waxler, N. E. *Family Processes and Schizophrenia*. New York: Science House, 1968.
15. Lidz, T.; Flick, S.; and Cornelison, A. R. *Schizophrenia and The Family*. New York: International Universities Press, 1965.
16. Wynne, L. C.; and Singer, M. T. *Thought disorder and family relations of schizophrenics: I. A research strategy, II. A classification of forms of thinking*. *Archives of General Psychiatry*, 9:191-206, 1963.
17. White, R. W. *The experience of efficacy in schizophrenia*. *Psychiatry*, 28:199-211, 1965.
18. Wynne, L. C.; Ryckoff, I. M.; Day J.; and Hirsch, S. I. *Pseudo-Mutuality in the family relations of schizophrenics*. *Psychiatry*, 21: 205-220, 1958.
19. Bateson, G.; Jackson, D.; Haley, J.; and Weakland, J. *Towards a theory of schizophrenia*. *Behavioral Science*, 1:251-264, 1956.
20. Lu, Y. *Contradictory parental expectations in schizophrenia*. *Archives of General Psychiatry*, 6: 219-234, 1962.
21. Rosenthal, R.; and Jacobson, L. *Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectations and Pupil's Intellectual Ability*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1968.
22. Orne, M. T. *On the social psychology of the psychological experiment with particular reference to demand characteristics*. *American Psychologist*, 17:776-783, 1962.
23. Bleuler, M. *A 23-year longitudinal study of 208 schizophrenics and impressions in regard to the nature of schizophrenia*. In: Rosenthal, D., and Kety, S., Eds. *The Transmission of Schizophrenia*. London: Pergamon Press, 1968.
24. Hawk, A. B.; Carpenter, W. T.; and Strauss, J. S. *Diagnostic criteria and five-year outcome in schizophrenia: A report from the International Pilot Study of Schizophrenia*. *Archives of General Psychiatry*, 32:343-347, 1975.
25. Bland, R. C., and Parker, J. H. *Prognosis in schizophrenia*. *Archives of General Psychiatry*, 33:949-954, 1976.
26. Mosher, L. R. *A research design for evaluating a psychosocial treatment of schizophrenia*. *Hospital and Community Psychiatry*, 23:229-234, 1972.
27. Mosher, L. R.; Reifman, A.; and Menn, A. *Characteristics of nonprofessionals serving as primary therapists for acute schizophrenics*. *Hospital and Community Psychiatry*, 24:391-396, 1973.
28. Mosher, L. R.; Menn, A.; and Matthews, S. *Soteria: Evaluation of a home-based treatment for schizophrenia*. *American Journal of Orthopsychiatry*, 45:455-467, 1975.
29. Mosher, L. R.; and Menn, A. *Community Residential Treatment for Schizophrenic*. Paper presented at the 129th Annual Meeting of the American Psychiatric Association, Miami, Florida, May 10-14, 1976.
30. Brown, G. W.; Birley, B. M.; and Wing, J. K. *Influence of family life on the course of schizophrenic disorders. A replication*. *British Journal of Psychiatry*, 121: 241-258, 1972.
31. Waxler, N. E. *Parent and child effects on cognitive performance: An experimental approach to the etiological and responsive theories of schizophrenia*. *Family Process*, 13: 1-22, 1974.

GRAFICO I
COMUNICACION

PROCESO FAMILIAR	CARACTERISTICAS INDIVIDUALES	CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL ENCUADRE DEL TRATAMIENTO
Irracionalidad Significado vago. Falta de claridad	Perturbaciones del pensamiento.	Comunicación simple. clara, declarativa.
Incapacidad de compartir un foco de atención.	Distracción. Sobrecarga de estímulos.	Atención focalizada. Contacto diádico simplificado.
Invalidación. No reconocimiento.	Deficiente formación de identidad. Carencia de afecto ("aplastado")*	Validación. Reconocimiento. Honestidad.
Mistificación.	Distorsión * "Ilusiones"	Asumir las percepciones del paciente correctamente.

* Defensas.

GRAFICO 2
ROLES

PROCESO FLIAR.	CARACTERISTICAS INDIVIDUALES	CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL ENCUADRE DEL TRATAMIENTO
Estereotipado	Pobre sentido de sí mismo. Rigidez.	Flexibilidad de respuestas. Roles no prescriptos.
Expectativas contradictorias.	Ambivalencia* Ansiedad* Fragmentación yoica.	Predictibilidad.
PSEUDO MUTUALIDAD	Negación* Proyección* Compartimentalización* Límites del yo difusos.	Alentar el aprendizaje flexible por ensayo y error. Enfatizar la autonomía. Responsabilidad individ.
Débil, dependiente, usado para cumplir necesidades parentales.	Baja autoestima. Incompetente. Ineficaz.	Decisiones tomadas por los pacientes. Expectativas manifestadas.
Unión simbiótica.	Deseo de complacer a otro poderoso.	Continuidad de relaciones, basada en mutuo consentimiento.

* Defensas.

GRAFICO 3
AFECTO

PROCESO FAMILIAR	CARACTERISTICAS INDIVIDUALES	CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL ENCUADRE DEL TRATAMIENTO
Hipercrítica Inconsistencia Divorcio emocional Falta de empatía	Marginación* autismo* labilidad. Imposibilidad de goce.	Aceptación, tolerancia, calidez. apoyo, empatía, compromiso.
Incapacidad de obrar sobre el destino (Noción de "proceso"). Falta de ayuda.	Sentir falta de fuerza para enfrentar el destino. Alucinaciones*	Acentuar la definición por parte del paciente de sus necesidades. Facilitar el alcance de sus metas
Rechazo encubierto	Enojo	Alentar expresiones de afecto.

* Defensas

GRAFICO 4
DATOS DE LOS RESULTADOS DE SOTERIA
AJUSTE PSICOSOCIAL: ARREGLOS DE LA ESTADIA

	Experimental		Control		Probabilidad EXACTA *
	N	%	N	%	
I. Antecedentes a la Admisión:					
Con padres/ parientes	26/37	70	19/28	68	90
Solos/ pares	9/37	24	6/28	21	
Esposa/ hijos	1/37	3	2/28	7	
Pensiones con atención. etc.	1/37	3	1/28	4	
II. 12 meses post-admisión:					
Con padres/ parientes	5/21	24	10/22	45	009
Solos/ pares	12/21	57	4/22	18	
Esposa/ hijos	1/21	5	2/22	9	
Pensiones con atención. etc.	0/21	—	5/22	23	
Soteria/ hospital	3/21	14	1/22	5	

* Probabilidad exacta para RxC tabla de Contingencia (por ej: la probabilidad de obtener una tabla tan confiable o menos confiable que la dada).

LIBROS

Isidoro Berenstein - **Familia y Enfermedad Mental** - Editorial Paidós, Buenos Aires, Enero de 1976, 185 págs.

Hace tiempo que, en nuestro quehacer y desde diferentes enfoques teóricos y clínicos, se trata de encontrar la articulación entre la enfermedad mental de un individuo y su familia. I. Berenstein hace lo propio basándose fundamentalmente en el psicoanálisis, la antropología estructural desarrollada por Claude Lévi-Strauss y la lingüística saussuriana.

El autor nos introduce en el tema de la familia y su tratamiento posible desde distintas perspectivas: sociológicas, antropológicas, psicológicas, para hacernos recorrer un camino por diferentes concepciones acerca del tema. Estas concepciones distintas permiten al autor guiarnos hacia la línea directriz de su obra cuando, al hablar de la familia como sistema, más allá de la teoría de la comunicación, nos propone la visión lingüística de sistema partiendo de los desarrollos de Ferdinand de Saussure. Aquí, quizás, se produzca el corte radical que enmarca esta obra dentro del estructuralismo y dentro de la concepción de uno de sus representantes, Claude Lévi-Strauss. Desde esta perspectiva, se convierte en un aporte nuevo e interesante en la comprensión del enfermo mental y su familia.

Su enfoque estructuralista nos hace recordar a François Wahl cuando nos dice "que si la palabra estructuralismo corresponde a algo, es a plantear los problemas en las ciencias que tratan del signo, que tuvo su punto de partida en la lingüística saussuriana". De esta manera "con el nombre estructuralismo se reagrupan las ciencias del

signo, de los sistemas de signos". Por ello... "los hechos antropológicos más diversos pueden entrar en él, pero sólo en tanto pasan por los hechos de la lengua (en tanto están comprendidos en la institución de un sistema del tipo significante/significado y se adaptan a la red de una comunicación) y de allí reciben su estructura".

También recordamos a Claude Lévi-Strauss cuando nos habla del objeto de las ciencias estructurales, siendo aquello que "presenta un carácter de sistema", es decir, de todo conjunto del cual ninguno de los elementos puede ser modificado sin provocar una modificación de todos los demás. En ese sentido Berenstein nos muestra en su obra a la familia como sistema, para romper con la tranquilizadora dualidad sanos/enfermos. Partiendo de la preeminencia del intercambio sobre la consanguinidad trasciende las descripciones basadas en la familia nuclear para encarar el grupo familiar como un sistema relacional entre dos familias. Más allá de los componentes de la familia que se nos presentan en el orden de las relaciones familiares más próximas a la consciencia, existe un orden estructural, de naturaleza inconsciente, en donde la familia aparece como un sistema relacional basado en la prohibición del incesto como regla reguladora del intercambio dentro del grupo familiar y de ese grupo familiar con otros, para renovar el parentesco por medio de la alianza heterosexual.

En ese nivel estructural inconsciente nos encontramos con más personajes que los que se presentan como familia a la consulta, incluyendo, además, a los representantes de la familia materna o de una familia anterior, y se descubre la solución inconsciente del intercambio realizado por dos familias que se relacionan a través del vínculo conyugal, tal como nos va mostrando a través de diferentes descripciones clínicas, algunas de las cuales va retomando en capítulos posteriores para continuar aplicando sus desarrollos teó-

ricos.

En el texto, la familia consanguínea se extingue en su circularidad; también las concepciones como las de B. Malinowski que desde la patrilinealidad o la matrilinealidad pudieron hacer tambalear los desarrollos de S. Freud sobre el Complejo de Edipo. Aparece la condición necesaria de la estructura, el avunculus, permitiendo el enlace entre la familia conyugal y la familia materna. Desde aquí podremos pensar en lo que nos dice Lacan: "la primacía del falo es instaurada en el orden de la cultura, permitiendo la actuación en sí de la metáfora paterna", mostrándonos a los integrantes de la familia en su relación con la ley, sus identificaciones, su estructura inconsciente. Así, nos dice Berenstein: "La estructura inconsciente (familiar) no son sólo leyes de funcionamiento sino acontecimientos transformados colectivamente y vigentes como trozos de verdad histórica, reelaborados y mantenidos en el presente como recuerdos encubridores, mitos y fantasías familiares compartidas". Tal vez así se comprenda mejor por qué Lévi-Strauss definió a la Etnología como "el estudio de las condiciones inconscientes de la vida social".

En un grupo familiar es inconsciente aquella parte de la organización que no pasa por la conciencia de los integrantes o aquella parte de su historia que no es considerada como determinante de la estructura actual. La noción de estructura familiar, como la de estructura social, se refiere más bien a los modelos construidos de acuerdo a los índices registrados en las evidencias empíricas de las relaciones familiares. Para hallar el primer nivel de homogeneidad es necesario, en forma metodológica, disolver las individualidades y alcanzar el nivel del sistema desde donde los integrantes empiezan a cobrar una nueva significación. Entonces empieza a surgir en una doble articulación no sólo la relación entre individuos sino también entre familias. La estructura inconsciente constituye el armazón elemental y fundante que organiza

diversos órdenes de producción y sus transformaciones, tales como las denominaciones, el plano habitacional, el tiempo familiar, la enfermedad mental.

Las investigaciones sobre grupo familiar han llevado a modificar el concepto de enfermedad mental como anormalidad o desadaptación para considerarlo como expresión de un intercambio a nivel del sistema familiar. El concepto de series complementarias de Freud anticipó la causalidad estructural a cambio de la causalidad lineal: disolvió la separación entre lo sano y lo enfermo, lo anormal y lo normal y además, mediante el concepto de sexualidad infantil, equiparó el síntoma neurótico al desarrollo normal y sus obstáculos. La familia de un enfermo mental se presenta como un sistema escindido en sanos y enfermos. Pensar que la familia determina el trastorno mental de uno de sus integrantes o que el paciente determina por medio de su enfermedad la organización familiar, supone pensar en términos de causalidad lineal. Estudiar la relación entre esos dos términos supone el pasaje a una causalidad circular o estructural. La distribución por mitades sanos vs. enfermos, en modo absoluto es única; coexiste con otros tipos de intercambios entre las partes o entre otros subsistemas del grupo familiar. Todos estos intercambios intrafamiliares en un momento dado y a raíz de alguna causa desencadenante, de pronto, se reordenan, a través de un enfrentamiento entre los integrantes, con lo cual el intercambio predominante está en función de la oposición sanos/enfermos.

El autor nos advierte que la relación entre lo consciente y lo inconsciente está ahí; nos llama a no confundir, como de hecho se hace, los acontecimientos con las teorías de los miembros familiares acerca de su estructura y organización. Lo diádico encubre en su estatismo un sistema triádico que permite pensar a la familia como un sistema con un movimiento dialéctico continuo. Esta relación triádica nos remite a

Charles S. Peirce y a una raigambre hegeliana, donde el signo y su relación triádica genuina podrían servir de modelo. De esta manera, los individuos se ligarían entre sí, por el conjunto de estructuras significantes compartidas en las cuales están incluidos (C. Stein). La enfermedad mental de un miembro de una familia puede considerarse como un mensaje que nos remite a la estructura del grupo familiar y es en la estructura donde encontramos el nivel de homogeneidad primero, lo cual supone el pasaje de la conducta manifiesta a su significado latente.

La segunda parte de la obra titulada "La estructura inconsciente de las relaciones familiares", estudia a través de ejemplos clínicos tres órdenes básicos de producción de la misma: las denominaciones, el espacio y el tiempo familiar. El primero, acerca de los nombres propios donde el tipo de nombre y su pertenencia a la rama materna o paterna establece un modo de equilibrio en la estructura latente conformada por la relación de la familia conyugal y la familia materna". Los nombres se derivan, informan y remiten a un sistema relacional desde el cual definen su significación. En ese sentido, el nombre puede constituir un signo desprendido de un sistema significativo. Es así que establece relaciones sintagmáticas o paradigmáticas y formaciones metonímicas o metafóricas. De esta manera, en su pasaje de padres a hijos permiten, como ya lo vislumbraba Freud, un desarrollo diacrónico generacional del sujeto.

Los nombres propios pertenecen a dos tipos, aquellos donde el nombre es una marca de identificación aplicada por el grupo familiar según algún tipo de regla y aquellos nombres donde la regla es la creación libre del individuo que nombra y expresa un estado anímico transitorio. El nombre propio indica una relación entre el receptor y el dador del nombre, y, a menudo, es la expresión de un sistema de relaciones profundamente inconsciente entre ambos. Estudiando la deter-

minación histórico-genética nos acercamos a la circunstancia histórica transformada en estructura actual de la cual el nombre propio, el sobre-nombre, el apodo, el o los apellidos usados constituyen un signo.

El espacio y el tiempo son considerados objetos semióticos organizados que derivan de una estructura familiar inconsciente significante. La organización del espacio puede ser considerada como un lenguaje. La distancia y la ubicación son signos del vínculo entre los integrantes que pueden corresponder a un modelo inconsciente o ser una configuración encubierta del mismo. Con frecuencia, el hábitat de los vivos tiene lugar en su representación para los muertos. Otras veces la distribución espacial puede ser concordante con un relato mítico circulante en el grupo familiar. Consideramos la representación gráfica del hábitat como un mensaje cuyo significado nos remite a la estructura familiar significante. De la misma manera, es un mensaje la distribución en el espacio propiamente dicho, como sucede en la sesión terapéutica donde merced a la estabilidad del encuadre caracterizado por las dimensiones estables de tiempo y lugar, pueden registrarse las diversas organizaciones grupales familiares. La constancia del fenómeno de la silla vacía indicaría la cualidad de una ausencia-presencia significativa. En toda representación especial de un grupo familiar podemos establecer una oposición inicial entre los espacios en que subdivide la casa, a partir del cual se puede inicial la lectura sincrónica del espacio familiar. En ese sentido el espacio familiar jugará desde un sustento imaginario donde la virtualidad especular y la agresividad, aparecerán en el discurso familiar mostrando deseos y demandas que poblarán ese espacio de fantasmas.

El estudio del espacio en tanto organización sincrónica, nos permite inferir una ordenación permanente inconsciente de la estructura familiar. El estudio del tiempo nos permite recuperar una estructura

acrónica. El tiempo familiar y su ordenación también puede ser analizado como un índice desde el cual hacer inferencias sobre la estructura familiar inconsciente. El tiempo ofrece configuraciones estables o inestables correspondientes a modelos encubridores pero no por ello menos informativos. Con estos elementos es posible rediseñar el tiempo familiar actual y el histórico en un nuevo modelo de tiempo inconsciente representado por una fórmula acrónica donde se define la relación inconsciente entre la familia conyugal y la materna. El tiempo se transforma en un marco donde se ubican no sólo los acontecimientos vividos sino también la relación entre ellos. Hay un tiempo donde los episodios son vividos (historia) y un tiempo donde son recordados y agrupados desde el presente (memoria) y, como toda ordenación, varía de acuerdo a una concepción no siempre explicitada de modo consciente, pero que retiene las características de la estructura familiar.

La relación temporal, quizás más que la espacial, se presta para estudiar la relación causa-efecto, tomando como indicios la sucesión relatada de los acontecimientos históricos. De los 4 tipos de periodización temporal es el tiempo mítico familiar el que establece una determinación causal entre los acontecimientos pasados, pero se trata de una determinación causal lineal. Como todos los mitos, informa de las necesidades actuales y circulan para resolver contradicciones insolubles. Contiene un elemento variable contingente tomado de distintas épocas y un elemento invariante acrónico que le otorga potencialidad estructurante. El tiempo inconsciente es reversible; es el tiempo de la significación, aquél donde las distintas secuencias de acontecimientos se ordenan en una unidad temporal estable y aunque se origina en ellos, les sirve de marco y les otorga significación oculta. Mantiene así, en una misma estructura, acontecimientos ocurridos en épocas diversas, agrupadas en un modelo regulador que les otorga sentido.

Berenstein propone hallar la relación entre por lo menos dos acontecimientos, encontrar regularidades entre secuencias de sucesos y estudiar su correlación mediante el análisis dialéctico y de la estructura de significación correspondiente para descubrir la conexión entre la sucesión temporal histórica y la estructura acrónica. También el texto da importancia, desde la temporalidad, a la progresión o regresión familiar; lo mítico y lo anecdótico, donde todo nos lleva a esa relación no siempre perceptible pero por eso no menos constante: la relación inconsciente entre la familia conyugal y la familia materna.

Stella Maris Molina
Rafael Skiadaressis

La familia y el desarrollo del individuo. D.W. Winnicott.

Ed. Hormé, 216 pag. Buenos Aires 1967. The Family and Individual Development. ED. por Tavistock Publications. Traducido por: Noemí Rosemblat.

Este texto presenta escritos que van desde 1955 a 1963 y nos reúne con un autor importante, que no es terapeuta familiar ni escribe sobre terapia familiar a excepción de incipientes encuentros con familias donde se coloca en el lugar de "enfermero" para una resolución paliativa, sin perder de vista no obstante, la importancia de la función familiar y la interacción generacional. Creemos que los aportes de su pensamiento a la relación individuo/familia deben ser recordados o quizás sólo re-nombrados, porque en el "proceso" del desarrollo individual da a la familia un lugar, desde lo real y desde lo consciente o inconsciente, como basamento para ese desarrollo en su movimiento prospectivo.

En sus escritos nos muestra como se ponen en juego ante la enfermedad, tanto sea las relaciones familiares intervinientes como el rol del

terapeuta, ambos permanentemente cuestionados en su compromiso. Winnicott nos permite pensar con él que el analista puede ser utilizado por el paciente más para sus carencias que para sus éxitos y que, por lo tanto, tendrá que recorrer con su paciente el trayecto de lo que éste le falta para Ser.

Quizás por ello rompe con toda posibilidad de enmarcar su discurso en una fácil vertiente moralista, para desarrollarlo desde una perspectiva ética, diferencia importante si pensamos en el enfrentamiento que entre discursos moralistas y éticos se desarrollan en la sociedad de la cual la familia es su institución primigenia.

Winnicott nos muestra como el recorrido del desarrollo, en el "proceso" de la individuación, transcurre de la dependencia a la independencia. Así los instintos y las fantasías juegan su parte entre las posesiones YO/NO-YO y las relaciones objetales pasarán por esa serie de fenómenos transicionales donde el objeto transicional, parte del self, parte de la realidad, nos habla muchas veces de carencia. Carencia, ésta, constitutiva de la situación básica del pathos, que hará su aparición en las vicisitudes de la relación madre-niño, donde el autor nos muestra cómo la actitud de la madre llevará al niño a recorrer los caminos de un falso o verdadero self. La función materna para ello será discriminada en tres niveles:

- a) de sostén (holding)
- b) de manipulación
- c) de mostración de objetos (función esta requerida desde lo real)

Esta función constituye el soporte del camino que va desde la dependencia (por la necesidad e indefensión) hasta la madurez, concebida como independencia, realización del desarrollo individual.

Quizás los ejemplos que presenta en la primera parte nos sorprendan, pues el camino tendiente a la resolución sería la separación del niño de sus padres por conflictos de uno u otro. Pero sin duda debemos ver más allá cuando nos muestra la conflicti-

va en el seno familiar, sobre todo, tal vez, frente a la enfermedad psicótica del padre o de la madre.

Luego de la niñez y la latencia llegamos a la adolescencia, momento de situaciones específicas en las relaciones familiares. "Una característica de la adolescencia, dice Winnicott, es la brusca alternación entre una independencia desafiante y una dependencia regresiva". Pero también nos aclara que: "Una característica de los adolescentes consiste en que no aceptan soluciones falsas. Esta feroz moralidad basada en lo real y lo falso pertenece también a la infancia y a la enfermedad de tipo esquizofrénico". Esto es vivido en el medio familiar donde lo verdadero es el impacto recíproco entre el adolescente y los progenitores en esa mezcla de desafío y dependencia.

El autor nos advierte en lo que hace a la tarea terapéutica y nos dice.... "la que se ve puesta a prueba frente a ese desafío que representa el adolescente, es precisamente esa parte nuestra que nunca tuvo una adolescencia. Es ese pedazo de nuestro ser el que se siente agravado frente a quienes se permiten vivir esta fase".

Así el autor nos lleva a enfrentarnos con la familia y la madurez emocional, aquí un interrogante es importante: ¿Puede el individuo alcanzar madurez emocional fuera del marco de la familia? La respuesta es terminante: NO. Porque el pasaje de la dependencia a la independencia, lo que nos interesa realmente, es la actitud ambiental que responde y se adapta a las necesidades del individuo en cualquier momento dado.

De esta manera sólo la familia (institución) del niño, puede continuar la tarea iniciada por la madre y desarrollada luego por la madre y el padre; tarea esta de satisfacer las necesidades del ser. Dichas necesidades incluyen, sin duda, los momentos de dependencia y los esfuerzos por alcanzar la independencia. Pero el decir "satisfacer las necesidades del individuo en crecimiento", no podemos sólo pensarlo en el sentido instintivo, sino que también, los

padres puedan ser continentes de aquello vital que es el estallido desafiante que implica el desligarse, como así también de la dependencia que alterna con esta actitud desafiante. Por eso el autor nos dice: "un adolescente que huye del hogar, no ha perdido de ninguna manera su necesidad de un hogar y una familia". Como terapeutas familiares sabemos de la tragedia que nos dice esa búsqueda del que ha huido, donde a veces la constitución de su propia familia le hará, reabriendo sus heridas, constituirse en lo que constituye; o entre otras visicitudes buscará el amparo de la ley social por sus actos, o por fin, buscará entonces cobijarse en esa muerte violenta que será un regreso al seno materno.

Así Winnicott nos dice: "Para amar o para odiar todos necesitamos del otro que es o fue la familia". Y continúa diciendo: "Me parece útil comprender que mientras la familia se mantenga intacta, todo se relaciona en última instancia con los progenitores reales (o padres adoptivos) del individuo. En la vida consciente y en la fantasía el niño puede haberse alejado del padre y de la madre y haber obtenido un gran alivio por ello; no obstante lo cual, la posibilidad de volver junto a los padres está siempre presente en el inconsciente". Es de esta manera que: "La familia existe como algo consolidado por el hecho de que para cada miembro individual el padre y la madre están vivos en la realidad psíquica interna". Y como parte de la individuación en la dialéctica intersubjetiva, Winnicott agrega: "No se trata de percibir intelectualmente que el área cada vez más amplia de relaciones conserva simbólicamente la idea del padre y de la madre. Aquí me refiero a la capacidad del individuo para regresar realmente junto a los progenitores o a la madre, al centro o al comienzo (del desarrollo), en algún momento fecundo, quizás en un sueño o bajo la forma de un poema o una broma".

En la segunda parte del texto, luego de una formulación sobre el

campo específico de su trabajo, Winnicott vuelve en una visión integradora psicoanalítica desde la obstetricia, como antecedente instrumental al nacimiento, o en el post-parto, a dar cuenta de esa mujer, madre, que por la fascinación narcisista constituirá esa unidad madre-niño, hasta la ruptura en el NO-YO o la inevitable aparición de una psicosis.

Con un título equivoco aparecen los "consejos" como diferencia entre un compromiso fallido y el efecto de sentido producido por el develamiento de lo inconsciente. Por ello hablando de depositarios, la situación ya no depende del campo específico del quehacer psicoanalítico, sino de una actitud y una posibilidad, la de convertirse en tales. Así nos dice el autor: "Esto significa sufrir, soportar la preocupación, incluso la angustia de un caso, del conflicto de un individuo, de inhibiciones y frustraciones, de discordias familiares, de penurias económicas". Para que luego... "devolvamos lo que temporariamente recibimos y conservamos en custodia y entonces habremos ofrecido la mejor ayuda posible. En cambio, que se atenga quien necesita actuar, aconsejar, entrometerse".

De esta manera llegamos a la entrevista profesional y de aquí a la integración trabajo asistencial-psicoterapia como forma de encuentro de lo social, familiar y comunitario, con lo individual.

Por sus características, el trabajo asistencial a la familia funcionará como complemento cuando se presenta integrada, suplemento ante la desintegración y organizando o re-organizando, en el derrumbe familiar.

Pero sólo trabajando en equipo, nos dice, permite... "la organización de una tendencia activamente integradora o una contención del material potencialmente desintegrador" en las relaciones familiares.

El autor continúa con un tema primordial, la carencia (deprivación), y sus múltiples formas agrupadas en la relación madre-hijo o padre-madre-hijo; y será en estas relaciones donde para el niño... el odio se reprime o bien se pierde la capa-

cidad de amar" y sus síntomas serán tantos en la búsqueda de una recuperación ambiental.

En este sentido Winnicott es categórico, la psicoterapia en principio no constituye una medida práctica, lo esencial es proporcionarle al niño una familia. Sabemos, los que trabajamos con pacientes psicóticos, lo importante de esta proposición. Por eso en deprivación, la historia infantil (o la del psicótico) o mejor dicho la reconstrucción de la historia infantil por la familia permite al niño a volver a su pasado, quizás para encontrar en él experiencias de frustración. Así, ya sea por regresión o por la historia familiar, podemos ir al pasado en la búsqueda de las frustraciones que organizaron un falso self para permitir la progresión de un self verdadero.

Acá los fenómenos y objetos transicionales juegan su papel fundamental. Primero posesión NO-YO, lugar intermedio entre lo interno y lo externo donde la ilusión-desilusión se inserta en la raíz de la experiencia vivida.

El niño no sólo utiliza juguetes blandos o duros, ropas o frazadas, etc. sino, también a la madre como objeto transicional. En este sentido cabría interrogarse sobre la situación del niño sirviendo de objeto transicional a la madre, en la originalidad de las estructuras patológicas.

Estos fenómenos establecen la relación entre lo subjetivo y lo objetivo, pero cuando esta relación se destruye o nunca fue estable, el niño es incapaz de funcionar como un ser humano total. Sobre lo cual Winnicott nos dice: "En cierta medida, esta situación existe siempre en los niños que carecen de una vida familiar".

El llegar a una posesión NO-YO, permite al niño recorrer los caminos de la integración desde la cual, en relación con el grupo primario, instaurará el YO SOY. Precisamente es aquí donde todo se complejiza, si pensamos cómo el crecimiento personal del niño puede a veces complicar el crecimiento grupal, familiar.

Así, esta relación básica se amplía a lo que Winnicott llama "unidades superpuestas", donde cada indi-

viduo con su historia, constituirá con otros un grupo formado por unidades individuales integradas, o bien, y también por la historia de cada uno, se formarán los "grupos de protección" donde la relativa integración individual hará que el grupo funcione dependiendo de la protección y no de los individuos que lo forman.

De esta manera Winnicott amplía su concepto de grupo primario (familiar) y su influencia en la inserción del individuo en el ámbito social. Así nos lo dice al hablar del surgimiento patológico de la inadaptación: "...esto significa, escribe, que en algún momento del pasado el medio no logró adaptarse adecuadamente al niño, por lo cual éste se vio obligado a hacerse cargo de su protección y a perder así identidad personal, o bien obligar a alguien a hacerse cargo de esa protección, a fin de contar con una nueva oportunidad para alcanzar su integración personal".

Esto se complementa con una clasificación de casos que hace el autor, donde la integración individual y/o la dialéctica identificatoria darían cuenta de los orígenes.

Finalmente Winnicott nos acerca a la relación individuo/sociedad, en tanto el proceso de desarrollo emocional en el marco familiar, constituye un elemento fundamental para el desarrollo y la evolución social.

Rafael Skiadaressis

TECNICAS DE TERAPIA FAMILIAR

de Jay Haley y Lynn Hoffman, Amorrortu Editores S.A., Buenos Aires, Noviembre de 1976, 435 páginas.

Traducción de Inés Pardal, "Techniques of Family Therapy", Basic Books Inc., N.Y. 1967.

El objetivo de los autores es captar y transmitir el espíritu de la terapia familiar que se viene practicando hace 25 años en su país, abarcando una variedad de enfoques y sin pretender sintetizarlos. Para ellos la terapia familiar constituye una nueva forma de conceptualizar la causa y la cura de los problemas psiquiátricos donde la unidad de tratamiento ya no es la persona sino la serie de relaciones en que el ser humano se halla inmerso.

En este libro ofrecen al lector una aproximación a la experiencia real de dialogar con cinco expertos en terapia familiar bajo la forma no habitual de presentar una serie de conversaciones sobre la base de primeras entrevistas familiares representativas del enfoque habitual del profesional. Desde el comienzo existe una jerarquización de la práctica con el fin de evitar la pura disquisición teórica de los terapeutas y también el error de interpretación del observador que, en este caso, puede interrogar y formular sus propios puntos de vista. El trabajo implica, según los autores, "un esfuerzo por ir más allá de las fundamentaciones teóricas y las racionalizaciones habituales de todo texto clínico, utilizando en cambio un enfoque dialéctico: las conversaciones son producto de todo el bagaje incorporado por el terapeuta y los propios entrevistadores más la serie de elementos incluidos en el material de la sesión propiamente dicha."

El resultado de este diálogo es que hace explícito lo que antes se hallaba implícito en la labor terapéutica, permite reflexionar sobre la práctica clínica y confrontar

diferentes pero no opuestos postulados sobre la psicopatología familiar y la terapéutica adecuada a partir de la experiencia particular de cada especialista. El lector participa activamente como un entrevistador más y a menudo elaborando su propia interpretación no sólo de la sesión sino también del diálogo mismo. No obstante el estilo participativo del libro existen algunos altibajos debido tal vez a que los numerosos cortes de la sesión grabada provocan comentarios de procedimientos técnicos y digresiones teóricas que sin carecer de interés e importancia, van en detrimento de la apreciación global y continuada del discurso familiar. Esta dificultad se atenúa teniendo en cuenta que el objetivo de la obra es dialogar sobre el enfoque terapéutico del grupo familiar y no realizar el análisis conjunto de una sesión familiar.

Los entrevistados son fieles exponentes de la escuela interaccionista americana. Se basan en la noción de sistema tal como la define la teoría de la comunicación y la teoría de los sistemas y procuran llegar a un nuevo equilibrio familiar fundamentalmente por medio de técnicas de manipulación.

El Dr. Charles R. Fulweiler, de la Univ. de California, cree que "la terapia no es sino una forma de interacción entre seres humanos y uno (el terapeuta) desempeña su papel de la mejor manera posible; no es una herramienta científica que utilizamos para curar a la gente." Utiliza el sentido de la oportunidad, el humor, los juegos de palabras, la seducción, los discursos de preparación y sobre todo una técnica original: salidas y entradas de la sesión que sigue detrás del espejo unidireccional con el objeto de que la familia recree espontáneamente el conflicto en terapia y él sólo intervenga para estimular o encauzar la interacción puesta en marcha, interpretando cuando la situación queda perfectamente redondeada en busca de una experiencia nueva de mayor equilibrio. Aduce además que con

esta técnica evita que la sesión lo deje exhausto y controla mejor la contratransferencia, a la cual define y sortea de una manera no analítica y sumamente personal pero no discriminándola claramente de la transferencia cuando sostiene que "todas y cada una de las pautas de comunicación pasan a través de la persona del terapeuta". Tal vez este recurso, así como el largo discurso de presentación y la toma de un test en la primera entrevista parezcan un tanto evitativos en nuestro medio pero debemos tener en cuenta que en E.E.U.U. no se acostumbra trabajar la transferencia y la contratransferencia en psicoterapia.

La Sra. Virginia Satir encara de manera directa y segura a la familia. Sin preámbulos y sin más técnicas que las verbales conduce con pericia la entrevista manteniendo la estructura de la misma para que la familia se lleve una experiencia unitaria y coherente que fortalezca el yo de los miembros; tal vez podría reprochársele que estructura demasiado la entrevista no permitiendo que sea la familia quien lo haga más libremente. Actúa "como una suerte de pionero que va abriendo camino en un monte", avanzando continuamente. Su método es la persistencia, pero reasegurando al mismo tiempo a los pacientes para no obligarlos a un brusco enfrentamiento con sus conflictos. En cuanto a la interpretación de las emociones, se dirige, por ser el camino más fácil, al material más profundo y primario que da cuenta también de las reacciones afectivas secundarias. Pero cabe preguntarse si en momentos de tensión muy elevada, cambiar de tema es el único recurso de que puede disponer. Evidencia una amplia experiencia con familias de esquizofrénicos al señalar sus características a lo largo de la entrevista: no dejar crecer a sus miembros, no permitir el ingreso de extraños, los mensajes explícitos y las negativas rotundas. Pero tal vez se contradice al afirmar que no han llegado a la etapa del desarrollo que permita abordar el análisis de fan-

tasias incestuosas porque el caso que presenta las contiene y la terapeuta misma las tiene en cuenta, al menos, aunque no las interprete claramente.

El Dr. Don D. Jackson, de Palo Alto, que presenta un caso sumamente interesante, se muestra como un terapeuta muy hábil que sabe escuchar e intervenir breve y sutilmente, uniendo la espontaneidad a la cautela. A pesar de haber subrayado el aspecto de manipulación en la terapia resulta el menos manipulador, en apariencia, de los cinco terapeutas entrevistados. No asienta la estructuración de la entrevista en un encuadre rígido, sino más bien en una paulatina e intuitiva conducción del grupo familiar en pos de "una nueva manera de ver las cosas trastocando un sistema operativo y si es posible, luego, identificándolo." Evidentemente, apunta no a una comprensión de contenidos sino a un cambio de las reglas de comunicación mediante el uso de todas las técnicas propias de esta escuela. No obstante trabajar con un sistema, sostiene que la interpretación individual es más eficaz que la global. Es de suponer que esta opinión concuerda con su objetivo, que no es sino el de introducir nuevas pautas y disolver el doble vínculo que atrapa al esquizofrénico. Intenta rescatarlo de la trampa mediante claras alianzas con él, advertencias que le desliza desde el principio de la entrevista y señalamientos y aún directivas cuando persista en una pauta que lo encierra en un callejón sin salida. Pero podemos preguntarnos si la estructura del doble mensaje que comprende por lo menos dos términos en estrecha relación no requiere una interpretación más amplia que la individual que apunte a la estructura y no solamente al rescate del paciente atrapado en ella, más aún en un caso como el que nos presenta donde cualquier pauta patológica de comunicación se inserta y halla su significación en la relación triangular padre-madre-hija.

El Dr. Carl A. Whitaker, de la Univ.

de Wisconsin, considera que al comienzo se desencadena una lucha con la familia que consulta por determinar quién ha de controlar la situación. Su actitud es la de dejar en claro desde el primer contacto que es el terapeuta quien lo hace y el modo de concertar la entrevista resulta realmente sorprendente. Lo que en realidad persigue es el compromiso de los pacientes en la tarea desde el comienzo y trata de detectarlo a través de la contratransferencia: "Si me siento atado, sé que ellos también lo están". Al principio de la terapia y con toda deliberación busca que se produzcan hechos imprevistos, no planificados, con el objetivo de llegar a lo que llama "la expansión de límites". Su tarea es poner en marcha el proceso, pero una vez logrado, las situaciones se desarrollan por sí solas. El riesgo que corre es el de caer a veces en situaciones o justificaciones un tanto contradictorias. Critica la terapia de apoyo, que a su juicio es inútil en tanto posterga la batalla decisiva indefinidamente. No ve en la terapia una técnica de manipulación, sino una manera de ayudar a la familia a enfrentar sus problemas. Para ello utiliza técnicas de avance y retroceso, "sembrar ideas" subrepticamente, jugar con humor acerca de temas como el matrimonio, el incesto, las alianzas, la locura. Durante toda la entrevista prevalece el elemento lúdico en la tarea, ofreciendo a través de ella una experiencia nueva a la familia. Establece una interesante diferencia entre locura e insania pero cae en un quasi-elogio de la locura basándose en la mayor creatividad del psicótico. Hace interesantes reflexiones acerca de la seguridad que brinda el trabajo en coterapia así como una mayor productividad complementaria, aun teniendo que pasar por la prueba de que el paciente esquizofrénico logre escindir la pareja terapéutica; y en la entrevista que presenta sólo hay un estudiante observador que hace las veces de público para hacer surgir las aptitudes histéricas del

terapeuta.

El equipo constituido por el Dr. Frank Pittman III (psiquiatra), Kalman Flomenhaft (asistente social) y Carol de Young (enfermera Psiquiátrica) de la Univ. de Colorado, presentan una investigación que se propone evaluar los resultados de la aplicación de la terapia familiar breve (de una semana a dos o tres meses) para evitar que las personas víctimas de una crisis aguda deban ser hospitalizadas pues consideran a la internación como regresiva y estigmatizante. Se limitan a que la familia pueda superar la crisis inmediata mediante un modo diferente de asignar la responsabilidad entre los miembros de la familia. El proyecto enfoca primordialmente el cambio funcional utilizando una técnica operativa que apunta a definir el punto de urgencia familiar y el motivo desencadenante del síntoma para proponerle a la familia medidas concretas e inmediatas. Emplean indicaciones directivas que deben ser cumplidas rápidamente. Se consideran satisfechos si logran restituir el equilibrio existente antes de la aparición del síntoma. Luego procuran derivar a los pacientes a los correspondientes servicios comunitarios. Para cambios caracterológicos, derivan al paciente a un tratamiento a largo plazo. Se trata de una investigación muy bien planificada, pero donde el objetivo no es la terapia familiar en sí, sino fundamentalmente la movilización de la familia para impedir la internación. Por eso sorprende que un grupo terapéutico institucional con una elaborada ideología sobre criterios de salud y enfermedad y una sólida formación científica se limiten en la terapia al fortalecimiento yoico mediante directivas prácticas que no pueden ser suficientes sobre todo en aquellas familias que no derivan a tratamientos más prolongados y en las cuales el paliativo de esta brevísimas terapia y el seguimiento cada 6 meses no puede ser perdurable. Si bien desde el punto de vista metodológico formal nada se puede reprochar a esta

investigación, en cambio se podría discutir el supuesto sobre la internación del paciente agudo y el modo azaroso de aplicar la alternativa propuesta.

Finalmente, cabe señalar que en definitiva ninguno de los terapeutas de familia que en este libro exponen su técnica trata como método a la familia completa. Sobre todo llama la atención en el caso que presenta el Dr. Jackson, quien luego debió tratar por separado a los hijos que no incluyó en el primer tratamiento. El Dr. Fulweiler sostiene que nunca trata más de tres miembros "para evitar un número de interacciones excesivo" y piensa que "al modificarse el equilibrio interpersonal de una triada, todo el sistema se verá afectado". La Sra. Satir suele ver a toda la familia durante las primeras sesiones y más tarde puede tomar unidades diferentes por separado, pero siempre en el marco de la familia como un todo y nunca aísla una unidad como la más enferma; generalmente al principio atiende a los padres solos, pues entiende que siempre que hay un hijo perturbado, la relación conyugal ha sido desplazada a la relación padre-hijo. Al Dr. Whitaker, a pesar de haber citado a toda la familia, le cuesta encararla como sistema y admite que llega al todo pasando de un individuo a otro.

Evidentemente, el valor fundamental de este libro, tal como lo concibieron los autores, es el de promover el diálogo y la discusión sobre la práctica terapéutica. Así sucede al intentar comentarlo.

Stella Maris Molina

Edward Shorter. The Making of the Modern Family (La Formación de la Familia Moderna): Basic Books, New York 1975, 259 pag.

La terapia familiar tiene el poder de hacer para la historia social, lo que el psicoanálisis hizo para la biografía: proveerla de profundidad teórica y métodos científicos. El impacto de la psiquiatría familiar en el conocimiento histórico en general, pudo, de hecho, ser más accesible que aquel de sus predecesores freudianos, porque los temas de historia social —con el grupo familiar a la cabeza de la lista— proveen ahora la corriente principal de la investigación histórica. Al mismo tiempo la biografía ha sido reducida a un simple tributario y los tradicionales temas políticos se han virtualmente agotado. El auge de la historia de la familia corre parejo con el acrecentamiento de la terapia familiar. Hasta ahora, los historiadores de la familia, como otros practicantes de la "nueva historia", han dedicado su mayor esfuerzo a corregir las deficiencias de investigación de la historiografía tradicional, dominando las técnicas del análisis cuantitativo y aumentando los niveles de evidencia histórica. El problema del futuro será el de elevar la calidad de la interpretación.

Las glorias investigadas y las miserias teóricas de la historia de la familia están bien ilustradas en el libro de Edward Shorter, "La Formación de la Familia Moderna", que es descrito por su editor como la "primera historia comprensible de la familia moderna en la cultura occidental". Shorter amontona una impresionante cantidad de datos sobre temas tales como costumbres de noviazgo y matrimonio, razones de ilegitimidad y prácticas de la crianza del niño, y luego las usa para sostener una tesis psico-histórica, carente casi en absoluto de sofisticación psicológica. Brevemente, Shorter argue que la familia moderna es el producto de una "oleada de sen-

timiento" que se extendió sobre el Occidente en el final del siglo XVIII, reemplazando en el noviazgo consideraciones materiales con romance ("sexualidad afectiva"), en la crianza de niño indiferencia malthusiana con amor maternal, y en la vida de familia, supervisión comunitaria por domesticidad fortificada. (1).

Shorter adopta la idea del historiador francés Philippe Ariès, quien sostiene que la indiferencia materna hacia el niño, caracterizó la sociedad tradicional; pero él trata de modificar el encuadre temporal de su desaparición, para acomodarlo nuevamente a su fijación del final del siglo XVIII. Las viejas prácticas de atar a los niños como a momias y luego descuidarlos por largos períodos, o de dejarlos al cuidado de niñeras mercenarias, olvidándose completamente de ellos, constituye uno de los más tristes y terribles cuentos de horror en la historia, y Shorter lo relata bien. En parte como resultado de estas prácticas, en el siglo XVIII, un tercio de los niños perecían en su primer año de vida, y la mitad no llegaba a los veintiún años. La crianza tradicional del niño, como dice Shorter, era una "matanza espantosa de los inocentes". Y su intento de asociar su muerte con los cambios emocionales en la vida de la familia, es de una gran significación histórica.

La domesticidad, la última de "las tres grandes erupciones de sentimientos", descrita por Shorter, separó la vida de la familia de la comunidad, y la cambió de una unidad productiva y reproductiva a una unidad emocional. Con esto, comenzó la edad de la vida de la familia nuclear. Shorter aclara enfáticamente, que él se refiere aquí a un estado de la mente, y no a una serie de normas domésticas. El núcleo familiar es descrito como "un sentido especial de solidaridad que separa la unidad doméstica del entorno comunitario". "Nuclear" no significa un alejamiento de los parientes. Por el contrario, el retiro de la vida comunitaria es acompañado, de acuerdo a Shorter por un fortalecimiento de los lazos

familiares, por lo menos en el nivel emocional. "Los parientes, hoy", escribe Shorter, "extienden y complementan la estructura egoística y emocional de la familia conyugal".

¿Que es lo que provocó la gran "oleada de sentimiento" que transformó la vida de familia? En el penúltimo capítulo, titulado "Los motivos" (The Reason Why), Shorter ofrece una explicación tradicional sorprendente. El capitalismo —la liberación económica del individuo por un mercado económico— era, dice, la "variable dominante" en vigencia, en la primera revolución sexual de los tiempos modernos. En un capítulo final sobre la familia "post-moderna", Shorter identifica los comienzos durante los últimos 20 años, de una segunda gran revolución sexual, en la cual "las parejas flotantes", reemplazan el núcleo familiar, mientras que la libertad y la espontaneidad rompen todos los lazos y logran su apoteosis en el hedonismo, no sugiere ninguna variable dominante para esta segunda revolución.

A pesar de que "La Formación de la Familia Moderna", presentada al lector como una historia "comprensible", la mayor parte de su evidencia es tomada de Francia. Las fuentes en las cuales Shorter se nutre, son los relatos de doctores en medicina, burócratas de bajo nivel y anticuarios —lo que los franceses llaman "les erudits locaux". Como todos los buenos "nuevos historiadores" Shorter cuidadosamente señala las limitaciones empíricas de su evidencia y las generalizaciones que se extraen de ellas.

Todo esto es honesto y admirable. Pero Shorter revela las limitaciones intelectuales reales de su método y su propia pobreza teórica cuando se desplaza desde las descripciones de conducta, interferencias en la vida emocional y en el cambio de la personalidad, hacia el dominio de la psichistoria. A través del libro él sostiene que "la gran oleada de sentimiento" que comenzó al final del siglo XVIII representaba un triunfo de la libertad y la espon-

taneidad, tanto dentro de la familia como en otras áreas de la vida humana. El por lo tanto acepta el aparente significado de la explicación autoservida de esta revolución que fue originalmente ofrecida por los mismos revolucionarios: las generaciones cuyas sensibilidades se formaron y reflejaron en la literatura romántica y en la política liberal.

Si Shorter no hubiese desdeñado, a la manera de los historiadores sociales de moda, las "fuentes beletrísticas" y la riqueza de la crítica interpretativa que surgió alrededor de ellas, se habría prevenido contra las facilidades que acompañan a la retórica de la libertad y espontaneidad. "Autonomía" y "Espontaneidad" fueron las grandes ilusiones de la edad romántica. Y como René Girard explicó en "Metsonges romantiques et vérités romanesques", la revelación del "deseo mediato" detrás de estas ilusiones, fue uno de los grandes descubrimientos de los novelistas clásicos.

De la misma manera un conocimiento elemental de la teoría freu-

diana, hubiera salvado a Shorter de una aceptación ingenua de la retórica romántica. Pero incluso Freud tan sólo llegó a desentrañar las dependencias emocionales complejas y decepcionantes del núcleo familiar. Antes que los historiadores puedan entender realmente la poderosa atadura emocional que hace a la formación de la familia moderna, ellos deben tener acceso a una teoría comprensiva y convincente sobre la psicodinámica de la vida familiar.

Raymond Mac Kay

1) El colapso general de las prácticas de noviazgo tradicionales, antes del ataque vigoroso del movimiento social y físico, ha sido ampliamente estudiado, y Shorter de ninguna manera trata de alterar nuestra comprensión —aunque se esfuerza en concentrarse en lo que él considera que es el siglo pivotante, de 1750 a 1850. Más interesante son sus observaciones sobre la transición de las prácticas tradicionales en la crianza del niño a las prácticas modernas.

SIMPOSIUM

V SIMPOSIUM INTERNACIONAL

SOBRE PSICOTERAPIA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA

Entre los días 26 y 29 inclusive, se llevó a cabo organizado por el Instituto para la Pareja y la Familia, dirigido por el Dr. Joseph Duss von Werdt. En el ámbito del edificio de la Universidad, con una organización eficiente y ágil, se dieron cita terapeutas de distintas pares del mundo, especialmente Europa y EE.UU., para exponer sus ideas en forma de paneles, seminarios y grupos de trabajo.

En los idiomas oficiales, inglés, francés y alemán, se desarrollaron diariamente seminarios que versaron sobre aspectos teóricos y técnicos de la terapia de pareja y del grupo familiar.

Asimismo, dos veces por día se reunían los integrantes de cada grupo de trabajo por espacio de 3 horas junto con su coordinador, para enfocar aspectos específicos del tema y ver video-tapes de sesiones de grupo familiar, con discusiones posteriores. El día 27 se efectuó el Panel N° 1, bajo la dirección de Ingeborg Rücker Embden, de Heidelberg, con el tema de: **El hombre y la mujer como terapeutas**. Participaron Ruth BRACK, de Berna, Philippe CAILLE, de Oslo, Almuth MASSINGEN, de Göttingen, Robin y Prudence SKYNNER, de Londres y Rosmarie WALTER ENDERLIN, de Zurich.

El día 28 se efectuó el Panel II bajo la dirección de Jean Lemaire, de París, sobre el tema de: **Terapia de Pareja**, con los siguientes participantes: James y Mary FRAMO, de Filadelfia, Christa HOFFMAN - ZUR VERTH, de Suiza y Betty y Norman PAUL, de Boston.

Finalmente, el día 29, se desarrolló el último Panel sobre **Terapia de Familia**, bajo la dirección de Theodore LIDZ, de New Haven, con los siguientes participantes: Donald BLOCH, de New York; Nathan EPSTEIN, de Ontario; Luc KAUFMANN, de Lausana; Mara SELVINI PALAZZOLI, de Milán y Helm STIERLIN, de Heidelberg. En este Panel se decidió tomar un solo tema para abrir la discusión, cual fue la diferencia entre familias sanas y enfermas.

Cada autor resumió esquemáticamente su posición comenzando la Dra. SELVINI PALAZZOLI, quien postuló la **definición de la relación** como condición para que una familia sea sana. Asemejó la familia a los sistemas vivientes, poseedores todos de una jerarquía, de variables esenciales y accesorias. Así como una fábrica funciona bien y coherente si la comunicación responde a la jerarquía que el organigrama postula, una familia tiene un organigrama que define las jerarquías y las relaciones entre ellas.

El Dr. STIERLIN agregó: La capacidad para diferenciarse y expresarse emocionalmente, como condición esencial tendrá un buen funcionamiento, siempre y cuando se tenga en cuenta la conexión con la sociedad como factor de regulación y reciprocidad. Esto evitaría la formación de familias tipo "mafia", que viven explotando la sociedad o aquellas como la de Eichmann, que era un excelente padre a la vez que genocida.

Luc KAUFMANN señaló que no todas las familias jerárquicas y coherentes son sanas, si no se toma en cuenta la creatividad individual, a veces suprimida en aras de un orden convencional.

BLOCH enfatizó sobre la necesidad de incorporar la alegría vital como índice de salud, señalando que a veces las familias sanas suelen ser muy aburridas, por lo que a veces pareciera que una dosis de "locura" fuera necesaria. Esto

motivó una vehemente intervención de EPSTEIN, quien señaló los peligros de una visión antipsiquiátrica de la terapia de familia donde pueda idealizarse la psicosis, cuando en realidad ésta es una manera de evitar el sufrimiento que existe en familias sanas y creativas como condición normal.

El público participante en este Congreso siguió sus alternativas con interés sostenido y es de señalar su composición heterogénea, ya que

además de médicos y psicólogos incluía asistentes sociales, consejeros juveniles y de familia, sociólogos y filósofos, lo que muestra que el campo de la terapia familiar reviste interés no sólo profesional o técnico, sino también como fenómeno cultural de amplia repercusión en todos los estamentos de la sociedad.

El 6º Congreso se realizará desde el 26 al 29 de setiembre de 1979, en la misma sede.

A. Canevaro

CONGRESOS

VI CONGRESO MUNDIAL DE PSIQUIATRIA

Entre los días 28 de Agosto y 3 de Septiembre de 1977 se desarrolló este Congreso en la ciudad de Honolulu - Hawai, organizado por la American Psychiatric Association. Con una concurrencia numerosa desde casi todos los países del mundo, se presentaron más de 1.600 trabajos, distribuidos en 11 sesiones plenarias, 138 simposium y alrededor de 1.000 comunicaciones libres.

Si bien algunos de estos artículos serán publicados en extenso en esta misma revista, hemos extractado los resúmenes de la casi totalidad de ellos concerniendo a la terapia familiar.

De las 11 sesiones plenarias, una de ellas fue dedicada a los conflictos intergeneracionales y 4 de los simposium tomaron aspectos teóricos, clínicos y sociológicos del grupo familiar tomado como unidad básica de tratamiento.

DR. MARTIN de ORO

SESION PLENARIA SOBRE CONFLICTOS INTERGENERA- CIONALES EN UN MUNDO CAMBIANTE.

CONFLICTO INTERGENERACIONAL: PSICOPATOLOGIA Y SALUD MENTAL

M. Fakhr El-Islam, FRCT, FRC psych.
Ministerio de Salud Pública, P.O. BOX
42, Doha, QATAR.

El conflicto entre las generaciones viejas y jóvenes está basado en diferencia de valores y actitudes. Comienza a menudo en la adolescencia con la búsqueda de un sentido de identidad. Los valores parentales internalizados y las relaciones objetales son desafiados por valores grupales semejantes. Los jóvenes a menudo están en un estado de fluctuación y sus mayores en una mezcla de envidia y hostilidad hacia los jóvenes.

Se sugiere que el conflicto intergeneracional es intensificado patológicamente cuando las prácticas de crianza de los niños enfatizan las dimensiones de nutrición y dependencia, en individuos con separaciones previas o traumas de rivalidad, con grandes discrepancias entre las orientaciones de valores existentes, en sociedades rápidamente cambiantes, donde las dos generaciones comparten la misma casa, donde las áreas de conflicto son altamente valorizadas, y donde el grupo de semejantes no puede proveer un medio saludable para trabajar a través del conflicto.

Se discute la necesidad de investigar el conflicto intergeneracional y la implicancia terapéutica de su reconocimiento.

BURLA A LOS ANCESTROS: EL CON- FLICTO INTERGENERACIONAL COMO UNA GENERALIDAD HUMANA.

John Cawte, MD., Ph. D. Prince Henry -
Hospital, Little Bay, N.S.W. 2036 -
Australia

El conflicto intergeneracional como resultado de un rápido cambio socio-

cultural, se diferencia de aquel que ocurre en el mundo relativamente inamovible del "hombre de las cavernas". Los estudios de una sociedad tribal aborigen en Australia, antes del advenimiento de la era moderna, revelaron la existencia de una sociedad graduada en edades, con severos conflictos entre las generaciones. En esta sociedad gerontocrática, los mayores monopolizaban el conocimiento secreto, el poder, y el control de las mujeres. El conflicto inherente con las generaciones más jóvenes era suprimido con poderosas expectativas sociales, respaldado por ejecuciones ocasionales de hombres jóvenes a causa de errores religiosos. "La burla a los ancestros", es el disconformismo y la conducta rebelde de la juventud.

En comparación, el conflicto intergeneracional en la sociedad moderna, no es suprimido, sino ventilado: es atenuado y más equilibrado. Proviene de construcciones culturales competitivas de la realidad. Se muestra el uso de un repertorio para especificar las construcciones culturales de la realidad. Las construcciones culturales de la realidad de un aborigen anciano, se contrastan con las de un anciano samoano. Las construcciones de la realidad del primero, son algo que invitaría a los jóvenes identificados con el mundo moderno, a la burla.

EL COMPLEJO DE EDIPO EN NUESTRA SOCIEDAD CAMBIANTE: CON ESPECIAL REFERENCIA A COREA:

Kwang - Iel Kim, M.D., Departamento de Neuropsiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de Hanyang, Seúl, Corea.

Las formas arcaicas de resolver el complejo de Edipo, han sido comparadas entre la mitología coreana y la griega. En la Corea tradicional la lucha edípica ha existido verdaderamente, pero ha sido sublimada exitosamente a través de canales culturalmente aprobados. Ni siquiera en el mundo de la fantasía hubo actos de parricidio ni de incesto.

El medio humanístico de la gran familia, el "hyao" y la forma de vida oriental son atribuidas a las pautas culturales para soluciones deseadas. En el pasado, el complejo de Edipo no era tan serio ni

aun en la enfermedad mental.

Recientemente, las manifestaciones edípicas son más explícitas y serias en muchos pacientes mentales, debido al colapso de la cultura tradicional y provocando considerables conflictos intergeneracionales.

La universalidad del complejo de Edipo también es discutida brevemente.

SIMPOSIUM SOBRE FAMILIAS Y NIÑOS EN UN MUNDO CAMBIANTE

FAMILIAS Y NIÑOS EN UN MUNDO CAMBIANTE.

B.K. Ramanujan M.D. B.M. Instituto de Salud Mental, Ahmedabad - 38000 India.

Los patrones de conducta de los niños parecen ser determinados por los roles paternos de relación y por otros significativos de la familia. Estos roles paternos, varían en distintos tipos de familia, desde el grupo doméstico pasando por varios grados en familias numerosas. Pretendemos estudiar el proceso involucrado y el impacto de ellos, en niños en crecimiento a través de un método de estudio.

Ocho niños y sus familias pertenecientes a una unidad nuclear y ocho niños de familias numerosas, del B.M. Instituto de Salud Mental, fueron estudiados exhaustivamente. Dieciséis sujetos de poblaciones no-clínicas fueron seleccionados como muestra semejante para ser estudiados comparativamente.

Algunas prácticas existentes en la crianza de niños, surgieron del estudio. Las variaciones de roles estructurales y funcionales en familias nucleares y familias numerosas, fueron revistas. Se notaron también algunos patrones imitativos significativos de los niños. Niños que tenían un bajo nivel de ansiedad, manifestaban una conducta evasiva al cumplir tareas. Niños con un alto nivel de ansiedad mostraron síntomas tales como aislamiento, inhibición y en general una actitud defensiva hacia las tareas. Se discute las implicaciones psicosociales más amplias.

EVALUACION CRITICA DE ESTUDIOS CONCERNIENTES CON MEDICION DEL IMPACTO DE GRUPOS REGULARES DE ATENCION DIURNA EN LA SALUD MENTAL DEL NIÑO DE 0 A 3 AÑOS.

Jean Francois Saucier, M.D., Ph.D. Departement de Psychiatrie, Université Montréal, Canada.

No tenemos información suficiente para estar capacitados para medir con exactitud el impacto de grupos regulares de atención diurna, en la salud mental de niños pequeños, principalmente por la escasez de estudios sistemáticos y los consiguientes defectos de los mismos: 1) los grupos de atención diurna observados, no son representativos de la mayoría de centros de atención diurna; por ejemplo, muchos tienen un porcentaje de un adulto por cada 4 o 5 niños; 2) en muchas medidas (ej. en separación ansiosa) los niños de diferentes edades, de 3 meses a 6 años, están mezclados, a pesar de que estos grupos de edades reaccionan al mismo estímulo en forma distinta; 3) el nivel de adaptación de los niños no se mide frecuentemente antes del comienzo de exponerlos a la atención diurna; 4) la "extraña situación" de Mary Ainsworth es utilizada a menudo para medir las reacciones a la separación, a pesar de que esa medida nunca ha sido normalizada, es decir, nosotros no sabemos que grado de comportamiento es normal y cual es patológico; también la misma medida es a veces usada para todos los niños de hasta 3 años, a pesar de que es de validez decreciente después de los 21 meses; 5) muchos estudios miden solamente una vez las diferencias de comportamiento entre niños expuestos a la atención diurna, y aquellos educados en su casa; de manera que es una base débil para hacer juicios de impacto; 6) muy pocos estudios son realmente longitudinales o cubren periodos suficientemente largos; 7) muy a menudo, los ejemplos son muy escasos, y lo que es más importante, tan sólo originados en la clase media.

PADRES E HIJOS EN UN MUNDO CAMBIANTE.

(Referencias africanas). E.F. Thebaud, M.D. Hospital de Rehabilitación "Catherine Mills", Monrovia, Liberia.

Se ha hecho un intento para integrar el pensamiento psicológico con el antropológico. El concepto de cultura como un instrumento de adaptación e integración del individuo dentro de la sociedad, ha sido considerado suficientemente valioso.

El Africa de hoy se caracteriza por la coexistencia de instituciones tradicionales tales como "The Society Bush School" y escuelas que proveen educación occidental. Los conflictos surgen entre padres que desean retener su autoridad, e hijos que se han dado cuenta que la fuente del conocimiento no reside tanto en la edad como era anteriormente, sino en la adquisición y en la especialización de las técnicas. Sin embargo, la falta de internalización de los nuevos valores, es una fuente de inseguridad para la juventud.

SIMPOSIUM SOBRE TERAPIA FAMILIAR Y LA ECOLOGIA CAMBIANTE

SINTOMAS SOMATICOS RECURRENTES EN LA ADOLESCENCIA.

Stuart H. Fine, M.D. División de Psiquiatría Infantil, University of British Columbia, 717 West 10th. Av. Vancouver, British Columbia, Canada.

Los síntomas somáticos recurrentes en los adolescentes, son frecuentemente máscaras para la psicopatología individual y familiar. La ecología cambiante se refleja en adolescentes, quienes frecuentemente suelen tener el temor de que si toman drogas, pueden resultar con

un daño físico irreversible. Se ha descubierto que esto es un factor que causa síntomas somáticos recurrentes.

A raíz de la alienación experimentada por muchos adolescentes, ellos usan juguetes de paño, como los más pequeños, para sentirse confortados y usarlos como objetos transitorios.

También en nuestra sociedad se mantienen en secreto ciertos asuntos. El secreto de las tensiones familiares, puede sólo revelarse después de varias entrevistas. Una vez que estas tensiones han sido sonsacadas, ocurre la catarsis y el alivio de los síntomas.

La combinación de grupos terapéuticos para la familia y el adolescente, han demostrado ser efectivos en asuntos tales como: Pesquisar preocupaciones sobre drogas; reemplazar objetos transicionales a través de la comunicación con la familia; y ventilar las preocupaciones sobre los "secretos de familia".

PARAMENTROS DE TERAPIA FAMILIAR Y SU APLICACION EN UNA UNIDAD RESIDENCIAL DE ADOLESCENTES.

Contribución al Simposio sobre Terapia Familiar y la Ecología Cambiante. Grace A. Kutasi. M.S.W. British Columbia Young Development Centre, Burnaby, B.C.

Vivimos en una época de rápidos cambios sociales, en la que hay poca claridad respecto a las reglas de comportamiento aceptable, tanto para el individuo como para la familia, en familias bajo tratamiento terapéutico, que tienen adolescentes seriamente perturbados, encontré una necesidad cada vez mayor de fomentar la reflexión sobre estas posturas poco claras, y de encontrar soluciones más flexibles.

En este trabajo se discuten los medios por los cuales un terapeuta puede utilizar formas variadas de terapia familiar-terapia matrimonial, el acercamiento múltiple familiar; terapia para los hermanos; en esencia, terapia en

cadena- para ayudar a la familia a que se involucren en una experiencia de desarrollo para toda la unidad, más que la concentración per se, en algún miembro individual.

REVITALIZANDO EL SISTEMA FAMILIAR; REORGANIZANDO EL NUCLEO FAMILIAR AISLADO.

David S. Freeman, D.S.W. School of Social Work, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

En este trabajo se discuten las maneras por las cuales un terapeuta puede ayudar a las familias a superar su aislamiento básico. En mi experiencia clínica descubrí que cuanto mayor es el aislamiento del núcleo familiar de otros significativos, como ser miembros de la familia más lejanos, amigos, o vecinos, mayor es la disfunción. Es comparable a la situación de individuos aislados que cuentan con pocos recursos o sistemas de apoyo, y que reciben poca energía del entorno, lo que los torna en consecuencia menos capaces para encontrar sus necesidades internas, y sus expectativas externas.

Este trabajo bosqueja los medios por los que un terapeuta puede ayudar a los miembros de una familia a conocerse a sí mismos, a través de un replanteo de sí mismos en la relación con otros personajes significativos. El proceso de conocer la historia personal de cada uno (raíces históricas), pasando de una posición reactiva a una activa, relacionándose con otros, aprendiendo a procesar información de una manera nueva, sobre sí mismo y sobre los otros, será lo que discutiremos aquí en detalle.

Se demostrará que estos procesos pueden ser utilizados para proveer a los miembros de la familia, una nueva fuente de energía creativa.

COMUNICACION SEXUAL Y EXPECTATIVAS DE SEXO:

Contribución al simposio "TERAPIA FAMILIAR Y ECOLOGIA CAMBIANTE". Graham F. Knigh-Webb. M.D. Departamento del Niño y del Adolescente. (Psiquiatría) University of British Columbia.

La mayor facilidad con que pueden ser exploradas las actitudes sexuales dentro de la estructura familiar, ha creado la necesidad de una reevaluación de las ataduras emocionales y sus resultados. Este trabajo es un esbozo de las observaciones que conciernen a las dificultades que acosan a muchos adolescentes en su intento de lograr independizarse de sus familias.

Se considera al incesto como un posible paradójico intento, el resultado de una mala comunicación, y como una amenaza que puede dar pie a que tenga lugar una individuación de distintas cualidades. Se discute la necesidad de una mayor discreción con respecto a la apreciación legal de los compromisos sexuales intra familiares.

Se investiga la transferencia de temas sin resolver desde la familia de origen a la familia de procreación, especialmente en el área de conformidad y expectativa marital, a la luz de mayores requerimientos sociales para la igualdad en el matrimonio.

DOS INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DE LOS SENTIMIENTOS FAMILIARES.

Eva Bene. Ph.D. University of British Columbia, Department of Psychiatry, Vancouver, B.C. Canada.

Esta contribución al "SIMPOSIO DE TERAPIA FAMILIAR Y ECOLOGIA CAMBIANTE" es sobre dos investigaciones

cuyos resultados pueden ser de interés para el terapeuta. La técnica usada en ambos fue el test Bene-Anthony de Relaciones Familiares.

La primera investigación tuvo que ver con la incidencia de depresión mayor entre mujeres casadas que entre hombres casados. Los resultados indicaban que menos mujeres que maridos encuentran su matrimonio satisfactorio.

La segunda investigación es sobre el desarrollo emocional de adolescentes. Los resultados de esta investigación sugieren que los adolescentes amados por sus padres, tienden a denigrar el amor de sus padres, probablemente porque esto los ayuda en su lucha por la individuación y la separación. Sin embargo, los varones adolescentes, que no son amados por sus madres, tienden a aferrarse a ellas como niños menores.

SIMPOSIO SOBRE TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS: APROXIMACION A ESTUDIOS DE FAMILIA

VARIACIONES CULTURALES CRUZADAS EN LA COMUNICACION FAMILIAR.

Lyman C. Wynne, M.D. University of Rochester Medical Center, Rochester, New York, U.S.A. 14642.

Dentro de las familias americanas de clase media, se han identificado los patrones de comunicación que diferencian a las familias de esquizofrénicos, de las otras familias. Un tema importante conceptual y metodológico para tales estudios, ha sido: los sistemas de comunicación en familias psiquiátricamente perturbadas, son similares o diferentes de las variaciones entre familias que son psiquiátricamente

sanas pero que provienen de distintos medios culturales, educacionales y socioeconómicos?

Las observaciones relevantes a este tema serán revistas sobre datos y experiencias del autor y sus colegas, en un pueblo rural Muslin libanés, en Japón, en Inglaterra, y otras áreas urbanas americanas de barrios bajos. Los métodos para el estudio de las familias pueden ser modificados para ser coherentes con el contexto cultural; cuando estas modificaciones metodológicas han sido cuidadosamente introducidas, los patrones de comunicación de la familia asociados con una severa psicopatología, pueden aún ser diferenciados. El estudio de los lazos de cada familia como un sub sistema de su contexto cultural específico (incluyendo el ámbito del tratamiento) es esencial para el éxito de cada investigación.

— ESTILOS TRANSACCIONALES DE LA FAMILIA.

Margaret Thaler Singer, Ph. D. University of California, Berkeley, California, U.S.A.

Cuando los hijos se desprenden de sus experiencias familiares, a través de los años, internalizan cualidades estilísticas para la transacción, que caracterizan a su familia como pequeños sistemas sociales. Notamos que lo que los hijos internalizan son los rasgos de atención, lenguaje, razonamiento y afecto, que caracterizan los estilos transaccionales de sus sistemas familiares completos. Se presentarán datos para la investigación, considerando la familia desde el punto de vista sistémico, usando una visión epigenética del desarrollo a lo largo del tiempo y un impacto multidireccional de los miembros de la familia entre sí.

— TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS COMO APROXIMACION AL ESTUDIO DE LA FAMILIA.

Stephen Fleck, M.D.; Nathan Epstein, M.D.; Ira Glick, M.D.; Dr. Norman Sartorius; Dr. Margaret Singer; George Vassiliou, M.D.; Ms. Vasso Vassiliou; Lyman Wynne, M.D.

Este trabajo se dirigirá a llenar una ausencia en la literatura sobre tratamientos familiares unitarios: un proceso sistematizado para la evaluación clínica, y el establecimiento de indicaciones terapéuticas para familias. El esquema se deriva de la Teoría de Sistemas Generales, y enfoca un sistema de cinco parámetros: liderazgo, fronteras, fuerzas afectivas, comunicación y ejecución de tareas y metas. Estos constituyen las funciones básicas del sistema familiar, en casi todas las culturas. La colección de datos para el logro del funcionamiento familiar en estos cinco sectores, toma en cuenta tanto las dimensiones verticales (históricas), y horizontales (interaccionales). Un estudio detallado de las funciones familiares, durante las varias etapas de evolución del ciclo de vida familiar, debe ser cotejado con información de entrevistas familiares, similar a las deducciones e inferencias que un psicoterapeuta hace en base a los datos de la entrevista diádica y su conocimiento del pasado específico de su paciente, de su estructura caracterológica y del desarrollo de su personalidad.

De esta manera una familia puede ser examinada y evaluada en su competencia sin tomar en cuenta su estado evolutivo y los valores variables de composición o subculturales.

— INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LA TERAPIA FAMILIAR.

Ira D. Glick, M.D. y David Kessler, M.D. University of California, School of Medicine, Department of Psychiatry,

Langley Porter Neuropsychiatric Institute, San Francisco, CA, USA 94143.

Como parte de un simposio titulado "Teoría General de los Sistemas como Aproximación al Estudio de la Familia" para el Sexto Congreso Mundial de Psiquiatría 1977, este trabajo complementará otros sobre sistemas de familias. Enfocherà específicamente indicaciones y contraindicaciones relativas para la terapia familiar. El trabajo tratará sobre indicaciones clásicas, contraindicaciones relativas y absolutas y nuevas direcciones en las que incursiona este campo (ej. indicaciones por clasificaciones psiquiátricas, clasificaciones sociológicas, y a través de la disciplina).

La revisión combina la mejor investigación de datos, como también la visión de los autores sobre el consenso en este terreno.

DIAGNOSTICO MULTIAIXIAL PARA EL PACIENTE: LA INCLUSION DE SISTEMAS CARACTERISTICOS DE FAMILIA.

John S. Strauss, M.D. Yale Psychiatric Institute, Department of Psychiatry, Yale Medical School, New Haven, Connecticut, USA.

El diagnóstico multiaxial clasifica a los pacientes registrando cada una de las características independientes, tales como cuadros sintomáticos, clases de desorden psiquiátrico y funcionamiento social, más que el diagnóstico tradicional de combinar estas características bajo un rótulo individual. Recientes adelantos en el diagnóstico psiquiátrico dan las pautas de las muchas ventajas del sistema diagnóstico multiaxial sobre el tradicional rótulo individual. Pero, se puede extender un modelo de diagnóstico multiaxial, para el paciente individual, incluyendo características familiares relevantes? Este

trabajo describirá las importantes razones que llevan a tomar tal decisión, y los problemas involucrados. Será presentado una prueba de estructura para agregar las características familiares al diagnóstico multiaxial para el paciente individual.

SIMPOSIUM SOBRE PSICOTERAPIA DE FAMILIAS PRIMORDIALMENTE LATINAS

PSICOTERAPIA DE FAMILIAS PRIMORDIALMENTE LATINAS. ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LAS FAMILIAS LATINOAMERICANAS Y SU RELEVANCIA EN LA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE ENFERMEDADES MENTALES.

Hector R.

Corzo, M.D. University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109, USA

Un conocimiento adecuado de la cultura latinoamericana con énfasis en la cultura centroamericana, es importante para entender los orígenes de enfermedad mental en estos países, el mantenimiento de ésta, así también para un manejo adecuado desde el punto de vista de prevención y tratamiento.

Una variedad de aspectos teóricos relevantes a las familias latinas serán considerados, particularmente los relacionados con los efectos de la influencia familiar (abuelos, padres, hermanos, etc.) en el individuo (niño, adolescente, adulto, etc.).

ESTUDIOS DE LA PERCEPCION Y COMUNICACION EN PSICOTERAPIA DE LA FAMILIA.

Robert B. Shapiro, Ph. D.,
Madeleine Gomez, M.D., Ravenswood
Hospital Community Mental Health Center,
Chicago, Illinois, USA

Este trabajo de investigación fue hecho con el propósito de investigar los procesos interpersonales perceptivos y comunicativos dentro del sistema de la familia, utilizando los tests de 1. lista de chequeo interpersonal antes y después del tratamiento 2. entrevista de la familia y 3. congruencia en la familia.

Se usaron los criterios siguientes a) que la psicoterapia de familia fuese de corta duración, b) que hubiese un mínimo de tres miembros de la familia de más de diez (10) años de edad, c) que los miembros familiares vivan juntos d) que ninguna de las familias sufran de psicosis, de adicción a drogas o alcohol.

Los resultados obtenidos en 52 familias de extracción europea, latina y africana fueron que la psicoterapia de familias de corta duración mejora las comunicaciones de los miembros de la familia y que la forma en que los miembros se perciben hacia sí mismo o hacia los otros miembros familiares aumenta globalmente. La importancia de este estudio es que aunque este fenómeno se había observado clínicamente nunca fue medido por los instrumentos anteriormente enumerados. Una discusión seguirá.

PSICOTERAPIA FAMILIAR EN UNA INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL

Raymundo Macias M.D. Instituto Mexicano
del Seguro Social, México, D. F. México.

Se describen brevemente los niveles de atención en Psiquiatría y Salud Mental

en un Sistema de Seguridad Social, y la atención familiar en función de los niveles de acción terapéutica factibles de acuerdo a los recursos de la Institución, dentro del Sistema Médico-Familiar.

1) Un primer nivel de comprensión dinámica de la familia, de apoyo psicoterapéutico y orientación general que puede ser atendido por los propios médicos familiares. 2) Un segundo nivel de manejo terapéutico familiar, con orientación estructural funcional, tendiente a reeducar, modificando actitudes y conductas del Sistema Familiar y con un enfoque activo y breve puede ser realizado por los equipos de Salud Mental de las clínicas. 3) Un tercer nivel — considera la posibilidad de una intervención psicoterapéutica más profunda y a mayor plazo, orientada a lograr cambios en la estructura dinámica de la familia, por terapeutas entrenados en los Centros de Salud Mental.

Se propone un esquema de evaluación dinámica de la familia para definir la selección de casos y los objetivos terapéuticos. Finalmente se plantean niveles de entrenamiento para preparar el personal necesario, que asegure — su intervención oportuna y adecuada.

15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PSICOTERAPIA DE FAMILIAS.

Evaristo Gómez, M.D.
George J. London Memorial Hospital y
Universidad de Illinois, Chicago, Illinois,
USA.

Esta ponencia describirá en parte algunas experiencias psicoterapéuticas en el tratamiento de familias por los últimos 15 años haciendo hincapié a las familias latinas.

Desde que la psicoterapia de familias estaba en pañales y comenzó en el mundo de la psiquiatría el autor empezó a envolver inmigrantes del Marrueco español en esta modalidad de tratamiento en la ciudad de Montreal del Canadá y más luego familias latinoamericanas en la

ciudad de Chicago, E.E.U.U.A ya sea inmigrantes recientes o familias que viviesen por generaciones en esta ciudad nortea. Se discutirán las vicisitudes obtenidas, los problemas al comienzo del tratamiento y las modificaciones de las técnicas en comparación con las usadas en la familia americana. Se ha dicho que la interacción en la familia es una condición casi "sinequanon" para el mejoramiento y entendimiento de sus miembros, pero la familia latina interacciona espontáneamente, de por sí, así es que hay que tratar el problema rápidamente sin seguir etapa por etapa como se describe en los libros de texto. El autor ha tratado más de 500 familias pero solamente un 20% latinas debido a la falta de aceptación y otras variables que serán discutidas a fondo. Algunas sinopsis clínicas serán dadas.

SINDROME DE NEGLIGENCIA MATERNA.

Ramiro Coello-Cortes, M.D. London
Memorial Hospital, The Chicago Medical
School, Chicago, Illinois, U.S.A. y
Tegucigalpa, D.D. Honduras, C.A.

El propósito de esta ponencia es elucidar las características clínicas, factores contributivos, tratamiento y pronóstico del SINDROME DE NEGLIGENCIA MATERNA tal como se ha observado en familias de la República de Honduras en Centro América. Este síndrome se considera como un serio problema social, pediátrico y psiquiátrico debido a su alta incidencia de morbilidad y mortalidad infantil. La psicoterapia de familia, en sus diversas modalidades, se presenta como la más efectiva herramienta terapéutica para este desorden. Sin tratamiento el pronóstico es pobre.

COMUNICACIONES LIBRES.

EL PSIQUIATRA DE LA FAMILIA COMO MEDICO DE CABECERA.

David Rubistein M.D. Temple University,
School of Medicine, Philadelphia, Pa. USA.

El tratamiento de la familia por un psiquiatra, representa una modalidad en los servicios primarios de salud. Significa que el cuidado comprensivo psiquiátrico es provisto a grupos de toda edad, por un médico personal. El puede otorgar atención psiquiátrica personalmente o a través de otros, bajo su coordinación y supervisión.

El psiquiatra familiar apunta a aspectos ecológicos de individuos en las familias y entre familias y su medio ambiente. Este trabajo también examina el desarrollo de la psiquiatría familiar, como una nueva perspectiva y acceso a la psiquiatría. Desmostrará comparaciones y roles paralelos dentro de las tendencias contemporáneas en medicina.

En este contexto, debe considerarse al terreno de la terapia familiar como una rama de una disciplina más amplia de la psiquiatría familiar.

PSICOTERAPIA DE LA FAMILIA COMO UNA MEDIDA PARA PREVENIR RECAIDAS Y MEJORAR EL PRONOSTICO EN PACIENTES ESQUIZOFRENICOS.

Cazzullo C. L., Carta I. Department of
Psiquiatry, University of Milano, Italy.

La psicoterapia de la familia de pacientes esquizofrénicos se usa para la

mayoría de las familias de personas jóvenes que han estado viviendo con las familias en la época del primer episodio psicótico. Las sesiones familiares se realizan en la casa y también en el instituto, como para pacientes ambulatorios. El propósito de esto es: 1) reducir o aliviar la severidad de aquellos factores familiares psicogenéticos que han tenido efectos negativos en los sujetos; 2) obtener modificaciones estructurales y funcionales en el grupo familiar; 3) mejorar la comunicación dentro de la familia de manera de corregir medios de comunicación distorsionados o abiertamente patógenos. Estudios posteriores han demostrado el valor profiláctico de este programa familiar.

DESARROLLO DEL NIÑO EN ESTILOS DE FAMILIAS DIFERENTES.

Bernice T. Eiduson Ph. D. University of California at Los Angeles, California, U.S.A. 90024

Doscientos niños pequeños e infantes que están creciendo en una variedad de estilos de vida familiar en California, están siendo estudiados desde su nacimiento a través de los primeros seis años de vida. Cincuenta de ellos están creciendo en grupos comunitarios; cincuenta en familias donde los padres no están casados; cincuenta en casas de padres solteros (madre); y cincuenta (grupo comparativo) que nacieron y fueron criados en el núcleo familiar tradicional de hoy en día con los padres. Las diferentes familias representan los intentos de reestructurar la unidad familiar de acuerdo con los valores e ideologías de los adultos jóvenes en el mundo -humanitarismo, igualdad sexual, identificación con los aspectos orgánicos naturales de la vida, antiintelectualismo, filosofía de ayuda propia y una indiferencia hacia las instituciones existentes sociales y médicas.

Los resultados demuestran que estos sistemas de valores, han provocado modificaciones en las actitudes y prácticas de la crianza del niño entre las diversas familias. Más aún, algunas de estas modificaciones están siendo rápidamente difundidas dentro de la corriente cultural, y pueden inclusive detectarse en los núcleos familiares tradicionales de los padres.

Estos hallazgos también apuntan a los modos en los que las diferencias en la composición y estructura familiar afectan el rol paternal y la interacción entre padre e hijo. Los resultados de los exámenes pediátricos y nutricios, los tests intelectuales, y las medidas socioemocionales, no reflejan estas diferencias fundamentales en el medio familiar al año del niño, pero ciertos aspectos sugieren que algunas variables familiares, tales como estabilidad de residencia y estilo de vida, provocarán desajustes en los años preescolares.

NIÑOS DE SEXUALIDAD ATÍPICA.

Richard Geen M.D. Department of Psychiatry, State University of New York, Stony Brook, New York U.S.A.

Durante los últimos diez años, la investigación del autor ha estado dirigida a niños cuya identidad sexual es atípica, pero cuyos padres tienen una identidad sexual típica. La nueva investigación presentada aquí representa la estrategia inversa. Son descriptos treintacinco niños cuyos padres son transexuales u homosexuales. Un cuarto de ellos han sido criados por hombres que fueron anteriormente mujeres. Otra cuarta parte por mujeres que fueron anteriormente hombres. Una mitad criada por mujeres homosexuales. La mitad de los niños son varones, y la otra mitad, mujeres. Su edad varía de los tres a los veinte años. Estos niños han vivido en esos hogares sexualmente atípicos, de uno a dieciséis

años. Todos los niños que han llegado a la adolescencia, manifiestan orientaciones heterosexuales exclusivamente; ninguno de ellos es transexual. Todos los niños prepúberes con una sola excepción son absolutamente normales en su identidad sexual dentro de los límites de su edad, sexo y cultura. Las conclusiones de este estudio piloto, intentan demostrar que los padres con una identidad sexual atípica, expresada en forma de transexualismo u homosexualidad femenina, no provocan en sus hijos una identidad sexual atípica.

TERAPIA FAMILIAR DINAMICA PARA LA INCAPACIDAD EN EL APRENDIZAJE.

Shahzad Fozouni Ph. D. Iradj Siassi M.D. National Iranian Society for Rehabilitation of the Disabled, Kh. Shahreza, Kh. Sarshar, 34 Tehran, Iran.

Hace tiempo que se ha reconocido la asociación entre problemas emocionales e incapacidad en el aprendizaje. La incapacidad para el aprendizaje en el niño, provoca siempre intensos sentimientos de ambivalencia en los padres, de los cuales pueden ser concientes o no. Este trabajo expone el impacto de la terapia familiar psicoanalíticamente orientada para aliviar las dificultades de estos niños para el aprendizaje. Sesenta y ocho niños impedidos educacionalmente (todos varones) fueron asignados al azar en dos grupos; uno, que recibía terapia familiar y otro grupo controlado que no la recibía. El progreso de las actividades escolares los niños fué supervisado después de tres meses, seis meses y doce meses. Al final de los tres meses ambos grupos manifestaron evidentes mejoras, que obedecían al tiempo transcurrido y a su estadía en un centro residencial muy sofisticado. Sin embargo, después de los

seis meses y nuevamente después de los doce, la mejoría de los niños del grupo que estaba en terapia familiar era significativamente mayor que aquella del grupo controlado. Este trabajo, presenta y discute los antecedentes demográficos de los niños, el grado de la incapacidad en el aprendizaje, junto con el porcentaje global de las dificultades y progresos de los niños a través de sus maestros en momentos dados. Finalmente este trabajo discute las implicancias de este estudio para la educación especial de niños que sufren de incapacidad educacional.

EL GRUPO FAMILIAR MULTIPLE PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES PSICOTICOS EN COMUNIDAD TERAPEUTICA PSICOANALITICA.

Dr. Jorge García Badaracco Clinica Psiquiátrica O'Higgins 2323 Bs. As. Arg.

El autor continuó una serie de trabajos sobre el aspecto teórico-clínico de esta técnica aplicada en comunidad terapéutica psicoanalítica, la considera como un contexto de mayor seguridad donde puedan resolverse intensas transferencias marcísticas y relaciones de objeto parciales que caracterizan las uniones simbióticas entre el paciente psicótico y sus familiares.

El campo psicológico resultante de la unión de varias familias es un mayor continente para la movilización de las intensas ansiedades que caracterizan al proceso terapéutico de dichos pacientes.

En la conducción trabaja con un pensamiento psicoanalítico sin centrarse especialmente en la interpretación de la fantasía inconsciente y de la transferencia, sino más bien en el análisis de los comportamientos y de las relaciones interpersonales trabajando sistemáticamente en la confrontación entre fantasía in-

consciente y realidad, entre relaciones objetos internos y objetos externos. El trabajo de elaboración es principalmente una construcción compartida de elaboraciones interpretativas con los participantes, pudiéndose incluir, en momentos oportunos técnicos de dramatización-

ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA DE LA TERAPIA FAMILIAR CON PACIENTES PSICÓTICOS.

Dr. Alfredo A. Canevaro Clínica Psiquiátrica O'Higgins 2328 Bs. As. Arg.

A partir de la experiencia con grupos familiares con algún miembro psicótico, o gravemente perturbado, dentro del marco de una comunidad terapéutica psicoanalítica, el autor enumera una serie de hechos clínicos observados a lo largo del proceso terapéutico de esas familias.

Diferencia luego dos situaciones potencialmente terapéuticas, en tanto se les pueda dar sentido y convertir el estereotipo patológico en un camino de crecimiento emocional y maduración, que son **regladas o sistemáticas y fuera del encuadre formal o asistemáticas**.

Estudia finalmente los procesos de transferencia y contratransferencia que se dan en un tratamiento grupal familiar y los diferencia en:

TRANSFERENCIA

1) Individual

- a) hacia los miembros del grupo
- b) hacia el grupo "en sí mismo"
- c) hacia el terapeuta o equipo tratante
- d) hacia la institución

2) del grupo en sí mismo

- a) hacia los miembros del grupo
- b) hacia el terapeuta o equipo tratante
- c) hacia la institución

CONTRATRANSFERENCIA

- a) transferencia del terapeuta hacia los grupos familiares en general
- b) Respuesta emocional a la transferencia familiar
- c) Contratransferencia institucional

Traducción de
**E. ANTONIETTO y
C. DOYHAMBEHRE**

INDICACIONES SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE ENVÍEN COMO COLABORACIONES

Aquellos trabajos originales o comunicaciones sobre Congresos conferencias y seminarios que traten sobre el tema específico de la terapia familiar, deben ser enviados a:

Alfredo A. Canevaro, O'Higgins 2328, Capital Federal (1420) - República Argentina.

Las colaboraciones deberán ser originales y enviadas en dos (2) copias mecanografiadas a doble espacio, con un resumen final.

La propiedad literaria de los artículos enviados pertenecen a la revista, y ésta se reserva todos los derechos de reproducción y publicación.

FICHA DE SUSCRIPCION

Sres. Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección:

Código Postal Localidad

Profesión:

castellano ☐

Deseo recibir la Edición en:

inglés ☐

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Alberto Cattán, No a la Orden. por \$.....1

Alberti 1862, Capital Federal (1247). R. Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL

Argentina u\$s. 15 (*)

Exterior u\$s 17

(*) Dada la variación de costos, el precio de la suscripción corresponde a su equivalente en pesos, de acuerdo a la cotización del día del Banco de la Nación Argentina.

FICHA DE SUSCRIPCION

Sres. Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección:

Código Postal Localidad

Profesión:

castellano ☐

Deseo recibir la Edición en:

inglés ☐

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Alberto Cattán, No a la Orden, por \$.....1

Alberti 1862, Capital Federal (1247). R. Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL

Argentina u\$s. 15 (*)

Exterior u\$s 17

(*) Dada la variación de costos, el precio de la suscripción corresponde a su equivalente en pesos, de acuerdo a la cotización del día del Banco de la Nación Argentina.